

郭贞卿



郭贞卿医论医话集

郭贞卿 编著

于仲制、袁乃、推拿、外科、药物、
辩证论、点穴、为绝。临证常内
病、痛、疾、有丰富经验。临证七十余年，救
人无数。她晚年所创立的郭氏延年益寿法，在学
术界引起过较大影响。



学苑出版社

自序

余四川威远人也。生于国医世家，吾祖吾父，皆谙此道，为邑中名医。自幼受其熏陶，嗜爱中医。学文之余，间亦为父抄写中医典籍，口诵心记，渐有所悟，而又得家父时时点拨，故年未及笄，遂初入国医之门矣。后虽入学攻它，亦未尝废辍此好。二十岁，毕业于成都淑行女师，投身教育，亦兼行诊务。后以求诊者甚众，力不暇给，方弃教从医，专攻此术，且医且学，日趋进矣。

一九三六年春，因痛感旧社会之腐败，欲废除祖国医学。是时，虽年逾不惑，乃不顾家庭累赘，求学于四川国医学院，从事理论之研讨，得学院良师李斯炽、邓绍先等前辈之器重，给余精心指导。或赠贻讲义，或面询解惑，或课余抄诵医案，或携余随师应诊。间有疑难怪症，吾师嘱试诊回报，然后复诊，正余错讹。凡师之所教，余皆倾侧以听，不敢稍怠。师常诲曰：不胶于古，不谬于古，博采众长。余至今仍引以为训。数十年来，白日细心临证，夜晚挑灯读书，据经以洞病理，验案而悟经义，自感其乐无穷。

解放以后，党的中医政策昭示于天下，海内同仁，莫不深受鼓舞，竞献所长，为挖掘祖国医学宝藏殚精竭智。余亦深感多年积累，报国有门，乃将一己之见，陆续整理成文，献诸国内中医期刊，累以时日，遂成卷轴。

余今年八十有九，蹶足医界已六十有奇。自度所得，虽属浅陋，中有父兄师友心血之结晶，值此祖国“四化”建设猛进之日，敢不进献荃莛而令其随墟而失哉？是以辑录此册，赧颜问世，或可有益于后学，倘不负此，余愿足矣。

目前，中医门诊和病房在诊断论治上，都存在有不同程度重西轻中，重药用轻医理之倾向。余意，忽视中医本身诊断知识之继承、整理和提高，会使临床眼界狭小，有碍中医理法方药之贯通和发展；而重方药，轻医理，必将使中药之有效应用范围越来越窄，疗效也会随之受到限制和影响。有感于此，故辑册为《郭贞卿医论集》。

本书在具体编选集纳过程中，承游仲文君相助，在此致以深切谢意。

文稿由小孙张斯特、孙女张斯杰协助整理。欣见后辈能勤奋好学，后继有人，暮年可慰。

仅以本书献给祖国青年中医工作者。

郭 贞 卿

一九八一年识于梓潼

目 录

第一部分 辨证	1
八辨四落实.....	1
瘀血的病机诊断.....	13
第二部分 论治	21
论治管见.....	21
浅谈扶正.....	38
针刺四逢穴在儿科的运用点滴.....	47
咳嗽论治.....	54
论温胆汤与滋阴、补气法之配伍.....	63
浅谈以神和以药养胎.....	70
肝气肝阳虚的理法方药.....	76
第三部分 治则	90
涩法刍议.....	90
下法运用点滴.....	96
热因热用举隅.....	108
甘温除热法使用我见.....	120
第四部分 方剂	125
傅山宣郁通经汤.....	125
薛生白仿吴又可三甲散.....	129

当归贝母苦参丸·····	112
经验方二十首·····	147
第五部分 探讨 ·····	164
瘀血证必须广开治路·····	164
略论见瘀休治瘀·····	171
行血、生血和摄血之气的探讨·····	179
津血同源对瘀血证治疗的意义·····	190
略论叶桂络病的病理实质是瘀水互患·····	196

第一部分 辨 证

八辨四落实

我早年宗张景岳“两纲六变”和徐灵胎“两纲六要”之说，中年信奉喻嘉言医律十二条。但由于在临床辨证中，不论是用八纲、六经、三焦、卫气营血、脏腑、气血、病因等辨证方法去进行辨证，都必须结合地方、时令，以及病人的体质、年龄、性别、职业、精神等情况，进行具体分析和归纳，方能较为准确地制定治疗法则，因而感到张、徐、喻氏之说均不能很好地概括和驾驭以上各法。经长期反复探索、推敲、验证，拟定出临床辨证的八个辨别和四个落实，以求能较好地概括和统一以上诸法及各点。近三十年来，我体会到这“八辨四落实”能较好地概括和驾驭中医的各种辨证方法，从而提高临床辨证论治的水平。因此，不揣浅陋，简述于下，望能成为引玉之砖，对中医辨证方法理论研究有所补益。

一、八 辨

辨，就是运用中医的理法，对病人复杂的症状以及天人相应

的诸种关系等进行分析，以探求疾病的性质及其干扰影响疾病发生、发展的各种因素。我把它们分为八个方面，故称为八辨。

1. 辨 部 位

我认为八纲的表里二字，是不足以概括中医所讲的一切病变部位。伤寒有六经，温病有三焦和卫气营血，内伤杂病有脏腑气血经络，这些都是指的病变部位，仅用表里二字去统率他们，则概括性不强，所以，不如将“表里”换为“部位”二字为妥。中医所谓的病位，决不能单纯当作某个具体的解剖部位来理解，实质上乃是指病变的不同类型而言。这部位既指人体的一定具体解剖部位，更指疾病过程中具有共同病理基础的一定症候群，因而部位不同，性质也不同，治疗的措施就不同。外感内伤，邪正相争，阴阳失调，都必然会表现在人体的一定部位。要判断病变的部位何在，可根据六经、三焦、卫气营血、脏腑气血经络的各自辨证规律和特点去进行推演归纳。各种疾病无论是外感或内伤，都可以通用上述辨证方法去进行部位的辨别。前人讲六经辨证，不独为外感伤寒而设，就是这个意思。同样，脏腑气血经络、病因、卫气营血辨证的方法，也并非纯为内伤杂病和外感温病所独用，各人可以根据自己运用的熟练程度去加以选择。由于各种辨证方法的基本病机变化是脏腑气血的功能失常，所以，不管用哪一种方法去进行辨证，最终都必然要落实到具体的脏腑气血这些部位上。故尔我临床辨证之部位，是以脏腑气血为主，首先根据症状表现去判断在何脏腑，然后再分别在气还是在血。中医以五脏为人体中心，六腑与五脏相表里，通过经络去联缀全身。因此，抓住脏腑就抓住了根本，而脏腑病变非气即血，气之渐加为阳，血之深入为阴。综上所述，我认为将辨部位落实到脏腑气血，实是一种执简驭繁的捷径。

2. 辨 病 邪

病是指病名，邪是指邪气，病邪二字含义有所区别。中医病之种类不同，治疗总原则亦不同，中医的病名实质上是前人对辨证求本结果的总结，辨病也是指导中医进行论治的重要环节。是伤寒？还是温病？是泄泻？还是滞下？是积聚？还是痈肿？是疮疽？还是岩瘤？辨证不明，治难中肯。尽管中西医对病这个概念的认识在理论上的立足点有所不同，但对于病的含义都是包括有起病原因，有发病机理，有发展过程，一句话，有规律可循，有预后可测，有一定的治疗原则可遵，有若干专方专药或优选方药可供选择。因此，不辨明属于何病，就无法明了全部病理以及发展趋势，立法就会欠缺原则性。今天见到气虚补气，明天见到血虚又补血，后天见到热毒又清解，这样的治疗，辨证再清楚，从本质上讲，也仍然不过是一种被动的应付，有时难免和整个病机相违背，从而助纣为虐。另外，无可讳言，中医的辨病虽确有它的特色与独到之处，必须继承与发展，但是，由于受到历史条件、发展环境和观察方法的限制，对病的认识不及现代医学准确和深入，所以，临床上辨病要发扬中医望、闻、问、切的特有诊法，并吸取西医辨病之长以参照，取西医诊断方法及对病因、病机、病程、发展和预后的认识，这对于总结和发展中医辨病水平，具有十分重要的意义。

病邪之辨，大体不越十二种，即风、寒、暑、湿、燥、火、痰、饮、瘀、食、虫、毒。中医之病邪的实际意义，还不仅在于说明病因，更重要的是根据它们在临床上各自的特殊表现，借以概括临床症状，区别症候类型，确定治疗原则，从而作为临床辨证施治的根据之一。因此，病因辨证就成为中医的一种辨证方法。另外，须要加以强调的是，除暑以外的十一种邪气，内伤外感都

可以产生，其产生的途径不同，治疗原则从根本上讲也是不相同的。以食积来说，暴饮暴食之积与脾胃虚弱之积，虽皆同为食积，但在治疗侧重点上，却有消补之分，失之毫厘则谬之千里。

3. 辨 寒 热

寒热之辨发生错误，就尤如用油救火，饮冰散寒一样，后果可想而知。一般而言，病邪的寒热属性决定着病症的寒热，但体质的禀赋和邪正消长的情况，也影响着病症外在的寒热表现。伤寒可以化热而出现多种热的证型，温病可以化寒而出现多种寒的证型。所以，症之寒热，不单以病因（病邪）之寒热特性为唯一机转。寒热在内外的表现，是邪正斗争过程中，人体内阴阳失调的具体情况，在邪气参与下发生的复杂变化，忽视其中任何因素的作用，都会使寒热的辨证发生不同程度的错误。我认为辨寒热而不被假象所迷惑，必须注意三点：一、病邪的寒热属性；二、禀赋体质情况；三、正邪消长情况。若善于将此三者综合权衡，则可少出差错。举例说明之：有林××，男孩，平素面色晄白，禀赋阳气不足。患肺炎，经注射青霉素、链霉素，及服清热解毒、宣肺平喘中药，高热得到控制，咳喘减轻。这时，左下肢承山穴处长一小疮，漫肿如棋子大，疼痛，坚实，略红，神萎疲乏，汗多，脉细略数，舌苔腻而微黄，口不渴。我认为此患儿面白，须顾其阳气，用清解药到十分之六七，即不可过于寒凉，过于寒凉则寒凝经络，故而出现此症。疏方阳活二陈汤加杏仁、前胡，小制其剂，并针刺包块，留针二十分钟，针后加灸；仍注射青霉素、链霉素。三日后即愈。这类寒热相差悬殊，转变迅速的情况，大多数都是由于体质的内在情况特殊性引起的，再加上治疗时未周密地考虑到这些情况，就更促成了这些转变的产生。但是，纵是此等病候，也要注意针对病因（病邪）进行治疗，所以该例抗菌

素未曾停用，这就是临床上寒热并用，攻补兼施等治则有广阔用场的根本原因，也是辨病邪对临床指导价值之所在。这点医者要加以注意，不能忽视，否则跟着证型跑，随证施治，胸无远见，忽视辨病邪的价值，与头痛医头，足痛医足的作法，并无本质差异。本例若忽视温邪为患，不用已经发生效果的抗菌素，难免有死灰复燃之虞。如未用西药，我常在方中配伍清解散结药物，如重楼、白花蛇舌草、半枝莲等，这种温清并用，与中西药同用的理论根据是完全一致的。这些情况，在临床上⁶是常能遇到的。

4. 辨 虚 实

勿犯虚虚实实这句话之所以脍炙人口，就是在于它强调了辨虚实的重要性，虚补实泻，辨证失之，流弊大矣。辨邪气之实，当辨实邪为何？是风寒暑湿燥火？还是痰饮虫食毒瘀？邪之性质不同，泻的方药也就不同，张冠李戴地泻邪，轻则无异于隔靴搔痒，重则常会为虎作伥。辨虚也要弄清楚虚在何处，是津液？气血？还是阴阳？在何脏腑？否则泛泛论补，诸补杂进，只会增加人参杀人无罪的悲剧罢了。只有弄清楚了这些细节，虚实补泻才会有的放矢，才会使中医辨证论治的光彩在临床中闪耀出来。除此以外，更要注意辨清虚实之间的因果关系，是由虚引起实，还是由实而导致虚，都当明察秋毫，虽然虚实互见则补泻兼施，但因果关系不同，就直接影响到总的治疗计划和原则。如内痈、外疽、泄下、癆瘵、黄疸等等，实邪仍存，虚象已露，这些由实及虚者，侧重点仍在治实，补虚为支持协助泻实，因为从因果关系上看，邪实不除，正虚终究难复，这并不是否认补虚的重要性，而是说实邪未去，把侧重点放在补正上，把正虚当作主要的治疗目标，就难免有扬汤止沸之误。同样，因虚而导致邪实的病证，补虚应该是治疗的根本大法，泻实为补虚服务，比如痰饮病就是这

样，临床实践已经证明，对痰饮病急则治其标实，缓则补其本虚，发作时则泻肺痰，平时则调补脾肾，能收到较为满意的长远效果。因此，辨虚实应该强调四点：一、实者为何？二、虚者为何？三、虚实之间何为标本？四、虚实之间比例如何？这是辨虚实的主要环节。

5. 辨 体 质

体质的情况，对疾病发生、发展以及治疗有着重要的影响，不可不辨。张景岳说：“当识因人因证之辨，盖人者本也，证者标也，证随人见，成败所由，故当以因人为先，因证次之。若形气本实，则始终皆可治标，若形气原虚，则开始便当顾本。”叶天士说：“吾吴湿邪害人最广，如面色白者，须要顾其阳气，湿胜则阳微也，法应清凉，然到十分之六七，即不可过于寒凉，恐成功反弃，何以故耶？湿热一去，阳亦衰微也；面色苍者，须要顾其津液，清凉到十分之六七，往往热减身寒者，不可就云虚寒，而投补剂，恐炉烟虽熄，灰中有火也，须细察精详，方少少与之，慎不可直率而往也。”《伤寒论》中指出淋家、疮家、衄家、出血家等都不可发汗，就是因为这些人的体质已异于常人，即使感受外邪，治则也当别论。以解表而言，前人有滋阴解表、助阳解表、温中解表等等不同治则，这些行之有效的治则，就是针对病人不同体质情况而制定的。另外，同样的病邪侵入不同的人体，往往随着病人体质不同而发生转化，其中阳热之体感受阴寒之邪，或阴寒之体感受阳热之邪，邪气顺从体质而转化的现象就尤其明显。薛生白在《湿热病篇》中谈到：“湿热证属阳明太阴经者居多，中气实则病在阳明，中气虚则病在太阴。”病邪在人体中的传化过程，也能明显地看到体质的重要性，外邪不经过表证阶段而径直入里的“直中”就是明显的例子。“温邪上受，首先犯肺，逆传心

胞，”为什么会逆传心胞？从临床实际来看，凡是心气不足、心阴不足或湿邪太盛，往往容易出现急骤险恶的逆传心包重症。另外，个体差异对药物的耐受性也是不相同的，前人之所以提出老年人与青少年、儿童各有不同的用药注意事项，妇人经带胎产各有其宜禁，这些都是鉴于体质情况不同而有区别的缘故。临床上有相同类型的腑实证，有用大黄 10 克，即泻下不已，也有用至 30 克，方才致下；有用桂枝 10 克，即有出血倾向，有用至 30 克，稍止痛痹。如此等等，不胜枚举，都与体质所致有关，临证要注意询查，对指导辨证论治补益不小。

6. 辨气候、环境

人生存在有四季变化的自然界中，四季的风雨阴晴，都会影响到人体的生理功能和病理变化。故前人有言，善言天者，必有验于人。近年来，气象医学和生物钟学说的崛起，更说明了天人相应的观点已引起了人们的极大注意。因此，与之相应的，临床证明有指导价值的经验，也应当给予收集、整理、发掘，以便为进一步阐明、发展、完善这个学说提供更多的素材和资料。我认为，冬天万物凋谢，鸡都要少下蛋，秋天动物脱毛，树木落叶，人的脉象春浮、夏洪、秋毛、冬石，都与自然界四季生长收藏息息相关，不曾例外。张景岳说：“读运气者，当知天道有是理，不当日理必如是也。”因此，我主张辨气候要识当令之邪，又要辨兼挟之气，把这二者结合起来，去审查病机，灵活地贯彻《内经》“必先岁气，毋伐天和”的医疗观点。比如盛夏雨水较旺，则暑常挟湿；倘若是伏旱却难以挟湿，暑风暑燥则多矣。但知此也只能算对了一半，百花争春，梅却敢对严寒，晚香玉偏在夜里开放，人类更是在自动地适应和能动地改造自然界的斗争中，维持其机体的生命活动，因此，更需要注意总结自然地理环境和人为改变的生活环

境对人体影响的规律。“人间四月芬芳尽，山寺桃花始盛开，”自然界地势对气候的这类影响，往往被人类加以利用和仿造，工业发展和科学试验又越来越干扰和改变自然气候，这些因素如不加以考虑，就会刻舟求剑或指鹿为马。仍以暑天而言，随着人们生活水平的提高，工作条件的改善，在享受清凉饮料、冰糕，以及电风扇等降温设备时，只顾一时之快，恣意贪凉，夏月伤于寒湿的病人也就增多了。冬天烤火，室温增高，外出又受风寒，则寒闭于外，热郁于中的诸种证型也有上升的趋势。试问，如果不把人类对自然和环境能动改造并加以利用的因素加以综合分析，我们就不能够正确地运用四时六气理论去有效地指导临床实践。职业亦是辨环境的一个重要因素，除了职业病外，各种不同的职业都有各自不同的工作和生活环境，临证了解职业情况，对治疗亦颇有参考价值。因此，我反对脱离病人生活环境条件的客观实际，假借运气，死搬五行生克和客主加临去推衍病因以指导临床的作法。要能较好地识别气候环境对疾病的影响，我体会到必须注意三点：一、把当令之邪和兼挟之气结合起来权衡；二、了解病人的生活、工作条件和环境情况；三、病人的住地（是依山还是靠水，是向阳还是背阴，是潮湿还是干燥等等）以及新近是否外出？所到之处气候、水土情况如何。若能将三者结合分析，自然能辨别清楚，较好地运用四时六气等天人相应的理论，提高临床辨证论治水平。

7. 辨 心 境

心境包括个性、情绪等精神状况，有生理性的，也有病理性的，这些都能成为决定疾病变化的内在根据之一。情志刺激，能导致阴阳失调、气血紊乱和脏器失衡的例子，在临床和生活中都屡见不鲜。前人有见于此，故非常重视精神状态，把神作为人生

三宝之一，在摄生治病中，都极其强调对神的调整。李时珍说：

“盖人心如面，各各不同，惟其心不同，脏腑亦异，欲以一药通治众人之病，其可得乎？”徐灵胎也说过：“天下有同此一病，而治此则效，治彼则无效，且不惟无效，而反其大害者，何也？”其中心境的“忧乐劳逸”之别，乃是引起这种后果的内在原因之一。中医列郁证一门，就是研究由情志拂郁所导致多种疾病的病理机制及治疗原则。对于有精神因素影响的疾病，历代医家都认为使病人思想开朗、心情舒畅和精神愉快，有助于疗效的提高。若不移情更性，则药餌难疗之类的话，在前辈名家医案中随处可见。身心兼顾，形神共调，是祖国医学摄生与防病的特点之一。“精神内守，病安从来”，就是关于这个特点的一句名言。我常常对有些病人说：“你们那么迷信药物功用，梁山伯、林黛玉的病单是用药能治好么？妙药难医嘛。川剧《御河桥》中宣登鳌的病，还不是‘云开雾散见宝珠’以后才好了的，心病不能单靠药治。”那些身受迫害而致的思郁、忧郁、怒郁的病人，药物只能减轻其症状，根治还是具体问题逐步得到解决以后。

我认为，对于那些很难用客观曲线、图象、数据、指征等加以确定，而往往只能靠主观感觉加以描述的疾病和症状，在总结疗效时，一定要把精神因素加进去通盘考虑，不然很容易做出错误的结论。不少所谓疗效卓著的方药，之所以并不如所言之神，其中原因之一，就是没有注意认真分析病人的思想意识，没有排除病家对医者的信任心理和迎合心理等因素所导致的误差，结果以假当真了。

8. 辨 习 惯

人的生活习惯各有不同。单以饮食而论，有饮茶嗜好，有烟酒习癖；有爱吃辣，有喜欢酸；有近膏粱厚味远清淡，又有善清

淡而恶油腻；有偏喜海味者，又有见之则恶心者；有偏爱山珍者，又有嗅之则反胃者。生活千差，习惯万别，不可一概而论。这些不同的生活习惯，对某些症状的出现具有支配的意义，因而对治疗也有一定的启示。我曾未注意病者生活习惯，书与人中白，病人闻之则干呕，给病人处以淡菜总无法下咽，给病人拟以血余炭，视之就汗出……，这样一来，药物不能入胃，作用又从何而发生呢？为此，就必须了解病人的习惯，或改换它药，或改变剂型，或谎称为它药，以图能入胃。

有的人患小病，就心里紧张，专靠药物治疗，不注意生活摄养；在无病之时，也常常乱服药防病，这些人希图药饵延年，与历史上欲金石长寿者是同做一梦，欲望免病却反伐天真，而且一到病重时，往往内外交困，医者治病，于此得不辨乎？坏的生活习惯，是引起疾病的重要原因，不加以改正，则疾病难以除去。有一人家，平均每月皆有一至二人生病，我往其家中看望，方知夏天亦紧闭门窗，床下亦堆满东西，室内有霉湿之味，于是嘱其改变这种生活习惯，经常开门敞窗，搬走床下东西，让空气流通，日光常照，后来病即由少到罕。倘不辨习惯，方药再切中病机，家中轮流生病的情况，仍将继续下去。辨习惯对临床的指导意义，还在于可以利用习惯，去因势利导地帮助治病。如能食辛辣者，感冒风寒可用姜汤发汗；平时常经风雨之人，发表能少后顾，稍峻无妨碍；口粗胃强之人得病，重剂可用……。综上所述，辨习惯对治病来说，有这样几种意义：一、可以避免给予病人生活习惯相违背的方药和治法，从而减少或杜绝增加病人的痛苦及意外的变化；二、可以根据或利用病人的生活习惯，来协助制定治疗方案，使方药发挥更大的效能；三、可以帮助病人发扬优良的习惯，改变不良的习惯，这对于防病治病，促进身体健康，有着重

要的作用；四、了解生活习惯，有助于诊断，如饮食生冷，可伤脾胃，而致虚寒诸症，或伤肺，而见咳嗽喘息；经常饮酒者，可患酒湿症，而致腿骨疼；多吃肥甘或甜食，既会生痰生湿，又会动风；喜食辛辣者，则会伤肝动火；偏食者，易导致营养缺乏等。这些对诊断均有很重要的参考价值。

二、四 落 实

不同的病，有不同的发生和发展规律。但是，由于病人体质、精神情况、生活习惯和工作环境等不同，又会影响到疾病的发展，出现各自不同的特点。八辨是分析，是辨证、辨病，四落实是综合，就是将八辨的所得进一步地综合为一线贯通的理法方药，使辨证(病)施治更加缜密，以期收到更好的疗效。四落实是落实：

(1) 整个病情发展的规律和特点（整个病情发展的规律，是指不同疾病的具体发展规律。由于体质、心境、气候环境等因素的影响，则又可在不同病人的身上展现出不同的特点）；

(2) 目前主要应当解决的症结点；

(3) 总的和目前的治则（总治则根据第一条制定，目前治则根据第二条制定）；

(4) 选方遣药需要注意的地方。

现举一例来说明八辨四落实的临床运用。

何××，女，87岁，1978年11月15日。病员十余日前因受凉而头昏头痛，打喷嚏，流清涕，形寒恶风，不慎跌倒后，又呕吐几次。近几天气候突变，冬雨纷纷，即卧床不起，一身酸楚疼痛，手足冷，脉沉，舌苔薄白，14日用真武汤合二陈汤。今日重衾厚被，不时以手按头，不能言语，扳动头颈有痛苦表情，四肢发凉，两颧发红，双目冷冽，手足时躁动，合目时呢喃掷声及有撮空引线等现象，二便自遗，脉浮大，舌质胖嫩，苔白略腻。

1. 八 辨

(1) 部位：表里俱病，太阳风寒未去故有头痛（不时以手按头，扳动头颈有痛苦表情等），少阴阳气衰微而上浮，故见躁动两颧发红。

(2) 病邪：此病正喻嘉言所谓伤风亦有戴阳症是也，邪气为风寒挟湿。

(3) 寒热：真寒假热，真寒乃少阴阳微，太阳风寒挟湿，假热者乃少阴阳气上浮。

(4) 虚实：虚为少阴虚，实为太阳风寒挟湿。

(5) 体质：高年之人气血两衰，真阳不固。

(6) 气候、环境：寒潮来临，气温骤降，风雨连日，从所现症状来看，不仅原有伤风症状加重，更表现出挟湿现象。

(7) 心境：家庭和睦，精神愉快。

(8) 习惯：无烟酒等嗜好，平素活动比较均匀。

2. 四 落 实

(1) 此为—普通感冒，非时行伤风，整个病情特点是高年伤风，正虚邪实，孤阳上浮。

(2) 目前主要的症结点，是伤风与戴阳的症状同时出现。

(3) 因此，总的治疗原则，当从扶正着手以驱邪，高年体虚伤风，固然不能一味解表驱邪，这样无异于开门揖盗，但也不能单纯扶正而无视病邪的性质和兼挟，善治之法应当两相兼顾，从扶正以祛邪为立足点。邪去正安后，培补正气以善后。根据当时天气变化，空气湿润，舌苔略白腻，头颈转动困难，具体治则在回阳救逆方中参伍驱风除湿。

(4) 因为高年体虚要取轻可去实之意，补不可蛮，攻不可重。而舌苔白腻，颧红，故可用回阳燥热之附子剂。

处方：羌活 6 克 防风 45 克 苍术 6 克 陈皮 6 克 枳壳 6 克 葛根 6 克 党参 12 克 附片 12 克（先煎） 生龙骨 15 克 生牡蛎 15 克（先煎）

16 日，病员即神清厥回，能食半碗稀粥，后用陈夏六君子汤善后，半月康复。

书后附一歌，以便于记忆：

一辨部位二病邪，
虚实更当辨寒热，
体质气候与环境，
心境习惯不能缺。
落实病情规律特，（特即特点）
目前解决之症结，
长远当前治则何？
方药还需反复核。

瘀血的病机诊断

目前临床上使用活血祛瘀法，一般主要是依据瘀血症状的有无去决定。但是，这个方法又往往是很不可靠的，因为有瘀之症，并不等于一定要用活血祛瘀法，比如汪机就谈到，指甲色黑是“血瘀”，认为“血活则红，血凝则黑”，但治疗却主张用补气药治之，如人参等。临床上也确常常遇到明明有瘀血症状，使用活血祛瘀法却收不到希望的疗效。这都说明，囿于症状，是有很大的局限性。

要能很好地运用活血祛瘀法，还必须通过症状去再找途径。我的体会是，除了注意症状外，还应当深入到病理机制中去分析营血运行的具体情况，这样才能更好地指导活血祛瘀法的使用。兹分三个方面来谈谈我的体会和认识：

一、各种出血

大部分医书都说，典型的瘀血症状，是出血有血块，且血色紫暗。但从病机上看，无论有无典型症状，只要出血，都存在着一个如何正确地、不失机宜地处理好瘀血的问题。这是因为只要出血，就有留瘀，诚如唐容川在《血证论》中强调指出，在吐衄便漏中其血无不离经，凡离开经脉而未排出体外的营血也仍然是瘀血，瘀血不行，则新血断无生理，因而“治血者，不去瘀血而求补血，何异于治疮者，不化腐而求生肌哉。”（《男女异同论》）另外，凡血证必然是经络损伤的表现，这种损伤在恢复过程中，必然会造成损伤经络内的营血运行瘀滞。这种离经和在经的瘀血，都是血症的必然的产物。如果在治疗各种出血症时，再不究根源，不注意顾及营血的生理特点，又很容易产生新的和加重原有的瘀血。除专事滋补、一味止涩、过用寒凉外，诸如寒者本应热之，而热之过度，塞者自当通之，而通之有余，如此等等，虚虚实实，太过不及的错误治法，都会成为引起或加重瘀血的原因。因此，在各种出血症的治疗中，均要从两个方面去防治瘀血，以利于机体恢复：一是止血时要注意不要引起留瘀；二是要注意消除瘀血，以利于化生新血。这就是说，各种出血症，不论有无典型的瘀血症状，从病机上看，都存在着一个正确对待瘀血的防治问题，需要针对具体的情况，灵活地加以解决，以免由此而造成后患。唐

容川把消瘀做为治疗出血证的重要法则之一，他认为：活血是本，止血是标，大出血时补气固脱，维持生命，止血是次要的；不化瘀血将会使病情复杂化，衍成痼疾；离经之血即是瘀血，瘀血不去，则新血断无生理。故对出血症唐氏提出“止血、消瘀、宁血、补血”四个步骤，这与明代缪仲淳治血三法中“宜行血不宜止血”的观点是一致的，且认识更进了一步。

除了吐衄便漏等出血证外，手术、外伤、经产等也都会不同程度地直接损伤经脉，引起营血离经的现象。因此，我把这四种情况都归属于各种出血证的范围内。它们即使在正常和顺利的情况下，也存在着一个正确防治瘀血的问题。在这之后，如果出现某些病症，也多与瘀血密切相关。我个人临床体会，主要有以下几个特征：

1. 四种情况之后，出现不容易理解和异常的症状，应该考虑到有瘀血的可能。这样的症状，在前人和今人的书中，都有颇多的记载。古往今来，均有瘀多怪病的说法。证之临床，诚非立异之谈，实能有助于指导临床实践。

2. 四种情况之后，出现了比较局限、恒定的疼痛、酸楚、麻木等不适的感觉，都与瘀血有关。

正常的经产和成功的手术，也是不同程度地直接损伤了经脉，因此，一旦受到了其他原因（如六淫、七情等）的影响，也往往会产生瘀血阻滞气机，造成肿痛及其他症候。因之，在四种情况之后，若出现局部比较恒定的疼痛或其他症状，更应考虑到有瘀血的可能。

3. 四种情况中，凡离经之血，应排出体外而未排出体外者，不论之后出现何种症候，均应考虑到与瘀血有关。

在妇产科中，经来或突断，经闭，产后恶露不下，或恶露未

尽，均属瘀血为祟，常常导致多种多样的病证，古今医案医话对此记载颇多。只要我们不局限在经产范围内，就可以受到若干启发，比如外伤、咯血、吐血等，瘀血未排除，也同样会产生多种多样的症候。正如唐容川在《血证论·吐血》中所说那样：“其离经而未吐出者，是为瘀血，既与好血不相合，反与好血不相侏，或壅而成热，或变而作癆，或结痼，或刺痛，日久变化，未可预料。”另外外伤的血肿，体内外包块中的血瘤，这些都是明显地由该排出体外之血而未排除，潴留体内为患。对于这类瘀血的排除，中医往往从气机和气化的角度去解决这个问题，比如桃核承气汤证、抵挡汤（丸）证、下瘀血汤证、大黄蟅虫丸证、大黄牡丹汤证等，使用通腑法的目的，都是为了帮助潴留在体内的瘀血排除体外，而因势利导的方法。

4. 四种情况之中，或紧接着发生六淫外感，或七情内伤而出现了相应的疾病，均要在针对六淫、七情而出现的相应病症的治疗中，适当地配以活血祛瘀法。

前人和今人，赞同并实行这种观点者不是少数，只有两相兼顾，才能有助于新病的治疗。我在临床上，亦坚持这种观点。这里举两例验案来谈谈我的认识：

郭××，女，17岁，湿温十余日，胸痞闷，发热倦怠，呕恶，溲赤，汗出烦渴，舌苔灰白，舌质赤，曾用杏仁滑石汤、黄芩滑石汤、甘露消毒丹等，均无甚疗效。到我诊时，发现病员默然不欲言语，舌质红，舌苔略腻，询知病患于经来刚净之时，于是想到，“湿温瘀血闭心包，神识昏迷热似潮，默然不言能饮食，不知所苦药难疗，辛香宣利俱无效，醉地鳖虫不可抛。”乃书与薛生白仿吴又可三甲散，原方加滑石、甘草、豆卷，连服四剂，诸症遂愈。

1963年，曾治某妇，年近三旬，自诉两年前，经行时适逢瞋怒，遂致停经，少腹结癥疼痛，两胁不舒，善太息，面黄肌瘦，舌尖红，苔薄黄，脉弦。

方用逍遥散，方中加山梔仁、桃仁、红花、地鳖虫、蚕砂（炒），另用定坤丹，每夜睡前服三分之一丸。三月后，经行痛减，渐愈如初。治此案后，我曾反复想过，与其病成后费如此大的功夫长期服药，不如初病之时防微杜渐，早用活血化瘀法。再仔细观察、回忆，临床上此类病人不是少数。因此，陆续总结了一点体会，凡经来或刚净之时，无论外感、内伤，常选加益母草、香附，少加艾叶，以活血化瘀。在作计划生育的各种手术后，以及其他外伤、各种手术后，在正常的恢复过程中，一旦六淫所袭或七情所伤，都以参苏饮（人参、苏木、当归）相伍，能两相兼顾。这样未雨绸缪，确可免掉日后的不少麻烦。

二、长久、固定

《素问·痹论》指出：“病久入深，营卫之行涩，经络时疏，故不通。”这就是说，病久迁延时日，有导致瘀血的可能。清代叶天士认为，人身“经络皆统血”，并提出“初病气结在经，久则血伤入络”，及“久痛入络”的论述。从临床体会来说，除了“久痛入络”外，还有其他久咳、久肿、久痿、久痹、久黄疸、久怔忡等，均可因病程长久而血伤入络，因此，“久痛入络”仅仅是“久病入络”中的一个项目而已。在理解和运用前人“暴病在经，久病入络”一类经验时，我的体会是：病变长久，病位又固定，就很容易产生瘀血，须用活血化瘀法以治之。由于中医强调气血，病变所波及者非气即血，血病可以及气、气病可以及血、气血之间由于生理的密切，而表现为病理上的密切，但血病比气病更深一层，气病一久，很少不波及于营血的。完全可以这样地推理，既然“百病皆生于气”，那么，百病长久，固定地存在于人体，就很容易由气及血，形成气血皆病。的确，临床上有很多慢性疾病，如慢性肾炎、冠心病、慢性支气管炎、慢性肝炎、血卟啉病等，这些病

在中医学中往往归于腰痛、水肿、咳嗽、胸痛、胁痛、黄疸、腹痛等症，古往今来的文献中都曾记载着，这些病由于长久、固定地反复发作，从病机上看，就有瘀血存在的可能。而在今天，无论是中医、中西医结合，以及实验室的研究，都证实了活血祛瘀法在这些病症治疗中的重要性。

三、病变呈结聚状态

肿、瘤、岩、积、聚、癥、瘕、疔、疮、痈、疽、疹等，这些病症都有一个共同的特征，即都是呈结聚状态的表现，从中医理论上来说，很自然会联想到瘀血。但是，另外一些诸如此类的病症，是否也可以应用活血祛瘀法呢？我认为是完全可以的。《中医杂志》（1962年第6期）载“通经逐瘀汤治疗23例荨麻疹的初步报告”一文，报道效果良好。该文认为，荨麻疹病因虽多，“其病理基本环节在于风湿或风热，郁于皮毛腠理间，阻塞气机，肌表气血因而瘀滞致发本症。治疗当以疏通肌表气机，畅通气血为主，通经逐瘀汤以皂刺、地龙等通经络舒畅肌表气机，以赤芍、桃仁、红花活血逐瘀，并以连翘、银花解其邪毒，加入香附调和气血。目前临床一般习用消风散，其方效主在消风止痒散风湿，而其通经逐瘀之力则略逊。”此即按病机分析，去进行诊断，以指导活血祛瘀法的使用，结果比较令人满意。临床上，我就持此种观点，并由此而推至麻疹、风疹、疮疡、水痘、紫癜、瘰癧等等。的确，也有不少古今文献曾论述过这些病症的病机为血分蕴毒，因此，活血与解毒、祛瘀等法相配伍，本是正理。至于急慢性扁桃体炎、咽炎、鼻炎、舌溃疡、小儿鹅口疮等，我亦以病变呈结聚状而分别配伍活血祛瘀法，均有积极的治疗作用，看来不应当忽

视。总之，只要病变呈结聚状态，皆会有一定程度的气机闭塞，从而造成相应的血行不畅，这在中医理论上是很容易理解的，因而应用活血祛瘀法则去治疗，也是理所当然的事情。

以上三条，皆为有瘀之兆，不论表里、寒热、上下、内伤、外感、男妇、长幼，不论有无瘀血症状出现，皆要注意配用活血祛瘀法。一般来说，这样做确比根据是否有瘀血症状而使用活血祛瘀法更为准确、实用，且能防患未然和防微杜渐。

以上是从病机上去判断瘀血的存在、发展，并指导活血祛瘀法使用的认识和体会，由于近年来对活血祛瘀法的使用比较注重症状的诊断，很少论及病机的探讨，故书之出来，望能质之高明。

附：分析以往用药来指导 活血祛瘀法的使用

《金匱要略》治疗产后腹痛，先用枳实芍药散，服之无效是内有瘀血，用下瘀血汤。这种瘀血着于脐下腹痛之诊断是用药物试探后而成立的。

《医林改错》血府逐瘀汤所治证目载：

不眠：夜不能睡，用安神养血药治之不效者，此方若神。

心跳心慌：心跳心慌，用归脾安神等方不效，用此方百发百中。

头痛：查头痛者，无表证，无里证，无气虚、痰饮等证，忽好忽犯，百方无效，用此方一剂而愈。

总之，用其他药无效，再结合其他症状，即可诊断为血瘀，此类例子甚多，不能一一列举。这个矛盾是在诊断由于条件的局限时不可避免的，然而，如何去吸取教训，得到正确的诊断，却是一门学问，非要有坚实的理论知识和临床经验为基础不可。这种“诊断性治疗法”，颇为历代不少著名医学家所重视，并且积累了相当丰富的经验。我也深深地体会到，很多异常宝贵的经验和深沉的教训，都是从药物试探进行诊断这里面取得的，而不论这种试探

是有意还是无意地进行。这是一条从特殊到普遍必然经历的过程,这里会有丰富多彩的历程在等待着我们去认识、思索……。特别是在今天的实践过程中,必然会出现更多的新问题,这种诊断性治疗法的运用范围也必将扩大。因此,对这个方法应该给予认真对待,并努力加以总结和提高,是非常必要的。

第二部分 论 治

论 治 管 见

论治是依据辨证和辨病的结果，抓住疾病本质的病变趋势，采取相应的治疗措施。临床要能较好地进行论治，必须博览古今各家之方，深究古今名家遣方之精华，注重实践，细心验证。反复研究成功和失败的经验教训，方能逐渐灵活化裁成方，师而不泥。这样，临证治病才能富有胆识，有理有法，严谨有机，遣药精当，取得较好的疗效。以我多年的体会，深深地感到必须十分重视理、法、方、药的连贯性，因为辨证虽明，而析理不深，立法不严，组方浮泛，选药失当，仍可贻误病人。这里，就我对论治感受较深的地方，谈些体会。

一、用方当深究组方之理

学习方剂，要通达组方之理，才能用活方，创新方。组方之理，至少包括三个方面：一是治疗对象的病理和病机；二是立方的原则；三是用药的法度。一个好的方剂，起码的条件就是要切中治疗对象的病机，再进一步就应该是配伍严密，主辅佐使恰当，

治疗的方向明确，用药有绪，严谨不乱，要做到药味少而重点突出，药味多而不杂乱无章。前人所谓：“方从法定，以法统方”，就是说治疗法则，是从众多的治疗方药中总结出来的，带有规律性的东西，是指导治疗复杂多变疾病的大法和基本原则。做到了“以法疏方”以后，也不能说就一定能取得满意疗效，还必须熟悉用药法度，即药物的特点及配伍后的协同与拮抗等问题，这样才能较好地选好方、用活方，取得较好的疗效。辨证立法相同，而用药疗效不同，问题就往往在于配伍和选药之得当与不得当，即使方同量异，作用亦各不相同，古今医案此类情况甚多，可供参阅，而临床医生对这种现象，也都是各自有其深切的体会，值得反省。基于这些认识，我临床上除注意方与法之间的关系外，还非常重视收集民间单方、验方和同道们行之有效的自制方、祖传方，运用中医的基本理论去加以探讨，使之为我所用。所用的含义，除临床治病运用外更用来开拓自己的思路，打破旧有认识上所形成的障碍，从而获得新的体会和认识，以指导临床实践。总之，要能选好方、用活方、创新方，最重要的是通过临床实践，博采多家之长，多读书，多看能家临证，多记录，多思索，多对比，多付之实践验证。

二、择选药物要注意专能

药物的专能应当重视，对药物在不同剂量、剂型、炮制和配伍情况下能起的不同作用，都要注意探讨和了解，且愈多愈详愈好。理法好比兵法，而药物又好比武器，战争除了重视战略战术外，对武器的掌握亦很重要，而且武器的变化，往往还会引起战略战术的变化。我觉得，一个高明的医生，应该常常注意调整这

二者之间的关系，就能为中医的理法方药发展，做出一定的贡献。至于研究药物的专能，我的体会是，主要应当注意三个方面：

1. 单味药物的专能

单味药物的作用，常随产地、采取时节、剂量、剂型、炮制方法等不同，而有所侧重和变异。不妨以柴胡为例，来说明这些影响和关系，柴胡有南柴胡与北柴胡之分，其共性为舒肝解郁，疏邪退热，祛邪调经。其个性则南柴胡长于升阳散邪，疏肝解郁；北柴胡长于解热泄下，推陈致新。生品，多用于外感；炒制，能缓解发散作用。蜜制，润肺，止咳；酒制，升散，退热；醋制，增强舒肝活血及止痛作用；鳖血制，用于养阴，制疟。在使用的剂量上，重剂退热，中等剂量解郁舒肝，小剂量升举阳气。剂型的使用，对药物的专能，亦有相当的影响。比如，龙骨外用，主要能敛汗、生肌、止血，内服为收敛浮阳、安神重镇、平降肝阳，各有侧重。附子捣烂敷足心，可以引火下行，撤上部热盛之症，如鼻衄、咽痛、小儿流口水、口疮等，与内服有一定差异。另外，大黄欲泻下，当后入煎剂；欲止泻，可以久煮，芒硝需要兑入药汁溶化，阿胶烱化，肉桂焗服，旋复花布包煎等，无不影响药物专能的发挥。倘不细察及此，处方再好，也难免会有时因此而功亏一篑。

2. 药物配伍后的专能

药物经过配伍后，所能产生的作用，不是单味药物作用的简单堆加之总和，在经过配伍以后，药物性能和作用往往起了变化，且这种变化常是多方面的。就以麻黄来说，在麻黄汤、麻杏石甘汤、麻杏苁甘汤三方中，都以麻黄为主，辅以杏仁，佐以甘草。但一则配伍桂枝，为治表实无汗之太阳伤寒；一则配伍石膏，为治汗出发热而喘之方；一则配伍薏苡仁，就成为治疗风寒湿痹之方。三方

仅差一味药物，其治疗作用就全然有异，可见配伍后的药物专能值得努力探索和认真掌握。药物配伍后所能表现出来的作用，大致可以归纳为三个方面：（1）改变其本来的功效或取得另外的效果，如桂枝配白芍，以调和营卫；黄连配吴茱萸，以平肝制酸；干姜配五味，以温化痰饮等。（2）增强其本来的功效，收到更强的效果，如苍术配厚朴，以燥湿行气；木香配槟榔，以顺气化痰；黄柏配知母，以清下焦湿热。（3）减轻或消除毒性或副作用，如干姜配附子，能减轻附子毒性；砂仁伴熟地，能制熟地滋腻碍胃的副作用等。药物配伍后的专能，还常常受到剂量的影响，在配伍的方剂中，常可因一味药物剂量上的增减，整个处方的作用，就会向其他方面转化。以《伤寒》、《金匱》中的方剂来说，比如桂枝加桂汤，药味组成虽依然如旧，但由于一味药物剂量的增加，却变为治疗奔豚气从少腹上冲的方剂了。枳术汤、枳术丸都是枳、术的组合，前者枳倍于术，寓补于消，以消食导滞为主，后者术倍于枳，寓消于补，以健脾和中为主，一祛邪，一补脾，迥然不同。小承气汤、厚朴三物汤、厚朴大黄汤三方，也是药味相同，由于剂量不同，而治疗的病症亦不同。前辈名家对药物配伍后的专能，每有独到和精辟的见解，如喻嘉言谓虚人于解表药中加参，其效乃捷，而一般规律是表未解者，不可用补。王旭高说：“麻黄是开达肺气，不是发汗。”陆士谔说：“桑叶为肺家之肝药，枇杷叶为肝家之肺药，二味同用，大能清肝肺之热，降气通络止咳。”综上所述，如果我们熟悉了单味药物的专能后，不再进一步地掌握药物配伍后的专能变化情况，仍然不能比较恰当地选方遣药。

3. 药物作用同中之异

同，是指同类作用的药物，异，是指同类作用药物之间的差异，这种差异既包括单味，也包括配伍。掌握同中之异，就可以

减少处方中杂乱和叠床架屋的现象,从而使处方简洁有力。这样,不仅有利于提高疗效,总结经验,而且对于节约药材,减轻病人经济负担均具有积极的现实意义。

比如说,都是升提的药物:葛根善鼓舞胃中清气上行,以输津液;桔梗为舟楫之剂,能载药上行;升麻、柴胡能升阳举陷。

都是温肾的药物:

温散 { 附子: 回阳散寒, 行水止痛, 走而不守;
肉桂: 温阳达下, 能助气化;
淫羊藿: 补肾壮阳, 祛风除湿。

温补 { 巴戟天 { 刚药, 用于肾阳虚而便
仙茅 { 溲、舌胖、苔腻、体胖
补骨脂 { 等症。
肉苁蓉 { 柔药, 用于肾阳虚而便
锁阳 { 艰、舌疲、苔薄、体瘦
枸杞子 { 等症。

都是辛温开达的药物: 生姜、半夏降胃气; 吴茱萸、花椒泻肝浊; 桂枝辛温促动; 麝香香窜透络。另外, 如蔓荆子、桑叶、菊花皆能疏散风热, 治外风头痛。倘若对于肝风内动之头痛, 使用蔓荆子却并不对症, 此时纵有风热为患, 仍当以桑叶、菊花更为恰当。

羚羊角与犀角都同样能治热病发狂。但犀角以入心为主, 偏于凉血, 善治神昏; 羚羊角以入肝为主, 偏于熄风, 善治抽搐。

以上是用不同方式对药物同中之异探讨的举例。总之, 从上述三个方面去对药物了解得愈多、愈深、愈透, 就愈能提高临症处方对药物作用的选练功夫, 其好处自不待言。

三、不能忽视对治法的研究

我平素喜欢对中医种种具体治则（不论是常法还是变法）进行收集和研究，认为这是非常有意义的事情，并且于其中确也受益非浅。为什么疏肝常兼理脾胃？补血常须益气？何谓芳香化浊？何谓分消上下？酸甘化阴或苦辛通降的作用机制如何？如何使用？对诸如此类的问题进行研究，是会激发起研究者的无限兴趣。如果我们只掌握一般的治法，那么，在具体治疗时，一旦遇到了较为复杂的症候，往往会陷入五里雾中，感到治法不多，无从下手。比如见到虚证，虚则补之，但如何补才妥帖？需要从何着手？同时还需要顾及一些什么？要处理好这些问题，就必须对虚的成因、虚的程度，以及虚在整个病变中的机制和影响等关系，逐个得出确切的结论。做完这一步工作后，掌握治法的多少，就成为对治疗效果好坏、快慢有直接影响的重要因素。对这个问题，我的体会是，选方遣药的功夫，不一定能弥补治法上的错误和幼稚，反过来，治法上的正确，还可以多少弥补选方遣药的不足。为了能进一步地说明这个问题，拟分三种类别叙述于下，每类治法略举数端，以备参考，从中亦可见到前辈人治法之丰富多彩，值得认真努力发掘。

1. 扶正类

- (1) 虚则补之。
- (2) 补脾不若补肾，补肾不若补脾。
- (3) 补脾须不碍肺，滋肾须不妨脾。
- (4) 土旺则生金，勿拘束于保肺。
- (5) 血属阴类，非阳不运。

(6) 精因气而虚者，自当补气以生精，气因精而虚者，自当补精以化气。

(7) 阳失阴而离者，不补阴，何以救散亡之气？水失火而败者，不补火，何以能苏垂寂之阴？

(8) 善补阳者，必于阴中求阳，则阳得阴助而生化无穷。

(9) 善补阴者，必于阳中求阴，则阴得阳升而泉源不竭。

(10) 若要补，切忌蛮补，补中佐以动药，始能补而不见留滞，如厚味填补，必佐行气之品即是。

(11) 五脏之伤，穷必及肾。

(12) 劳者温之。

(13) 形不足者，温之以气；精不足者，补之以味。

(14) 精血亏损者，当用血肉有情之品。

(15) 气阴两亏，当用甘温之药。

(16) 久服养阴之剂，当参入甘淡微辛微苦、气味轻薄之品，以防气机郁滞。

(17) 虚损至食减形瘦，当以后天脾胃为要。

(18) 胃虚通补。

(19) 左归的立法原则，是育阴以涵阳，不是壮水以制火；右归乃扶阳以配阴，不是益火以消水。

(20) 瘀血不去，新血断无生理。

(21) 妇人产后病，可参考傅青主生化汤加减，大补气血为先，虽有表症，以末治之。比如产后冒风发热，可用生化汤加白薇，临床效果颇好，单用发散之剂，往往愆事。

(22) 补虚的主要方法在扶胃气，用药要少、轻、淡。可用饮食代药，引其开胃，饮食得宜则胃口开，饮食得进则气血增，就能进一步地进行调补。

(23) 病后自当进补,但要补得适宜,厚味荤腥固然血肉有情,但胃气初苏,反伤胃气,倘是温病,余热未净,反留祸根,能致食复。

(24) 久病服药损伤胃气而恶药、干呕者,当以食疗为主,倘仍用药物治疗,纵使对症,也难以见功。

(25) 临床上脾阳虚与胃阴伤同时存在者,比较复杂难治,治疗当兼顾东垣、天士之法,庶无偏胜之弊。我的体会,有热象者,当以养胃阴为主,养胃阴之药,如沙参、玉竹、麦冬等,均为清润之药,渐次再增加扶脾阳之药。无热象者,当以扶脾阳为主,渐次佐入养胃阴之品,阳长则阴生也。

(26) 治虚无速法,欲速则不达,要立方固守,多服自有益,倘若心急而背水一战,实乃促其早夭。

2. 祛邪类

(1) 实则泻之。

(2) 温热病之应用下法,主要目的是逐邪热,下燥粪,除积滞还在其次。

(3) 祛邪应乘势利导,切忌截堵病邪出路。

(4) 温疫以祛邪为急,逐邪不拘结粪。

(5) 胃痛屡发时久,必有凝痰聚瘀。

(6) 逆流挽舟。

(7) 即使邪在气分,甚至在营分,只要存在闭汗的病理现象,都须不可回避汗法,勿拘于表汗之说。

(8) 湿盛则阳微,非真微乃湿蔽清阳,利湿则阳通,此之谓也。

(9) 与其扬汤止沸,不如釜底抽薪。

(10) 养生当用食补,治病当用药攻。

(11) 寒湿内滞之证,施以温化之剂,犹如春和日暖,冰雪消融。

(12) 治任何疾病,都当为邪气开出路,开出路乃是审查病人之苦衷,恢复气机、气化之正常。一般出路为汗、吐、下、利,其中利指通利小便。如何开呢?并非仅仅指发表、涌吐、攻下、利尿,查气机、气化阻碍之因而去之,亦是开出路之法也。比如用五苓散与苓桂术甘汤都能治癃闭,而前者重渗利,后者重气化,要知常,更要达变。

(13) 用清法要无凉遏之弊,在于有机结合表透、通下、反佐等法,为撤邪祛热开辟出路。

(14) 攻邪宜早,迟延则徒耗正气,反为难办,达邪务溃,乃一鼓作气之义也,否则,再而衰,三而竭。

(15) 老年人、产后、先后天不足者,纵是感冒风寒、风热,也是杂合之病,当用杂合之药以治之。

(16) 阴邪凝聚者,当用阳药通之,但须注意与此有联系之处的寒热虚实,一则防其欲速不达,二则防其动辄制肘,三则防其挖正气的墙脚。

(17) 正虚邪实,有五法可以借鉴:

①不正面攻邪,从侧面祛邪,如癥瘕积聚,体虚又不任攻削者,可用消法或和消二法合用以渐去之。

②“退避三舍”,保存正气,争取各方面因素的支持,让邪势自衰,然后一举歼灭,如温病之战汗,即是其例。

③诱其所好而歼之,如热结旁流,采用通因通用之法,又如湿温用下法即是。

④先打弱敌,各个击破,如分消上下,使热与湿不相合,势力孤单。

⑤微者逆之，甚者从之，从者即反治法也。热因热用，寒因寒用等，皆是从现象上顺从，而反佐疗法，则是为了更好地发挥药物的治疗作用。

以上五法与扶正法相伍，于正虚邪实之证的治疗，皆有较好的疗效。

(18) 六淫外感，外来之邪，本人体所无，驱之务尽，但务尽二字，并非是指一味使用祛邪之法。邪去七八，则当伍与扶正之法以达邪，否则正气一虚，邪反易凑，就不能尽矣。

(19) 清各种脏腑之里热，清之不去，应配伍清热利尿，泻下通便之品，以引导邪热从二便而解，否则疗效不佳。

3. 调整类

(1) 脾失健运而痰生，健脾则痰消。

(2) 肝不柔和而风动，柔肝则风熄。

(3) 土虚木摇之风动，纯熄风无益，当补土固木。

(4) 阴亏于下，阳浮于上，不宜走窜不能收纳之品。

(5) 阴不足者，阳必上亢，而内火熾，欲阳之降，必滋其阴，徒持清凉无益也。

(6) 中气虚寒，得冷则泻，而又火升齿衄，此为土薄火升，清凉药无效，当温补中气，俾土厚，则火自敛。

(7) 壮水之主，以制阳光，益火之原，以消阴翳。

(8) 通之之法，各有不同。调气以和血，调血以和气，通也。上逆使之下行，中结使之傍达，亦通也。虚者助之使通，寒者温之使通，无非通之之法也。若必以下泄为通，则妄矣。

(9) 肝阴耗损之症，专事疏肝不独无效，反可增其燥伤阴血，柔以抚之，尚可驯其横逆。

(10) 调治脾胃，责在升降润燥之间，权宜而施。

(11) 疏肝必兼顾理脾胃。

(12) 水旺则火熄，勿汲汲于清心。

(13) 久患风湿，治风先治血，血行风自灭，以养血为本，自可事半功倍。

(14) 血之妄行，多是相火，疏泄无度，可用介类使肝肾泛滥之虚阳安其窟宅，正本清源，不治血而血自止。

(15) 肝主血，络亦主血，同类相从顺其势而利导之，莫如宣络。

(16) 肝脾肾三脏与奇经八脉密切相连，故凡三脏亏损之症，日久多兼八脉空虚。

(17) 喻氏逆流挽舟之法，本为下痢夹表而设，其实用治泄泻亦为可取。因方中取羌、防、柴、葛等既可解表，又能升清之品，所谓鼓舞胃气上腾，则泄泻自止。

(18) 虚怯之人外感，有健里托邪之法，里和表自解也。

(19) 春多上升之气，宜润肺抑肝。

(20) 夏多火热，炎上最重，宜清金降火。

(21) 湿温通阳不在温，而在利小便。

从中医众多的具体治法来看，可以看到虚补实泻、调整阴阳这句话，是包含着多么丰富的含义，实能开迪人之无穷悟境。如果不深入细致地了解得更多一些、更透一些的话，即使辨证准确无误，在析理和选法上也会出现山穷水尽疑无路的局面。

四、必须认真研究成方

胸中装的成方愈多，临证处方就愈成熟。对于成方的研究，我的体会是，必须从三个方面去着意体会，一是方剂作用之异同，二是组方之妙用，三是剂量之巧思。这里主要谈谈前两个方面。

先剖析几个治疗下痢的方剂：

1. 白头翁汤治肝经邪热挟湿热下注于肠道者，故以下利脓血、里急后重为主症。

2. 黄芩汤治少阳邪热移于肠道，故以下利热臭，腹部急痛为主症。

3. 小承气汤所治之下利，乃热结傍流，故于下利之同时，必有腑实谵语、腹部胀满拒按等症。

4. 猪肤汤所治之下利，以阴虚为主，病在少阴，有咽痛、口渴、心烦等症。

5. 桃花汤之便脓血，是因脾阳虚而不能温摄，症见下利脓血，血色暗而不鲜，滑脱不禁，腹痛喜温按，小便不利者。

再以行水的方剂而言，水肿之治，不在利尿药之强弱，而在于是否针对了气机、气化失常的环节，也就是说是否切中了病机。同是利水之剂，根据不同的治疗途径可区分为：五苓散重在化气行水，五皮饮重在行气利水，真武汤重在温阳行水。

以上是指方剂的同中之异。方剂要能发挥较好的疗效，又与组方之妙有很大的关系，了解和掌握这些关系，对于方药的灵活加减、新方的创立，都有着重要的意义。组方之妙，至少有两种情况，一是成方的组合之妙，二是对成方加减之妙，兹各举几例以说明之：

竹叶石膏汤之组方，妙在半夏一味。此方常用于热病之后，余热未清，气阴两伤，出现口干唇燥、舌质光红、苔少、泛恶、纳呆、脉细数等症。半夏与麦冬相伍，则半夏降逆止呕而又无燥津之弊，麦冬生津养阴而又无留邪之害。有人临证以半夏温燥去而不用者，实乃不知妙就妙在半夏温燥之性，当余热内扰、津气未复、胃气不振已甚之时，使用此方，必得半夏去振奋胃气而制

呕逆，如果减去不用，则方剂寒凉就会偏胜，更使胃气损伤而不易振复。再以大黄黄连泻心汤来说，大黄、黄连都是苦寒药物，如果单用黄连去治疗热痞，虽然有清热之功，却没有破结之力，痞结势必难消，而与大黄相配伍，则不仅能加强清热作用，更增破结力量，相得益彰。补气益卫、固表止汗的玉屏风散，其配伍亦颇有妙处，方中黄芪、防风两药合用，相畏相使，其功益佳。黄芪得防风，即不虑其固邪，防风得黄芪，亦不虑其表散，实属散中寓补，补中兼疏之剂。

前人对成方的加减，亦很能给人以启发，以白虎汤为例：

身中素有痹气者，热渴汗泄，肢节烦痛者，加桂枝；胃汁枯涸，暑热伤气，身热而渴者，加人参；胸痞身重兼见者，加苍术，理太阴之湿；寒热往来者，加柴胡，散半表半里之邪。王孟英说：“余于血虚加生地，精虚加枸杞，有痰加半夏，用之无不神效；治暑邪炽盛，热渴汗泄而痞满气滞者，以白虎加厚朴极效。”

从上述方剂加减中可以看到，补泻并用，温清兼施，各有巧思，故都能取得满意的疗效。

研究成方的异同，研究组方的巧妙，不仅能使我们更深刻地认识和掌握成方，从而有效地选好方、用活方，更重要的是能够由此而启迪我们的思维，推陈出新，加减得宜，创立新方，所谓法从古人，方由自裁，即是指此而言。

五、治病要有主方主药

徐灵胎在《兰台轨范·序》中说：“欲治病者，必先识病之名，能识病名，而后求其病之所由生，知其所由生，又当辨其生之因各不同，而病状由所异，然后考其治之之法，一病必有主方，一

方必有主药。”对于这些论述，我是深以为然，临床上坚持此义，治疗变通，总不离主方主药。兹以胃脘痛和痢疾的治疗为例：

1. 胃 脘 痛

这里的胃脘痛，主要是指慢性胃脘部疼痛，经常发作者，其中能够包括一部分现代医学的胃或十二指肠球部溃疡、慢性胃炎、慢性胆囊炎等。

主方主药：黄连、黄芩、香附、良姜、党参、檀香、延胡、花椒、紫苏。

加减：虚寒者，加黄芪、砂仁、肉桂；湿热者，加瓜壳、半夏、竹茹；肝郁者，加柴胡、乌药、郁金、白芍；血瘀者，加失笑散、丹参、地鳖虫；火郁者，加栀子、左金丸、金铃子；寒凝者，加桂枝、附片；食滞者，加焦三仙；胃阴不足者，去黄芩、花椒，加沙参、玉竹、麦冬、峨参；蛔虫者，加乌梅、使君仁、茺莢；腹胀气滞者，加厚朴、槟榔、枳实；虚胀者，加白术、莱菔子。

2. 痢 疾

古称滞下，又称肠癖。为夏秋季节常见流行疾病，临床以腹痛、里急后重、下利粘涎或赤白脓血相兼为主要特征。我赞成“无积不成痢”和“痢无止法”之说，以一方统治之。

主方主药：当归、白芍、槟榔、枳壳、滑石、木香、莱菔子、石榴皮、焦大黄。

方中当归、白芍用量均为25克以上。

加减：热重者，加银花、连翘、黄连；痢下赤盛者，加地榆；湿重舌苔微黄白腻者，加苍术、厚朴；舌苔灰黄，渴不多饮，小溲不利者，加藿香、通草、白蔻；兼有寒热表症者，加荆芥、葛根；兼有暑湿者，加藿香、佩兰、扁豆花；下痢伴腹痛后重明显者，加生大黄、肉桂（焗服）；有食积者，加焦三仙；休息痢，发作时准此，

不发作时，用参苓白术散、七味白术散等；噤口痢，舌质红绛而干、脉细数者，加石斛、沙参、麦冬、冰糖等；苔白而厚者，加半夏、生大黄，降逆通腑化浊；胃气已败者，加入参，再稍佐藿香、佩兰等芳化醒胃之品。

如何选用某一病的主方主药呢？就是选用的药物功用基本上要能针对整个疾病的病理病机，不同的疾病，各有其特殊的发展和发生过程，能够阻止和调整这个特殊发生和发展过程的方药，就是该病治疗的主方主药。另外，选用主方主药时，就一般而言，不要选择那些偏性太强烈的方药，要尽量能进能退，能左能右。例如，治疗内伤外感咳嗽，我常选用止嗽散为主方，之所以选用它，是因为它温润和平，不寒不热，稍加变化，则适应性就比较广泛。治疗黄疸，我常以茵陈四逆散为主方，这是因为茵陈蒿汤退黄利胆除湿，四逆散舒肝理气解郁止痛，正切合整个黄疸病的病机。治疗青壮年的神经衰弱，我常以温胆汤为主方，这与温胆汤不寒不燥，颇能进退有很大关系。

必须加以说明的是，我在这里所强调的重视主方主药，是服从于中医传统理法方药辨证用药这个大前提的。我反对动辄讲辨证论治，漫无边际，让人抓不住重心的作法，因为中医并非不辨病。我也反对重方药轻医理的作法，因为这样做的结果，只能使中药的有效应用范围越来越窄，疗效也必然随之受到限制和影响。只有辨证与辨病相结合，辨证论治与专方专药相结合，才能使中医基础理论更好地与临床实践结合起来，从而提高临床疗效，发展中医学术理论。几十年来，我对此体会尤深，教训亦不浅，故不能不加以强调。

六、掌握更多的治病手段

临床治病，不当以药治而屏弃其他治疗手段，也不当以内服药而屏弃外用药，各种治疗手段均有自己的长处和局限，作为医生要善于发挥各种治疗方法的长处，并尽量多掌握几种方法，以备临床之用。唐代孙思邈说：“病有须针者，即针刺以补泻之……，针灸而不药，药不针灸，非良医也。”观我父辈医生，纵以内科为主，亦兼通针灸、推拿等法，不似今天的内科医生，只往往运用药治。我临床治病，都是采用内外合治，针药并用，确能解决实际问题，比单用药治更能扩大治疗范围和提高疗效，颇受病家欢迎。

除针刺四逢穴与内服方药并用以治疗小儿多种病症，在后面有专文论述外，我治疗慢性气管炎，常采用灸足三里、关元、肺俞，与内服方药相配合，能相得益彰。急性火眼病，除内服汤药外，常用苧麻绳，点燃灸鼻尖，轻者单灸亦颇有疗效。疮、疽、痈初起，我亦往往是外敷内服方药并进，而治疗包块如乳癖、血瘤、肉瘤、粉瘤等，都是针药并用，效果颇佳。如丁×，女，32岁，××研究院工作。性情倔强，易怒，左乳房上生一硬结，数月内即大如核桃，疑为乳癌，心中甚为恐惧。处方：瓜蒌15克，甲珠6克，青皮10克，白芷10克，银花12克，木通6克，夏枯草12克，地丁草12克。水煎服。直接针刺其包块三针，另取合谷、足三里，每次针单侧，针后加灸。三月后，包块消失。又如王××，男，45岁，干部。右胁上生脂肪瘤（10厘米×6厘米），直接针灸包块21次后，即缩至5厘米×3厘米。马××，男，42岁，干部。背上生一硬结，拇指大，针后直接灸，治疗三次后即消失，二年后亦未曾复发。至于用针灸、推拿与内服药配合治疗关节痛、外感头痛、

扭挫伤、口眼喎斜等疾病，早已是属于经常运用的治法了。

这里，再谈一个病案，借以说明食疗和日常生活摄养对疾病治疗的重要性。我早岁曾诊治一经闭患者，经多方治疗，瘦弱、潮热、腹痛等症均已好转，而胃口总是不开。用多种方法调治，疗效不佳，几至技穷。后偶然闲谈，知患者平素爱吃甜食，自病后即渐恶甜，于是嘱其可适当吃些豆腐乳，本是不意之言，逆知病人自此却胃口渐开，比服药见效得多。于是，病体日益向愈，体质得以恢复，月经正常。此案给我教训很深，使我懂得了只知内服方药，还不能算得好的医生，仅懂得药疗是不够的，还要懂得食疗、神疗等治疗方法，不然对很多病的治疗仍会束手无策，而望洋兴叹。

七、遣方三要

具体遣方用药，我对自己有约法三章：

1. 要辨证用药

华岫云在《临证指南医案·凡例》中写道：“余愿业医者，于识证尤当究心，如儒家参悟性理之功，则临证自有把握。然后取此法与方用之，必有左右逢源之妙矣。倘阅是书者，但摭拾其辞句，黜袭其方药，藉此行道，为觅利之计，则与余刻是书之一片诚心，大相悖矣。幸后之览者，扪心自问，切勿堕落此坑塹。”徐灵胎对此眉批道：“近日此辈甚多。”这是强调辨证用药的重要性。

2. 要辨病用药

不少临床所选之药，都是针对中医所谓的病而选用的。如黄疸选用茵陈退黄，疟疾选用常山、青蒿截疟，蛔虫症选用槟榔、使君仁驱虫；它如香附、益母草调经，穿山甲、王不留行通乳，

三七、自然铜疗伤，仙鹤草止血等，也是这样的使用。中医也要辨病用药，不可忽视，这中间有不少宝贵遗产，值得发掘。而随着时代的发展，西医对病的认识也会非常自然地影响中医的临床，随之也必然会积累不少新的辨病论治经验。所以，辨病论治的功夫，也就成了临证处方中重要的一环。

3. 要根据经验用药

不少有较好治疗效果的方药，中医理论无法解释，纵能解释也比较牵强附会。而现代医学对其中的机理也无法完满地解释，选用它们，就是凭经验用药。

只要能较好地综合上述三个方面去选用方药，一般来说，也就比较中肯了。

从以上七个方面谈了自己对临床论治的体会，概括起来为三句话，即明理法，知方药，博技艺。能做到这九个字，临证论治就能收到较好的效果。但是，这九个字所包含的内容又非常之丰富，要做到又非常之难。因此，学医要下功夫、花力气，来不得半点侥幸心理。《素问·气交变大论》说：“夫道者，上知天文，下知地理，中知人事……。”临证日久，对此感慨颇深，我今年且九十，时时以“医非博物，不能治疑难之症”以自勉。

浅 谈 扶 正

中医治病为什么要时时注意扶正呢？首先是因为中医学认为邪之所凑，其气必虚，正气虚是疾病发生的内在原因。这种正虚

发病学说，由《内经》所确立，又为后世医家所继承而发展，成为中医学学术的特色之一。不仅如此，中医学还认为疾病的发展、变化情况，也多取决于人体正气的盛衰存亡。正盛则邪却，正虚则邪进，正气的情况决定着疾病轻重、发展和预后的好坏，正气未伤，虽重可望来苏；元气耗散，虽轻症亦易恶化。因此，对疾病发展和预后的推断，中医不仅视病情之轻重，更注意元气之存亡。基于此，中医治病总是处处顾护正气。《素问·五常政大论》说：

“大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；无毒治病，十去其九；谷肉果菜，食养尽之，无使过之，伤其正也。”《素问·六元正纪大论》说：“……大积大聚，其可犯也，衰其大半而止，过者死。”这里，就提出了一个值得认真思考的问题，为什么不彻底消除，却仅衰其大半而止呢？为什么无毒治病也不穷追猛打，却仅十去其九？这就是处处顾护正气思想的具体体现。《内经》所提出的这种“无使过之，伤其正也”的正确医疗思想，为后世医疗实践所证实、继承和发展，历代有学识经验的医家治病，始终处处以维持或扶持正气为主，谨慎地处理好邪正之间的关系，以达到邪去正安，病体向愈的目的。

张仲景在《伤寒论》中，对于正气的盛衰存亡是极其重视的，书中经常提到亡阳、亡津液，并有许多因正虚而禁用或慎用祛邪法的记载，以及因误治伤正而采用的多种“救逆”条文。处处顾及正气，还表现在服药注意事项的记载上，如大青龙汤有“一服汗者，停后服，若复服，汗多亡阳，遂虚”之诫。叶香岩在其《外感温热篇》中说：“如面色白者，须要顾其阳气，……面色苍者，须要顾其津液。”“初病舌就干，神不昏者，急加养正透邪之药。”

“若虽薄而干者，邪虽去而津液受伤也，苦寒之药当禁，宜甘寒轻剂可也。”对于妇女温病的证治，更是强调“虚处受邪，为难治

也。”“然须步步保护胎元，恐正损邪陷也。”如此处处注意扶正之说，随处可见。《温病条辨》一书中，也是再三强调“温热存阴，最为重要。”“温热为法，法在救阴。”“温邪以‘存津液’为第一要着。”以汗吐下三法驰誉医林的张从正，虽倡攻邪却未曾置正气于不顾，他那句“养生当论食补，治病当用药攻”的名言，就颇能道出他重视扶正的思想。清代医家魏玉横选辑他的有关医案之后，独具慧眼地指出：“子和之持论如此，岂放手攻泻而不顾元气者哉？第其用补，专重饮食调摄而不持药饵，故万全无弊，而亦无可举之功，其书具在，惟好学深思之士能通其意耳。”近代已故名老中医蒲辅周，亦非常强调在邪正关系上，正气为本，邪气为标；治疗上重视正气为本，强调人体本身抵抗力、修复力等内在因素的作用，不可见病不见人，所以，在立法用药上，蒲老力主贯彻“汗而毋伤，下而毋损，凉而毋凝，温而毋燥，补而毋滞，消而毋伐”的原则。并批评了有些医生忽视人以正气为本等基本概念的作法。总而言之，从中医整体学术思想来看，中医治病是时时以维护、扶持正气为主，谨慎地处理好邪正之间的关系，以达到邪气去，正气易于恢复，且病体最后向愈为其目的。

但是，中医治病，只懂得必须时时注意扶正还不行，还必须处处善于扶正，否则，希望仍将是希望，有时治疗的结果还会适得其反。必须加以强调的是，中医的时时注意扶正，是通过处处善于扶正而体现出来的。在临床上，我是通过以下几个方面来履行善于扶正这个原则的。

一、有虚必补

有虚必补，在补法上要当仁不让，这个观点在古今中医文献

中,都可以看到和体会到。《伤寒论》太阳篇桂枝汤中,就有大枣、甘草、芍药;阳明篇中,有人参白虎汤,调胃承气汤中,有甘草;少阳篇的主方小柴胡汤中,有人参、大枣、甘草,是和法的代表方剂;三阴篇中,以补为主,攻补兼施或以补为攻的治法就更普遍了。《温病条辨》上焦银翘散,即谓二、三日病犹在肺,热渐入里,加细生地、麦冬保津液;中焦通腑有黄龙汤、增液汤、增液承气汤;下焦三甲复脉、大小定风珠,都是贯彻了有虚必补精神的方剂。在中医众多的解表治法中,其中有益气解表、滋阴解表、助阳解表等以补为攻之法,这都说明了在外感诸证中,也是有虚必补的;有虚不补,其效不佳。《新医药学杂志》(1978年第12期)“清热解毒与益气活血法对慢性肺心病急性发作期作用的探讨”一文认为,益气活血能增强清热解毒的疗效,二者合用比单用清热解毒的综合疗效有较明显的提高。可见古往今来的临床实践,都支持外感病亦当有虚必补这个观点。

对于慢性病,中医更是强调有虚必补,今天的临床实践和科研成果,都日益表明这种思想的正确性。以冠心病为例,实践证明,通补兼施,标本同治,能相得益彰,使冠心病的治疗获得较为满意的疗效。其他如慢性支气管炎、慢性肝炎、结核、胃及十二指肠溃疡、慢性胃炎、慢性肝炎等慢性疾病,都存在着类似的情况,必须攻补兼施,才能取得较好的疗效。虚弱病症,在新陈代谢和生理机能方面,多有程度不等的失常现象,或为低下,或为失调,运用补法进行调养,往往能使之增强或改善。经现代药理研究,各种补益药含有人体所必需的各种营养物质,服用这些药物能起到补充营养物质的作用。现代实验研究亦证实,虚证患者每有免疫机能减退或失调的现象,运用补法,则能增强体质,从而有效地防止疾病的发生,增强机体的抗病能力。综合这些论述,

都足以说明，有虚不补，实为下策，有虚必补这种观点，完全适用于各种急、慢性外感和内伤疾病的治疗。那些根据补不恰当而出现了副作用和不良反应，就此得出“伤寒无补法”，“邪未尽不宜早补”，“虚不受补”等等结论的做法，是片面的。因为在有虚必补这个前提下，还必须补得恰当，才能收到良好的效果，如果气虚补血，阴虚补阳，当然只会适得其反。但若就此而得出不能用补的结论，和乱补一气的做法，都同样是荒谬的。

二、补要及时

补不及时，等于不补，这句话并不过分。特别是在病情危重之时，补要及时实质上包含着救急和防微杜渐这两层意思在内。不少同道指出，在危重或急性病的治疗中，不应该将补药使用得太晚。如屠揆先、王静仪医师谈到人参用于危重病人的时机时说，要“参照现代医学的诊断及根据中医的辨证，对‘攻邪’方面经过一定日期，还未显示出疗效时，就应考虑到机体功能问题，也就是可能有‘正不胜邪’的因素存在。要选用扶持正气的药物。配合祛瘀或攻逐的方剂进行治疗。”在出现正不胜邪的预兆时，更要急需考虑扶正：“用人参作为扶正药要用得及时。如用在死亡前的不多时刻，虽然亦可作为中药抢救的一法，可能效果不太理想。”（“人参用于危重病人”《新医药学杂志》1978年第7期）徐仲才医师亦以使用附子温阳为例来阐述过补要及时的思想，他引用张景岳的话说：“‘今之用附子者，必待势不可为，不得已然后用之，不知回阳之功，当于阳气将去之际，渐用以望挽回，若既去之后，死灰不可复燃矣。’张氏在这里对附子的应用还是留有余地，但强调及时应用附子于阳气受损病人则是观点较为明确的。我们应用‘温阳’药，

并不限于附子一味，我在这里不过借附子来介绍应用温阳药物的经验。”（“附子在临床上的应用”《新医药学杂志》1978年第3期）由此可见，补法做为扶正的一种手段使用时，不仅要有虚必补，而且还要补得及时，不能等到势不可为时才用补法，那样做，慢性病就会增加病人的痛苦，延长病程；危重病就会坐失良机，甚至造成不可挽回的损失。

三、要辩证地看待攻补和扶正的关系

中医的治疗法则虽然众多，但总括起来，不外攻补两大法门。从现代医学观点来看，补的基本作用，可能在于改善或恢复患病机体的神经——体液的调节，改善或加强机体的免疫功能，支持或加强机体的抗病能力，促进患病组织器官的机能、代谢和形态结构的改善或修复。总之，在于使人体机能调节内外环境的适应能力，抗病能力得到恢复和增强。而祛邪的基本作用，在于抑制或消除发病因子对机体的有害影响，减轻或消除各种损伤、障碍现象，加速毒物的排出，消除各种病理潴留物等。必须充分认识到的是，攻和补的目的，都是在于使患病机体恢复正常的生理活动，攻和补乃是为达到这一目的所使用的不同手段。

补法是扶正的重要手段，但不是唯一的手段。那种把扶正仅仅理解为即是补法的认识，是大错而特错的。由于攻补都是使正气恢复的手段，所以，在这个共同的基础上，二者的作用可以相互转化。以塞因塞用的气虚大便不通而言，补气即可以起到攻下的作用，这种寓攻于补之中的治法，何尝不是一种攻邪的手段呢？同样，攻邪适当，邪去正安，又何尝不是一种扶正的手段呢？补可去弱，邪去正安，可见攻补得当，都可以起到扶正的作用。正是

由于攻补都是治病的手段，因而使用不当，都会损伤正气。蒲辅周在谈到八法的运用时说：“以我数十年临床体会，逐步认识到中医的治疗大法‘汗、吐、下、和、温、清、消、补’均需掌握分寸，太过或不及，用之不当，皆能伤正。”这里提到了补法，补之不当仍会伤正，可见用补法扶正，也非多多益善，必须掌握分寸。“还有用泻法来达到补的目的。如《金匱》虚劳篇立有‘大黄廑虫丸’一法，去瘀才能生新。”古今的临床实践告诉我们，必须辩证地对待攻补与扶正之间的关系，攻补之间虽然不能相互替代，却能相互补充。只有有力地打击邪气，才能更好地保存正气，扶持正气，以利于病体恢复，这个道理是很容易理解的。临床上常常可以见到，肺心病患者肺部感染若能有效地被控制，心衰症状也往往就会随之而好转；结核病属于中医瘵癆范畴，用抗痨药物一旦有力地抑制和杀灭结核杆菌，那么，由此而产生的虚劳症候也就易于得到改善。诸如此类的情況都说明，祛邪是一种很重要的扶正变法。正是基于邪去则正安这种思想，中医学才有了那么多的祛邪方药，而对这些方药的使用，又再三叮嘱要中病则已，也就说明了中医治病是时时注意到扶正的。

从现代对中药的药理研究中也可以看到，中药攻和补的作用不是绝对的，往往是攻和补融合成一体。不少祛邪的药物，同时又具有补正的作用，如黄连不仅有较强的抗菌作用，同时又具有提高机体免疫力的作用。清热解毒的蒲公英、地丁，能促进正常人体淋巴母细胞转化，而虎杖对放疗引起的白细胞下降有效。白花蛇舌草、白毛夏枯草、鱼腥草、山豆根、杨梅根、银花、黄芩、黄连等，具有刺激网状内皮系统增生，增强其吞噬机能的作用。不少的补药，也具有不同程度的祛邪作用，如黄芪、黄精、麦冬、冬虫夏草、补骨脂、当归、芍药等，都具有抗菌作用。续断对痈

疡有排脓作用，何首乌能致泻，鳖甲能软坚，茯苓利水，当归活血，甘草解毒等。从纯中医的角度来看，也是攻补兼备的。综上所述，我们就不能用凝固的眼光去看待补正和祛邪，以及攻补药物之间的区别。二者常可由间接和直接的关系相互转化，要善于利用和运用这种转化去达到治病的目的，才能真正发挥出辨证论治的优点来。

四、剂型、禁忌、服药方法等， 也都是扶正的重要手段

银翘散为什么用散剂？为什么勿过煮？吴鞠通解释道：“肺药取其轻清，过煮则味厚而入中焦矣。”大黄黄连泻心汤，为何不取煎剂而用麻沸法？前人认为是取其轻扬清淡之意，以泻心消痞。且不论以上解释的科学性到底如何，而按照这样的剂型运用，确能使药物更好地发挥作用。同样，《伤寒论》中附子泻心汤，其中大黄、黄芩、黄连不取其煎而取其渍，是欲其味薄气扬以清热，附子别煮取汁，是取其味厚以加重扶阳之力，这种两者相混而服的煎药法，是既耐人寻味，同时又发人深思的。恰当的剂型，在客观上能起到祛除病邪、扶持正气的积极作用，因为剂型不当，煎法失宜，使药起不到应有的作用，邪气不除，则正气难复，正气不充，则邪气难却，疾病羁留，正气就会更加受损。所以，恰当地选取剂型，客观上都能够起到积极的扶正作用。

服药的方法，也不应当忽视。桂枝汤，服药一杯后，约半小时再喝热稀粥一杯，使谷气得充，能助药力。鸡鸣散，要求在清晨4时左右服，才有效果。礞石滚痰丸，在吞下后，要平躺一会儿，才能有效地发挥作用。一般而论，攻下药物，宜空腹服；对

胃肠有刺激的药物，宜饭后服；急救药物，宜急服，以快速为主，不必拘泥时间。同一四逆汤，《伤寒论》中，就有分温再服和顿服之分，这是因为病情不同之故。如果能正确地根据病情、药物、体质、环境等方面的因素，制定出相应的服药方法，就能更好地达到预定的目的。这样做有利于攻补得宜，就能起到积极的扶正作用。另外，饮食禁忌，也是为了消除各种不利于治病因素而制定的。设想，倘若不注意到煎药和服药的方法，以及饮食、情志之宜忌等情况，小则耽搁病程，大则增重病况，结果都只能是更损伤正气，走向扶正的反面。

五、不能囿于药治一法

用药物为武器，去扶正治病，是一个重要的方面，但不是唯一的方面。对疾病治疗的成功与否，还有赖于护理、营养、环境条件及精神情况等方面的相互协调。精心而恰当的护理，能给病人造成一个良好的休息和治疗环境；充足和适口的营养食品，能给病人以很好的补偿外，还能激发病人的胃口。这些都无疑对扶持病人的正气起到极大的作用。饮食疗法早已成为中医的一门专门学问，有时它能起到药物所不能起到的作用。我在临床上就体会到，补虚的主要方法，在于扶持胃气，用药要少、轻、淡，可用饮食代药，引其开胃，饮食得宜，则胃口自开；饮食得进，则气血自增，就为进一步调补打下了良好的基础。特别是久病服药损伤了胃气，而致恶药、干呕者，当以饮食疗法为主，倘仍以药物治疗为主，纵使对证，也难以见效。《灵枢·九针十二原》说：“神者正气也。”历代对调摄精神亦是补正疗疾之法的论述也是颇为丰富的，它能起到药物所不能起到的作用也是明显的，因此，其对扶正的意义也就自

不待言了。唐代孙思邈就曾指出：“若能用食平疴，释情遣疾者”，方可谓“良工”，可见前人对此不仅是认识到了，而且非常重视。

中医治病的方法虽然很多，但归纳起来不外是通过两个途径去达到治病的目的：一是直接截断、遏止病势发展，消除邪气，这种疗法可以称为截断疗法；二是调整人体机能，恢复和提高机体的抗病能力，这种治疗方法可以称为调整疗法。中医擅长调整疗法，但并不缺如截断疗法，中医是在调整的基础上进行截断的，就是通过祛邪、扶正以调节机体内环境的稳定，从而保证祛邪（截断）治法成功。因此，中医在调整以截断的方面积累了丰富的、丰富的遗产，成为中医治疗上的特长。这种特长对于帮助各种（包括西医药）病因疗法的使用，以及巩固其治疗结果，防止复发，帮助病体恢复健康，都具有非常重要的作用。我认为，在临床的治疗中，要充分发挥中医的特长，时时注意扶持正气，处处善于扶持正气，将截断疗法和调整疗法结合起来，就一定能使治病的疗效大大提高。

针刺四逢穴在儿科的运用点滴

针刺四逢穴治疗小儿疳积，由来已久，由于手法简便易行，疗效确实，且少不良反应，所以广泛沿用至今。临床上，我常用此法与内服方药配合，以治疗多种儿科疾病，能有助于提高疗效，缩短疗程。因此，我认为如果把此法仅局限地用于小儿疳积一症，实在有些可惜。今将我对此法作用的理论认识及临床运用体会介绍于下，供同道们参考。

关于四逢穴的位置，在中医文献上有几种记载〔注1〕，我所使

用的四逢穴，是除拇指以外，其余四指中节横纹中心，两手共计八穴。取用28号五分针，或用绣花针，针刺时避开血络，严密消毒，深度一般是刺入皮下约一分，进针后略为旋转即出针，每针后，宜挤出透明浅黄色有粘性的液体，以尽为度。若纯为血液，则不必挤尽。两手八穴同此，即算一次完结。

四逢穴为经外奇穴，根据《针灸大成》所载，四逢穴与脏腑的关系为：“食指与小肠，中指与三焦，环指与肝，小指与命门。”而《小儿推拿广义》则稍有不同：“食指与大肠，中指与小肠，环指与三焦，小指与膀胱。”我认为，各穴位分属于脏腑的认识，是前人根据四逢穴的临床作用进行归纳的结果，这种机械的分属方法不可取的，因为临床上四逢穴不是单用，而是四指全刺。但是，透过这种分类方法，却可以体会到四逢穴与传化物而不藏的六腑有密切的联系。针刺四逢穴，并要挤出液体，应当属于刺络法的范畴，且是一种泻法。其作用机理有三：一是以清泄胃肠之热为主，能起到清热除烦，通调血脉之功；二是胃为阳明阳土，得阴自安，以胃喜柔润故也，针刺四逢穴能润补肺胃之阴液，以安肺胃；三能疏通三焦，通降胃肠，六腑以通为用，胃宜降则和，这样就能以降调升，借通为补。总之，此法的作用，我的体会可以归纳为清、润、降三字，作用部位在于胃肠，不适于虚寒性证候的治疗。人体患病，非表即里，而病情进退变化，每与脾胃运化相关。外邪闭表，胃气易滞，内因病里，脾运易衰。常见外邪透解后，胃郁亦伸，而胃气畅达，则肌表自然得汗，在临床上屡见不鲜。这都是因为中焦为一身气机升降出入的枢纽，脾主升清，胃主降浊，对表里邪气的祛除，对人体气机、气化的调整，都有着非常积极的作用。当各种病症一旦波及到脾胃，出现了针刺四逢穴的适应证时，施用此术，配合汤药，必将相得益彰。我即是以此而指

导临床，颇感应手。兹举几种常见病症的运用情况介绍于下：

一、小儿腹泻

中医所说的小儿腹泻，包括的范围较广，就现代医学来说，包括了单纯性和中毒性消化不良，急性和慢性肠炎，肠胃功能紊乱等疾病。中医认为，不论何种原因，均必须造成胃失腐熟，脾失运化，升降失常，清浊逆道，水谷不分，并走大肠，才会引起泄泻。所以，不论伤食、外感、暑湿、脾胃脆弱、营养发育不良的小儿泄泻，都存在着一个调理脾胃的共同问题。我对于小儿泄泻，凡偏热或挟热者，除给予应证方药内服外，每配以针刺四逢穴，以调整三焦，理胃生津，清热除烦，降浊升清。临床上，我曾认真做过比较，同样体质和疾病的患儿，使用同样的方药，不论是症状的控制或胃肠功能的恢复，以及精神状态的改善，配合针刺四逢穴者，较单纯用药物治疗为优。烟台市立医院用针刺四逢穴治疗单纯性小儿消化不良症，疗效亦很显著，四百多例的治愈率达90%以上。（《串雅外编》选注，福建省医药研究所注释，人民卫生出版社，1977年）可见用此术治疗小儿泄泻不可忽视，具有重要的临床意义。除此以外，各种泄泻后期，胃液已伤，邪热犹存，泄泻不甚之时，此时患儿往往厌恶服药，家长亦因患儿拒药而大伤脑筋，单用针刺四逢穴，具有确切的疗效，对于开胃健脾亦有积极的作用。试举两例加以说明：

郭××，女，5岁。患菌痢已半月余，脓血便已好转，日大便三次，量少，色黄，夹少量涎液，唇干口渴，舌质红无苔，脉细数，指纹色紫。患儿体质消耗较大，与病前判若两人，极度厌药，服下即吐出。单用针刺四逢穴，隔日一次，四次后改为七日一次，经治一月后，体重、食欲、精神均显著改善，迅速恢复到病前体质。

罗 ×，男，6个月。患儿腹泻近三月，所泻之物，乃黄色不消化的乳块，有腐臭味，时呕吐，舌红苔白，指纹青紫，多方调治疗效不显，因之瘦弱不堪，以致父母深感苦恼。近来发烧，体温38.5℃，大便镜检，白细胞高倍满视野，大便次数增加。用半夏泻心汤加沙参、玉竹，辅以针刺四逢穴，一周后腹泻基本得到控制。尔后，一周针刺四逢穴一次，连续针刺三次后，患儿日渐大便成形，能食不呕，体重日增。

二、小儿疳积

历代医家对疳积分类甚多，但均不离脾胃受损，受纳失职。《幼幼集成》说：“疳之病，究其源莫不由于脾胃。”《小儿卫生总微论方》说：“大人瘠者，因肾脏虚损，精髓衰枯；小儿疳者，因脾脏虚损，津液消亡。”因此，调理脾胃实为治疗小儿营养不良的主要原则。临床所见，以肢体消瘦、发枯、神疲、肚大青筋或腹凹如舟为特征。其症以积热蒸腾，气血津液耗损者，用此术的效果最好，这与此术有清心止烦、通调二便、益胃生津等作用相适应。单用针刺四逢穴以治疗小儿疳积，已成定案，无庸赘述。而我常用自制沙参玉竹银翘汤（沙参、玉竹、麦冬、扁豆、花粉、桑叶、山药、石斛、银花、连翘）与针刺四逢穴相配合，每能相得益彰。

郭 ×，男，5岁。患儿形体消瘦，头大颈细，极不相称。头上经常生脓疮，贪饕无厌，酷食异物，如偷吃食盐、捡地上的脏东西吃等。此乃肺胃津液亏损，热淫于内，所以舌质红而无苔。处方：沙参15克，玉竹12克，麦冬12克，扁豆10克，银花10克，连翘10克，天花粉10克，石斛10克，山药18克，桑叶10克，甘草3克。并针刺四逢穴，能挤出淡黄色粘性液有七穴。

一周后再诊，进食已稍有规律，口渴、烦躁、夜卧蹬被等症减。再针刺四逢穴，仍处以上方。针刺第三次后，因他要返回江西，带回五剂药。后来信并附照片，小儿已体胖不畸形，且饮食正常，不再生疮了。

三、小儿发烧

小儿伤风、感冒、伤食而致发烧，或温热病后期肺胃津亏，余热未尽，或湿温病湿热流连三焦，以及小儿疳夏发热，阴虚、血虚所致之虚热等。我常使用针刺四逢穴法，并配合汤药治疗，亦常单行此术，效果较好，颇受病家欢迎，各举一例于后：

胡××，男，5岁。患儿近半年来，每夜发低烧，躁扰不宁，经注射百尔定、青霉素、链霉素，以及服滋阴清热解毒的中药，均无效。患儿面黄肌瘦，能食，舌质红、苔薄白，用银翘散加减（银花、连翘、蝉蜕、枳壳、天花粉、丹皮、赤芍、葛根、甘草），并针刺四逢穴。治疗二次后，低烧已不每夜发作，四次后基本痊愈。

赵××，女，2岁。患儿体胖，面色无华，平素经常感冒，常有低烧，食欲尚好。这次喉痛，流清鼻涕，发烧，咳嗽已两日，舌尖红、苔薄白，烦躁。针刺四逢穴，嘱多喝开水，不另服药物。隔日施术一次，治疗三次后，低烧消失，面色好转，感冒机会亦减少。

四、小儿腹胀

腹胀一症，常见于儿科多种疾病之中。徐洄溪对此症有较为中肯的论述：“腹胀症即使正虚，终属邪实，古人慎用补法。又胀必有湿热，倘胀满或有形之物，宜缓下之。”小儿临床上的腹胀，多属伤食，湿热气滞，偏于实证者较多，用针刺四逢穴的方法治疗，从理论上和实践上来看，都能令人满意。《伤寒论》中五泻心汤所主治之痞证，配合此法亦颇有疗效，不过虚寒性中满之证，用此法却不太相宜，当须注意鉴别。

李×，男，5岁。患儿中午吃肉包子五个，计约四两多，当晚即发烧，腹胀厉害，干呕，噎气。用针刺四逢穴，以通腑、消食、荡积，针后一小时

许，即泻下秽臭，夜烧退而告安康。

敬××，男，4岁。患儿感冒后腹胀如鼓，不思食，小便黄赤，口秽臭，且渴，而愈喝水腹愈胀，已病二月。视其舌质红，苔薄白，余无所苦。七天针刺四逢穴一次，停所有内服药。针第一次后口渴减，第二次后腹胀减，第三次后食欲增加，两月后，体质大见改善。

郑×，男，1月半。患儿半月来时时吐乳，渐至腹胀，不食乳，大便不通。服麦芽片、胰酶片、大黄苏打片等无效，已病两日。今腹部凸起，敲之如鼓。患儿因不断啼哭，而致声音嘶哑，食入则吐，精神萎顿，有半日未小便。针刺四逢穴后半小时，即排出小便。处方：砂仁1.5克，通草1.5克，白蔻1.5克，山楂6克，莱菔子6克，木香1.5克。次日午后再诊，大便通，小便增，腹胀减，能食乳，呕吐次数减少，再服上方。第三日腹胀全消，再针刺四逢穴。五天后，持续半月的呕吐现象消失。二月后，患儿一反消瘦为胖壮矣。

五、小儿口疮

本病有虚实两途，实则心脾（胃）积热，虚则为虚火上浮，由于本病常见于体质较差的患儿，所以，虚中挟实之证为多。用针刺四逢穴，以清心除烦，润养肺胃，通腑健胃，引火下行，正合此疾病机。就临床上看，以口中流涎较多，舌质红者，收效最佳。

白××，女，3岁。患儿口角溃烂，舌质红绛，苔黄薄，小便淋漓疼痛，色如浓茶，指纹青紫，口渴思饮。经用导赤散后，症有好转，但口角溃疡总不全消，已延续二个多月。单用针刺四逢穴，三日针一次，连续四次后，口腔溃烂即愈，已一年余，未见复发。

用针刺四逢穴的方法，除了能够治疗上述疾病外，还可以用于治疗百日咳病后期，肺胃阴亏，干咳不已；用于小儿急性传染性肝炎，有利于退黄；用于麻疹后期，能滋养肺胃；用于多种儿科疾病后期，除虚寒证外，均有利于患儿机体的恢复。总之，我

体会到使用此术，不应当拘泥于它到底能用于哪些疾病，而需要掌握它的作用机理如何，这样才可以举一反三地去治疗多种儿科病症。

最后，还有几个问题需要解释一下，这对于针刺四逢穴能否发挥最佳疗效，有着直接的影响：

1. 针刺的次数，主要根据疾病的具体情况而决定，同时也要考虑到针刺部位能否承受，权衡二者加以决定。一般来说，慢性病一周针一次，急性病隔日也可。

2. 总的来说，虚寒性疾病的疗效较差。再退一步看，心里不烦躁的患儿，比心里烦躁的患儿效果差；挤不出浅黄色粘液的，比能挤出液体的患儿疗效差。

3. 关于挤不出浅黄色液体的问题，有单独说明的必要。有时挤不出液体的，是由于针刺太浅了或刺上血络的缘故，前者再深刺一些，就能挤出来，后者最好下次注意细心针刺。另外，还有一种情况，连刺八穴，血丝极少，更无液体，或用力挤也只能挤出极少血丝和液体，这是津液干涸的现象。在这种情况下，我每于对证方中增入清养肺胃之品，如石斛、山药、沙参、玉竹、麦冬等，经过一段时间后，针刺即能出现和增多液体，病情也随之好转。

4. 在腹泻和疳积等症中，应该注意忌口的问题。因为在脾胃之气恢复阶段，暂时忌口，可以防止急性消化紊乱。逐渐增加对食物的耐受力，对疳积和腹泻的恢复有利无弊。到患儿大便正常，食欲渐见振奋后，就应当适时地、机动地增加营养量，这时若过分强调忌口，不异于因噎废食。我认为，忌口不可讲得太玄乎其神，但也不可不讲，忌口的实质，乃是要患儿吃容易消化的、不容易过敏的、不会增加病症的食物，一般如煎蛋、油条、胡豆、

烧饼、五香豆、糯米粑、鱼虾、蟹、牛肉、黄豆等。总之，忌口当须注意，不可不讲，但又不可过分拘泥得不分时候。

【注1】 四逢穴的位置，文献中的记载并不尽同。承淡龢氏《中国针灸学》和柯传灏氏《针灸经外奇穴治疗诀》记载的是：两手除拇指外，其余四指的第一指节与第二指节横纹两头，每指两穴。《增图考释推拿法》所定穴法是：除拇指外，其余四指之第三节与掌交界之横纹两头。

咳嗽论治

中医学认为，咳嗽的发生，无论外感、内伤，“无不关乎于肺”，另一方面，又认为“五脏六腑皆令人咳，非独肺也”。这两种说法并不矛盾，其实质是说，治病必求其本，任何原因只有波及到肺，才会发生咳嗽，而治疗咳嗽，如果不分标本，不究因果，但治其肺，是难以收到满意疗效的。关于论治咳嗽的文章颇多，这里，我仅概略地谈谈自己对外感、内伤咳嗽中标本、缓急、因果等关系处理的粗浅体会，以及临床治疗咳嗽常用的九种治法的运用，供同道们参考。

治疗咳嗽，不得专以止咳为能事，若不消除致咳的内外因素，徒用止咳之剂，则不仅收效不大，甚至反有留邪碍肺、延长病程之弊，但是，不用止咳之剂，亦终非治咳善法。所以，治咳要善于权衡调整脏腑平衡和止咳诸法之间的种种具体关系。我认为，治疗咳嗽要抓住三个要点：即升降、开阖、出纳。其中升、开、出为散，降、阖、纳为敛。新咳多为外感所致，当以散为主，敛为辅；久咳多为内伤所致，当以敛为主，散为辅。同时，二者都要注意

祛除邪气和与止咳药有机配合，这是治疗咳嗽的总则。

一、外邪引起的咳嗽论治

这类咳嗽可分为两个部分来论治：

1. 有表证者

外感咳嗽以风寒和风热为常见，自然还包括秋燥、风痰等症。凡外感咳嗽，初起有表证者，当以解表宣肺为主，不宜降气镇咳，以免邪郁滋变。

风寒咳嗽，重点在散寒、祛风，风寒一散，表证自罢，咳嗽自除。风热咳嗽，当以辛凉解表为治则，风热得以宣散，咳嗽亦去。当咳嗽一旦形成，对症治疗是必要的，但因果关系应当分清楚，处方用药才不会紊乱，凡由外邪引起的咳嗽，有表症，各种具体的治法都必须服从于解表这一大法。从生理上看，肺主皮毛，肺气通于皮毛的这种作用称为宣化，肺朝百脉，通于五脏六腑，这种作用称为肃降。因而病理上，肺气不能通达表皮，郁于肺，引起气机不能宣达皮表，则咳嗽甚则咳喘，故外邪在表的咳喘，当以解表降逆为主；外邪在表的咳嗽，当以解表宣肺为主，其间主次应当分辨清楚，方能获效。

值得注意的是，宣化和肃降是肺有机联系着的两种生理功能，临床上应该，而且必须利用这二者之间的相互联系去治疗咳嗽，才能收到较好的疗效。比如说，肺气失宣，水湿停滞，而导致肺失肃降，每因用桔梗、枇杷叶、杏仁之属以开泄肺气，就能获得肺气宣降，水道通调之功，这是因为气化则湿化，气畅则水道通，湿化、水通则肺气能够肃降。再如外寒引动内饮上逆之咳喘，不降其逆，单用辛温解表宣肺是难以奏效的。这是因为浊气不能降，

则清气亦不能升，所以单用解表宣肺，往往会更加引起内饮上逆。

感冒风寒，寒邪外束，皮毛闭塞，肺气失宣，开阖失职，发生咳嗽。临床多见喉痒、鼻塞、声重、恶寒身痛、发热无汗等症，当以辛散为主，宜用麻黄、紫苏叶、陈皮、枳壳、桔梗之属，还宜适当地配合前胡、杏仁等清降之品。在咳嗽时，只要有上述表寒见症，无论是急性或慢性支气管炎急性发作，就是肺气肿、肺心病，也要权与宣肺解表，待表寒罢，再议治本。支气管扩张症，原则上是清肺润咳，通络止血，如果是由外邪引起复发，或发作时受寒，在咳喘胸痛吐血的同时，出现有明显表寒见症，亦当权与宣发肺气，否则，肺气不宣，咳呛不已，肺络不宁，吐血胸痛亦难望其缓解。

风热犯肺，肺失宣畅，则咳嗽不畅，喉痒、痰稠或痰色发黄，还可见咽红喉痛、恶风发热、头痛、舌苔薄黄或薄白，舌尖红，脉浮数等表证。治当疏风清热，宣肺化痰，可选用桑叶、菊花、蝉蜕、薄荷、牛蒡子、前胡、杏仁、浙贝母、桔梗等。总之，不论何种新老痼疾，一旦出现有风热表证，都当疏风宣肺，清热化痰为首用之法。

风为寒热兼有之邪，风寒咳嗽，则风从寒化，治以寒为主，宜辛温解表；风热咳嗽，则风从热化，治以热为主，宜辛凉解表。二者均不离解表、宣肺这一治疗有表症之咳嗽的总原则。种种表症的出现，主要是邪气影响到肺和皮毛的开阖功能而造成的，所以，治疗表症当以调整肺之开阖为主，因而解表、宣肺是治疗有表症之咳嗽的总原则。

2. 无表证者

因病变部位已离开肺卫而进一步地深入，故治疗须重视升降。一般而言，热邪为阳，当重清降，寒邪为阴，当重温升。

热客于肺，清降失职，发为咳喘，多见咽喉不利，苔黄脉数，咳则连声有力，喘则痰鸣气急，甚至不得平卧，《金匱要略》称“火逆”，治以清热降肺为主，佐以宽膈祛痰，一般用桑白皮、黄芩、葶苈、杏仁、前胡、瓜壳、银花、芦根、冬瓜仁、鲜竹茹之属，不可妄用升散之剂，以免助其炎上之势。有时热邪不在肺部而在气道，出现鼻干涕稠，咽中不舒，喉间有痰不易咯出，喉部燥痒，呛咳不已，咽喉肿痛，则宜着重加用射干、山豆根、马勃、薄荷、蝉蜕、马兜铃之类，以清利咽喉。另有咳嗽不已，兼见苔腻胸闷，食少腹胀，则属于痰浊上逆之证，宜用温胆汤，加薏仁、杏仁、薏苡仁之类，以化湿降浊，肺气始得以清降，而清润药又当禁用。

外感寒邪犯肺的咳嗽，往往呈现表寒症候，入里则化热者居多，而里寒无表证者亦少，由于有一分恶寒便有一分表证，因而由寒邪所致的外感咳嗽，多有不同程度的表寒证。其方剂如杏苏散、金沸草散、小青龙汤等，都兼有辛温解表宣肺药物。所以，寒邪犯肺，当以温升为主，以制其寒邪收引之性。

二、内伤咳嗽的论治

内伤咳嗽，远非一般清痰降气散寒方药可愈。治此当辨其虚实、标本，治虚勿忘实，祛邪当顾虚，在扶正治本而不碍邪的情况下，可用补养方药以缓缓治之。一般治湿痰，以燥湿祛痰为主；治痰饮，又当以温阳涤饮为要。若仅知祛痰、涤饮，而忽视生痰聚饮之根源，则会本末倒置，而痰饮将始终难以消除。故临床上，常从肺、脾、肾三脏着手，调整气机、气化，其中脾肾二脏具有治其根本的意义。内伤咳嗽的治疗，以调出纳为根本大法，调出

纳的实质就是调整三脏的气机和气化活动。

内伤咳嗽起病缓慢，病程久长，实为痰饮、瘀血；虚为气血、阴阳。病变部位，又有肺、脾、肾三脏之别，部位之辨，颇为重要。如叶天士说：“见肺治咳，生气日戕。”“已经食减便溏，何假纷纷治嗽。”久病体弱咳嗽，兼有食纳减少，腹胀便溏，泛涎不已等脾虚见症，要多从土旺则金生去考虑治法，不必穷究其嗽，对此，叶桂喜用建中类。我常用香砂六君子汤加味，以健脾摄饮，形不足者，加人参、紫河车等。内伤咳嗽的证型，一般多见为痰湿咳嗽，肝火犯肺，瘀阻心肺，肺热壅盛，脾虚水泛，肾不纳气等。而咳嗽有年，多喘咳并作，易出现心阳不振，饮邪上凌，肾不纳气，虚阳上浮等重危症候。这时，调其出纳就显得更为重要了。

三、内伤外感综合论治

内外综合之症，就要综合权衡其升降、开阖、出纳，将散和敛、补和攻有机结合起来。就我长期临床体会，归纳出如下几个治疗要点：

1. 有表证时，以解表宣肺为主，辅以止咳降气，而治本，治宿疾则应当放到从属地位加以兼顾，扶正勿碍邪，解表勿伤正。以外感寒邪而致咳嗽症中的伏热和留饮两种证型而言，伏热为寒包火，除表寒症外，多有苔黄、口渴、痰稠等症，宜在辛温宣肺剂中配以黄芩、银花、连翘、瓜壳、川贝母等清热化痰。留饮除表寒证外，更有苔白、口不渴、吐稀白痰，即《伤寒论》中小青龙汤证。这就是说，内外同病时，为主和从属都必须兼顾治疗，但兼顾中又须主属分明，方能既治现在，又顾将来，取得满意疗

效。

2. 凡治外感咳嗽，重点在于祛邪，邪去正安。但如有体虚邪实，应当兼顾，不顾其虚，难去其实。不过，此时的顾虚，是为了祛邪，如不服从祛邪这一目标，缓急标本错置，以为补正即是祛邪，则邪气不除，正气难复，确有滞邪伤正之弊。

3. 急则治其标，缓则固其本，只要能缩短发作时间，减少外邪侵入次数，使缓解时间增长，体质得到改善，即使发展到肺气肿、肺心病，都有希望使其逐渐趋向好转。

4. 外感咳嗽，其病尚浅易治，惟燥与湿二者较为缠绵，难于速愈。内伤咳嗽，其病深而难治，就肝火与痰湿而言，每与情志、饮食有关。治疗时，须嘱病人戒郁怒，薄滋味，方能得到预期的效果。

综上所述，治疗咳嗽的要点，就是将散和敛、攻与补有机地结合起来，主次分明，有条不紊。其结合的方式有两种，一是先后结合，如先攻后补，先散后敛等；二是同时结合，如三分补七分攻，四分散六分敛等。一般说来，咳嗽分内伤和外感两大类，辨证时只须辨明有无外感？有无表证？病变在何脏腑？在气血？还是在阴阳？只要能辨清楚了这些问题，就能把握住标本、缓急、虚实、表里等关系，这样一来，对单纯外感或内伤，内伤外感相兼的复杂情况，都能得到有条有理的治疗。

兹举两例验案如下：

吴××，女，60岁，病员咳嗽十年，受凉更甚，仅能自理日常生活。近来受凉，发烧，咳嗽加剧，痰稀白呈泡沫状，已经半月。体温39℃，白细胞总数每立方毫米14800，中性白细胞80%，淋巴细胞20%，脉浮数（每分钟110次），口苦，口渴思饮，唇紫，舌质紫胀，苔白，伸舌时满口涎沫，胸闷，常太息。

处方：桑白皮50克，地骨皮50克，苏子10克，葶苈子10克，白芥子10克，莱菔子10克，杏仁12克，前胡12克。水煎服，一剂。

二诊，脉搏每分钟98次，诸症减，汗多，体温37.8℃，仍用上方加枸杞10克，党参20克，水煎服，一剂。

三诊，汗仍多，诸症悉减，夜寐不安。

处方：生地15克，麦冬15克，连翘15克，银花15克，丹皮15克，赤芍15克，桑白皮30克，地骨皮30克，黄芪20克。水煎服。

上方连服四剂后，经检查，血象正常，体温正常，用六君子汤调理。

此案虽属内伤咳嗽，但有新感外邪入侵，经手诊时，已无表症，邪已入里化热，里热以清降为主，急则治标，以清热肃肺为主，邪去正安，最后不忘调补脾肺。

黄××，男，38岁。病员慢性支气管炎急性发作，住院月余，每日注射青霉素、链霉素，咳嗽不减，舌苔白腻，一身酸痛，恶寒，吐白泡沫痰，量多，便溏，体瘦，脉浮紧。停用一切西药，专以中医治疗后，曾用荆防败毒散、小青龙汤多剂无效。到我诊时，除上述症状外，并询知病员平素气短，食欲不好，不耐疲劳。

处方：黄芪24克，苏子10克，党参24克，山药18克，甘草3克，茯苓10克，五味子3克，干姜10克，陈皮10克，法夏10克。水煎服。

一剂后，即有好转，连服五剂，即能起床活动。调理一月，他竟又康复如昔了。

临床上常可见到有些病员平素中气虚馁，表现为食少便溏，面白气短，纵有外邪入侵，也当用甘温之法，不得专事解表祛邪。这类病员，有时无表症，而气虚凛寒又似表症，辨证一错，治则大谬，临证之时，不可不注意加以分析。此症肺脾虚寒，以温升为主，升即能散，温既能补气，又能胜寒，所以取得较好的疗效。

倘初感寒邪的慢性支气管炎急性发作，则解表药又不可少也。

四、治咳九法

临床上，我把治咳的多种治法概括为治咳九法，兹简述于下：

1. **宣** 肺气通于肌表和上焦如雾的生理作用，称为宣化作用。肺气不宣通而壅塞时，就当用宣法。肺气之壅，可产生于两个方面：一是外邪束闭肌表；二是它脏累及于肺，如肝气郁滞等。

常用药物，有桔梗、苏叶、陈皮、前胡、麻黄、牛蒡子、浙贝母、香附、桑叶、薄荷、荆芥、枇杷叶等。

2. **降** 肺气不肃降而上逆，就会导致咳嗽，这与肺气不宣所致者，在病机上有所不同。但在外感引起的咳嗽中，肺之气机往往是呈现既不宣，又不降的情况，而在内伤咳嗽中，主要是肝气、胃气引起肺气不能肃降。

常用药物，有苏子、杏仁、桃仁、旋复花、白前胡、沉香、半夏、川贝母、瓜蒌、瓜蒌仁、槟榔、厚朴、射干、葶苈子、枇杷叶等。

3. **清** 清有清热、清火、清燥、清肺、清心、清肝、清胆等等区别，但归纳起来，只有两大类别，即清养和清泻。

常用清养药，可参考清润药。常用清泻药，有桑白皮、栀子、生石膏、寒水石、黄芩、知母、青黛、桑叶、大青叶、板蓝根、山豆根、地骨皮等。

4. **温** 咳嗽使用的温法，有肺、脾、肾三者之分。

常用温肺药，有干姜、白芥子、紫菀、款冬花、桂心、白蔻、百部、薤白等。

常用温脾药，有白术、附子、干姜、党参、黄芪、炙甘草等。

常用温肾药，有附子、肉桂、淫羊藿、枸杞子、菟丝子、仙茅、锁阳、肉苁蓉等。

5. 补 咳嗽病之补，也不外是肺、脾、肾三脏之气血阴阳。从联系的角度来说，有培土生金、补肾益肺、补肾纳气、滋阴保肺等法。

一般常用的补气药物，有黄芪、党参、人参、白术、山药、冬虫夏草、蛤蚧、石钟乳等。

6. 润 润有润养、濡润、润燥等含义。有凉润和温润之分，凉润中有甘寒和咸寒之别；温润中又分辛润和甘润两个部分。

常用凉润药，有沙参、玉竹、麦冬、天冬、蜂蜜、梨皮、生地、玄参、杏仁泥、藕、柿饼、柿霜等。

常用温润药，有熟地、制首乌、当归、龙眼肉、枸杞子、桑椹子、黑芝麻等。

7. 收 收乃收敛，久咳不愈，肺张叶举，或肾气浮散等症，用之最宜。但收法亦可用于减轻症状，故而咳嗽厉害时可以佐用，不必囿于纯虚无邪或久病方可使用之说。

常用药物，有五味子、乌梅、罂粟壳、百合、马兜铃、诃子、五倍子、白芨、白果、白薇等。

8. 汗 汗为解表之法，有辛温和辛凉之分。有表症者，非用汗法不可。由于外感有表症的咳嗽，多为风寒或风热，所以，这个汗法，多是以散风为主的解表法。

常用辛温解表药，有荆芥、防风、桔梗、枳壳、苏叶等。

常用辛凉解表药，有薄荷、牛蒡子、桑叶、菊花、蝉蜕等。

9. 下 由于肺与大肠相表里，通利大便，洁净大肠，能帮助肺气肃降，并且对于热邪犯肺之咳嗽颇能起到釜底抽薪的作用。

本法用得好，用得巧，常能取得满意的疗效。

在咳嗽药中使用下法，用于大便不通，或有便秘倾向，属于上病下取的方法，就临床观察来看，可用下法，常收效显著。对中焦素有湿热，浊气上犯，可用杏仁、枳实、莱菔子、大黄、保和丸消导之；如膈上痰火胶结，宜滚痰丸。

对上述治咳九法的使用，要根据病员的具体情况，去决定主次和配合。一张处方，往往是几法同时配合，有主辅佐使之别，这样治咳九法就可以变化出很多具体治则出来。运用治咳九法，我的体会是，首先要熟悉治咳九法的各自适应范围、作用机制，这样，各法运用准确，配合恰当，疗效自然较佳。再者，利用人身脏腑气机和气化的种种联系，巧妙地运用治咳九法，以达到治疗目的，亦是一种很有趣味的治病艺术。

论温胆汤与滋阴、补气法之配伍

温胆汤证是临床多种病中常见的证型，它的主要发病部位在胆腑，其病机是痰热内扰，主要的症状是：口苦，口粘，呕吐涎沫，胸闷，苔腻，纳呆，虚烦，惊悸，失眠，幻见，幻闻，幻觉等。治疗这个证型的温胆汤，由法夏、陈皮、茯苓、甘草、枳实、竹茹等药所组成。能调和三焦，傍通胆气，通过祛痰化浊清热的作用，达到清净胆腑的目的，是临床上治疗范围较广，疗效较高的一首方剂。

由于温胆汤证的主要病邪是痰热，因而临床上使用温胆汤时，

往往只注意到清热祛痰的一个方面，而对于温胆汤证有时还需补气、助阳或生津、滋阴的另一个方面，却常常缺乏应有的重视，所以，关于这方面的专门论述也极少。我在临床中体会到，气虚和津伤常出现在温胆汤证中，如不加以顾及，是会直接影响到治疗效果的，兹分别论述于下：

温胆汤证出现气虚、阳虚，一般由以下三种情况所造成：

1. 痰一方面是发病的因素，但另一方面它本身却又是人体脏腑气化失调后的产物。痰的成因非常复杂，可由风、寒、暑、湿、燥、火、食、郁、惊等原因所造成。但是，这些复杂的原因，只是具备了产生痰的可能性，归根到底，这些可能性都必须在干扰到人体对津液的代谢功能活动，特别是影响到肺、脾、肾三脏的功能活动后，才会使可能成为现实。另外，体内阴阳、气血、津液的亏损，也都会影响到肺、脾、肾三脏对人体体液的正常代谢功能，从而产生痰。上述各种原因，如果引起肺、脾、肾的气虚、阳虚，从而产生痰饮而导致疾病者，对于这类痰的治疗，正如尤在泾在《金匱翼》中所说：“夫痰即水也，其本在肾，痰即液也，其本在脾，在肾者气虚水泛，在脾者土虚不化，攻之则弥盛，补之则潜消。”“盖痰本于脾，温则能健之，痰生于湿，温则能行之。”《金匱要略》说：“病痰饮者，当以温药和之。”就是指此类而言。这类非温非补不能治其根本的痰，久留体内，郁而化热，可形成本虚标实、本寒标热之温胆汤证。在这种情况下，当然就应该在温胆汤中配以补气或温阳法。

2. 患病之初，纵是体壮，但痰湿久羁，就必然会阻遏气机和气化，影响到水谷精微为人体所用，久之阳气自然会由此而不足，证型也会由实而致虚。所以，痰症一久，常常会损气伤阳，出现虚实寒热相兼的局面。

3. 再就治疗来说,使用苦寒清热药物,常可因用之不当或用之过度,而损伤人体阳气,使痰湿更加潴留。另外,“凡治痰,用利药过多,致脾气下虚则痰易生而多。”(《金匱翼》)这就说明对于痰热症如果治疗不恰当,是会由此而引起人体气虚或阳虚,这时就完全可能出现痰热与气虚同见的情况。

以上三种情况,不论是由虚及实,还是由实及虚,出现了虚实相兼的温胆汤证,单攻单补,纯温纯清均不适当。单补气或助阳,则痰益固而热愈炽,单消痰清热,则正气又不能支持,痰热不但难以根除,反会变生其他不测。惟有辨清正邪之虚实孰多孰少,而采取相应的消补温清兼施之法。或寓补于消之中,使痰热去而阳气无损,或寓消于补之中,使正气复而痰不再滋生。温胆汤证中出现了气虚、阳虚症时,只有这样处理才比较恰当。冠心病就常可见到气虚或阳虚与痰热共存的温胆汤证,已故名中医蒲辅周,于此类症常用十味温胆汤以调营卫、通心气、化痰湿,如《蒲辅周医案》中心气虚痛等案即是。眩晕症使用温胆汤的机会也很多,故而前人有无痰不作眩之说。但当温胆汤证出现气虚或阳虚后,就必须加以顾及,不然疗效不佳,兹举一例说明。

蒙××,女,38岁。病员平素健康,很少服药。1974年8月,因前额昏痛、恶油,经诊断为鼻炎,有人用914针1支静脉注射,半小时后即呕吐,自觉天眩地转,住入××医院。6天后,呕吐得到基本控制,而眩晕如故,卧床不起,起坐如在舟中,卧床如在摇篮,时呕吐,时有妄见幻觉。

1975年3月13日,邀我孙儿斯特会诊,症如上述,舌苔白膩,舌尖略红,小便黄,口苦心烦,胆怯害怕。查以前所服方药,有辛夷散、川芎茶调散、益肾丸、镇肝熄风汤、天麻钩藤饮,亦曾有人用温胆汤加菊花、天麻、白蒺藜等无效。此乃痰热沃心,胆失决断,胆胃不和,用苦辛法与温胆汤加味:法夏10克,茯神12克,枳实10克,厚朴10克,菖蒲10克,远志10克,竹茹

10克，黄连6克。水煎服。服药两剂后，即能起床。3月21日出院，已能步行十五里归家。病员认为颇有良效，便连服此方二十余剂，眩晕虽递减到能参加农业生产劳动，但眩晕总不见彻底消失，且更增四肢无力，气短，食欲不振等症，每受凉后则眩晕又加重。

我认为，这是由于不顾及扶正，无端克伐正气的结果，便用温胆汤加党参、黄芪、枸杞、山药、玉竹、芡实、熟地等，以善其后。至今已过五年，她一直能参加农业生产劳动。可见治之不当，消之过甚，均能耗伤正气，必须加以兼顾。

再以哮喘一症来说，久喘之人，本虚标实颇为常见，其中也有出现温胆汤证者，但治疗时却不能忽视本虚的存在，兹举一例说明。

殷××，男，54岁。病员患哮喘十五年，肾阳衰惫，每次发作时治肺，平时治肾，症状逐渐减轻，由仅能自理日常生活，恢复到能参加农业生产劳动。1976年4月，由外感而引起急性发作时，手足心烧，恶梦纷纭，口苦舌麻，痰多色黄，咯吐不畅，恶心，食欲不振，喉中有水鸡声，形寒，小便色清量多，大便稀溏，每晨出一身汗，粘涎，胸腹部明显比它处为多。舌质瘦尖红，苔灰白，声音重浊。此为胆胃有痰热，脾肾阳不足。用温胆汤加补骨脂10克，胡桃仁15克，附片10克(先煎)，桑螵蛸10克，五味子6克，干姜6克，桑白皮21克。水煎服，连服三剂，就控制住了这次发作。

通过以上病案，可以体会到温胆汤证出现了气虚、阳虚，如果在治疗上不加以顾及，其结果必然是温胆汤证的症状难以消除，或退而复来，甚至还可能产生新的变症。如果在治疗上加以顾及，不仅可以加速近期疗效，而且远期疗效也较为巩固。

关于阴虚、津伤也会出现在温胆汤证中与痰热并见，并对该证产生重要影响的情况，也并非是不可思议的。可以从下面三个方面进行推理和讨论。

1. 倘因有热（包括虚热和实热）而生痰者，要注意是否有伤阴现象。因热而生痰者，热是矛盾的主要方面，邪热一方面可以灼液为痰，另一方面又会伤津耗液，具有两重性。人体阴液亏损，则邪热更炽；邪热一炽，则更易熬炼津液而为痰浊。几者相互之间是一环紧扣一环的，不顾及津液之亏，显然是不行的。邪热能伤津，生津能熄火，尤在泾就注意到了这种辨证关系在痰热诸症的治疗中也仍然起着作用，他说：“肺虚阴涸枯燥，日至气不化而成火，津液结而成痰，是不可以辛散，不可以燥夺，清之则痰自化，润之则痰自消。”

2. 平时阴虚火旺之体，虚火本易炼液为痰，这种体质又容易感受燥邪而出现燥痰，从而导致温胆汤证。从治病求本的角度来看，更应该根据津液亏损的程度，适宜地采用直接或间接地保津、生液，这对改善体质，治疗痰热，防止转化等有着不可忽视的积极作用。

3. 对火热的治疗，热宜清，药须凉，过凉又易伐生气，火应直折，药当苦寒，过用苦寒，又有化燥之弊。因此，清热泻火药物的副作用之一，就是化燥伤津。如果使用不当，加减失宜，则难免有此弊病。前人对温胆汤的组成是颇为赞赏的，对方中以枳实、竹茹凉性药物与半夏、陈皮温性药物相配伍，有着清热而不寒，化痰而不燥之誉，这种巧妙的配伍形式，并不意味着任意使用都无伤津耗液之弊，相反，这种配伍形式恰恰会启发我们清热而不要伤津，化痰而不要燥液。不然的话，称赞该方不寒和不燥还有什么意义呢？

在上述三种情况中，都要随时注意到伤津的情况，不能等到痰去热微而津亏独存之后，才去考虑治疗伤津的问题。要防微杜渐，才能减少变症，缩短疗程，少损正气，尽快恢复，否则，痰既

难去，热亦难微，何况常常等不到痰去热微，就会因津亏而导致其他变症。这里举一例疗疮治验来说明这个问题。

曾××，男，64岁。病员鼻上生疔，红肿漫延整个鼻梁，疼痛，口苦，口渴，心慌，胸闷，脉洪大而数，服苦寒清热解毒药已一周，疮肿仍有漫延之势，疼痛却无减轻之感。苔黄腻，又增干呕之症，胸闷，不欲食更甚。此案邪火、痰热与津伤并见，其中邪火是痰热和津伤的成因，用苦寒无效，是因为没有顾及到痰热和津伤。当三者并存时，往往互为因果，不治其痰，气机难以舒展，中焦难以运药，清热生津之药难以起到应有的作用。所以，前用清热解毒之剂自是枉然，反增干呕胸闷等症。火能伤津，生津又能熄火，当加入清热生津之品，如生地、玄参、麦冬一类，不仅在治疗邪火上有用水熄火之意，且于津伤之症的恢复也有实际意义。拟将泻火、化痰、生津溶于一炉，方用温胆汤加味：陈皮10克，枳实12克，法夏10克，茯苓10克，甘草6克，竹茹10克，黄连6克，野菊花30克，生地15克，麦冬12克，玄参15克。水煎服。一剂痛减，二剂肿消，三剂疮愈。

临床上也常可见到气阴两亏的温胆汤证，往往不能确切地了解是因虚生痰，还是因痰致虚，但只要虚实并见，我都注意使用通补兼施法以治之。举一心悸病例以说明。

谢××，女，45岁。1977年6月上旬，病员两年来经常出现短暂心动悸，胸闷难受的现象。近来每日心动悸达7、8次，且连续发作半月余。脉初触类动，不满30即无力而短，舌苔薄，根黄腻，口苦，夜梦多，有时失眠。乃痰热内扰，心气不足，用温胆汤加党参、枣仁、远志、菖蒲、黄连。6月底，上方服至6剂，症有好转，更配生脉散：人参叶60克，五味子18克，麦冬30克，每日一撮泡开水代茶饮。8月，心动悸基本控制，短脉明显好转，且搏动力量增加。至今未曾有类似过去的明显发作。此例痰热内扰，阻滞气道，久之则心气不足，故脉短无力，初触类动。用生脉散之意，不仅是因为时值炎夏，更因为该病员体质清瘦，常见阴虚火旺，何况脉无力而短。气旺能行，津充则润，不仅有利于正能胜邪，而且合乎治病求本的精神。我体会到这种处处顾及扶正的治法，见效快，疗效也较为巩固。

戴思恭说：“故善治痰者，不治痰而治气，气顺则一身津液亦随气而顺矣。”不少人认为，这是指在治痰方中加些理气药，有助

于化痰，我认为还不仅仅如此。气顺则一身津液亦随气而顺，不是理气一法所能达到的。中医的各种常法和变法使用的目的，都是为了调理人体气机使之顺，在阳气亏损的情况下，不补其气，气机是难以顺畅的，在津液耗伤的情况下，不滋补津液，气机亦难以顺畅，这个道理对于中医学术来说，应该是不难理解的。中医的正虚，从现代医学观点来看，包括各种原因所致的机体衰弱和各个系统、各种性质疾病的虚弱表现，包括神经系统和脏腑功能失调，内分泌、代谢的功能障碍等。补正的治疗作用，包含有调整脏腑功能以及神经系统、内分泌、代谢系统的功能，补充支持机体和增强非特异性抗病能力等多方面的意义。另一方面，从现代药理研究的成果来看，中医补正的药物并非单纯仅能补正，还有直接和间接的祛邪作用。间接的祛邪作用，如党参、黄芪、麦冬、玉竹、白术、茯苓等，有促进自身免疫或获得性免疫等功效，能提高病员抗病能力。人参、五味子具有适应原样作用，即具有增强机体适应体内外环境的不利变化的作用。直接的祛邪作用，如黄芪体外试验，对志贺氏痢疾杆菌、溶血性链球菌、肺炎双球菌、金黄色葡萄球菌等有抗菌作用。麦冬对葡萄球菌、大肠杆菌及伤寒杆菌也有较强的抑制作用。五味子对炭疽杆菌、金黄色葡萄球菌、白色葡萄球菌、肺炎杆菌、伤寒杆菌、痢疾杆菌、霍乱弧菌，皆有不同程度的抑制作用，对绿脓杆菌有较强的抗菌作用。所以，温胆汤证不论是出现在急性病，还是出现在慢性病，一旦出现了正虚的情况，选用相应的补正药物具有双重意义。既能补正以祛邪，又能加强直接祛邪的作用，何乐而不为呢？与此相应，在正虚的情况下，不配以相应的补正药物，只能更加削弱机体的抗病能力，难以取得满意的疗效。

无虚议补是错误的，有虚不补也是错误的，补正可以祛邪，

祛邪可以安正，因此，用温胆汤清化痰热，和胃降逆，清静胆腑，只要用得恰当，本身即是一种祛邪以达到扶正的方法，这点必须注意，不要由一个极端走向另一个极端。

温胆汤在配合补气、温阳法时，一定要注意辨证准确，“恐炉烟虽熄，灰中有火”的警惕一定要有。当与生津滋阴法相配伍时，也一定要想到“清热太过，留湿致困，养阴不当，反成蒙蔽，见证施治，用药最难。”（陈光淞对叶氏上条的阐述）要把这些配伍看作难事，而处处加以小心；看得太容易了，又往往会不顾厉害引起变化，或死灰复燃，或反成蒙蔽；看得太死了，又会束缚手足，错过时机，削弱正气，为邪张目，所以要小心对待，仔细推敲，方不致误。

浅谈以神和以药养胎

据我多年来的临床观察体会，感到孕妇养胎不可小视。对于孕妇养胎，我强调应注重生活起居、饮食、情志、药物等多种方面。这里仅就神养和药养两个方面，谈谈我的一些体会。

一、神 养

神养，即以神养胎。神养的实质，就是调七情，要孕妇随时调节自己的情志，使之宁静，而不躁扰，从而能对胎儿的发育产生良好的影响。《史记》说：“太伍有娠，目不视恶色，耳不听淫声，

口不出傲言。”这是关于孕妇妊娠神养最早的记载。《便产须知》说：“勿乱服药，勿过饮酒，勿妄针灸，弗向非地便，勿举重、登高、涉险，心有大惊，犯之难产，子必癫痫。”《巢氏病源》说：“妊娠三月名胎始，当此之时，血不流行，形象始化，未定仪，因感而变。欲子端正庄严，常口谈正言，身行正事……欲子美好，宜佩白玉，欲子贤能，宜看诗书，是谓外象而内感者也。”这种通过不听淫声，不出傲言，不登高，不涉险，使孕妇保持心情宁静；通过谈正事，佩白玉，读诗书等方法，加强孕妇的品德修养，培养高尚情操，保持良好的精神状态，可使胎儿未来智力发达，性格端庄，避免胎儿发育缺陷的说法，是有一定的科学道理的。在妊娠期间，胎儿在胞宫内，仰赖母体气血阴阳的滋养而生长发育，孕妇的精神和心理状态的异常和失度，都将会影响到气机和气化的失常，导致气血阴阳的紊乱，胎儿受此异常精气的影响，其发育就必然会受到干扰。中医学认为，如果情绪的变化超出了常度，就会导致气的正常生理功能紊乱，而产生一系列的病变。如《素问·举痛论》说：“怒则气上，喜则气缓，悲则气消，恐则气下，寒则气收，炅则气泄，惊则气乱，劳则气耗，思则气结。”另外，不同的情绪过度，将伤及不同的脏腑，产生不同的病理变化，如《素问·阴阳应象大论》就提出：喜伤心、悲伤肺、恐伤肾、怒伤肝、思伤脾等论点。试想，由神而伤及气机、气化、内脏的孕妇，其胎儿何以会处其间而不受影响呢！

《素问·上古天真论》说：“恬淡虚无，真气从之，精神内守，病安从来。”孕妇在怀孕期间能保持心情舒畅，情绪稳定，生活有规律，注意营养和休息，保持良好的心理状态，就必然有益于胎儿的良好发育。我认为，所谓的“恬淡虚无”，并非是什么事情都不想、都不做，这对于一个生存着的人来说，也是根本不可能的

事情。从积极方面说，应当是使自己达到“德全不危”的境界，才能真正做到“淡泊以明志，宁静以致远”的、有利于身心健康的“恬淡虚无”。思想纯洁，无多杂念，就不会患得患失，胸襟开阔，在任何顺或逆的环境中，都能保持情绪稳定，愉快而宁静地生活。成语所谓临危不惧、视死如归、威武不能屈、富贵不能淫等，都是这种心境在不同情况下的具体体现。

心境是指一个人经常保持的一种比较持久的情绪状态。现代心理学认为，心境并不是某种不能控制的东西，树立对有价值的肯定的东西的信念来驾驭不良心境是完全可能的。现代心理学还认为，意识到行动的目的以及想到将要获得的东西，是意志行动的主要因素，意志行动始终是自觉的行动。因此，提倡妇女向历史上的优秀人物的高尚品质、磊落情操学习，这对保障母亲、儿童的身心健康，提高人口质量，保障民族兴旺发达均有着重要的意义。对于妇女，我主张根据各自的性格、气质、能力、兴趣、爱好、理想、信念等情况，多接触美好的事物，培养自己对日常简单事物的欣赏能力及乐趣。听听轻松的音乐，欣赏优美的风景，观看花卉，阅读有益于身心的文学著作。要能控制自己的情绪，要善于摆脱恶劣的情绪，学会情绪的积极转移，就是要设法使自己的思绪转换到更有意义的方面去。在日常生活中，不要老是担心自己生病，过分地担心反而会带来疾病。在家庭生活中，要和睦相处，尊老爱幼；对社会活动要积极参与，不要有自卑感、压抑感，要以社会主人翁的姿态出现。这样就能保持精神饱满，正气内守，阴平阳秘。另外，人的生活有三分之一以上的时间是在职业活动之中，因此，热爱工作，忠于职守，无私、勤奋、谦逊、大度、顽强、坚定等优良品质，则更使人接近德全不危境界的一个重要方面。而在工作中失职、利己、傲慢、浮躁、固执、虚伪、狡诈、

偏狭等不良品质，不仅会使人碌碌无为，而且使人心情不易平静。前人说“胎教即是宁静”，试想那些争名于朝、争利于市的人，心境何以会得到宁静？

身心兼顾，神形同治，亦是中医诊治疾病的重要特点之一。《内经》认为临诊应从治神入手，且应以治神为本，故一向强调病员的精神和意志的作用。如《灵枢·师传篇》说：“告之以其败，语之从其善，导之以其所便，开之以其所苦。”从而解决病员情志和思想上的问题，促进疾病向愈。我认为，医生应该深刻理解语言的作用，利用语言具体的内容，去引导病员的思想情绪与生理活动向有利于疾病向愈改变。但是，如果仅仅强调不给病员以恶性刺激，把病员当作被动的对象，而加以“保护”，也是不行的，这仍是消极的方法。比如周围亲人渴望她有个孩子，一旦她怀了孕，就给予特殊照顾，以致造成她特别“娇气”，产生各种主诉，这显然不利于胎儿正常发育。前辈医家非常重视“以情胜情”的心理治疗。《后汉书·方书列传》华佗传记载，佗治一郡守笃病久，佗留书骂之，太守大怒，吐血数升而愈；朱丹溪医案曾载一女子，病不食，医告术穷，丹溪诊之，知“思男子不得，气结于脾”，乃怒之，诈之，使病愈；张从正《内伤形》数案，皆用精神疗法，不药而愈。我觉得研究并运用这些由于某一种情绪过甚而形成的不平衡，激发另一种可以战胜它的情绪，使之平衡，乃是积极的办法。所以，我主张在孕妇就诊和检查时，医生要多从治神入手，采取积极的办法，加强孕妇的意志锻炼，并引导到一定的方向上去，将有利于开阔心胸，控制情绪，提高适应能力，保持心情平静。这对于孕妇、胎儿的身心健康都有着非常积极的意义。

有人根据现代医学的观点，认为妊娠胚胎器官形成期，即停经后27~70天，此时正值胚胎各器官发育形成阶段，要特别注意

神养。我根据临床和对社会生活的观察，发现妊娠三月后，由于种种原因而导致孕妇精神变化，从而影响到胎儿身心健康者，也不是少数。因此，孕妇整个妊娠期都应该重视以神养胎。

二、药 养

药养，即以药养胎，前人有慎药之说，乃慎重用药之意，并非不用。孕妇患病，即当治病，服药疗疾，不属于药养范围。以药养胎，乃指孕妇在一般无疾的情况下而言，而药养主要可分为两个方面：

1. 对妊娠分阶段进行药养

前人有逐月养胎之说，我认为此说颇有道理，故也提倡分阶段进行药养，不过具体方法因来自自己的临床体验，故与前人有异。

(1) 妊娠一月，有初妊反应时，即当用藿香、紫苏、砂仁、芫荽煎汤，盛入茶壶之中时时嗅之，既能治疗恶阻，又能通畅胎气，有益于胎儿与母体气机流通。素体面白气虚之人，亦可用桂枝汤煎汤入壶，效亦佳。

(2) 妊娠三月后，每月可用人参3~5克，切成薄片，每日嚼服1~2片。《本经》说：人参“主补五脏，安精神，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。”现代药理研究成果能证明上述结论者多矣。因此，孕妇适当服用人参，有益于胎儿元气充沛，智力发育，五脏协调，出生后不仅活泼聪明，精神充沛，适应能力强，且抗御六淫七情的能力亦强。

(3) 妊娠四月后，可用藏青果3~5颗，炖猪肚子服2~3次，以清胎热。将来小儿痘麻稀，平时少生疮，也就是说可以减

轻胎毒所致的诸种疾病程度。

(4) 妊娠五月，可用当归 60 克，杜仲 30 克，菟丝子 30 克，淮山药 60 克，龙眼肉 30 克，续断 30 克，党参 30 克，水煎服，服 2~3 剂，若在暑天可适当减量。就现代医学观点来说，妊娠三月以后，此时大多数器官虽俱已成形，但生殖系统、牙齿、神经系统仍在继续发育中，而此方能针对上述发育有促进作用。本方强腰脊，健筋骨，益肾精，补气血，畅血脉，颇适宜这个阶段的胎儿发育。

(5) 在妊娠后期，当出现足肿时用鲜鲤鱼 0.5~1 斤，熬汤，加少许胡椒、姜、葱服食，每月 1~2 次。《本草拾遗》说：鲤鱼“主安胎，胎动，怀妊身肿。”据历代文献记载，用鲤鱼治子肿、子气、子满者，不是少数。将它用于临床，疗效确切，作为药养，安胎消肿，两相兼顾。

2. 针对孕妇体质进行药养

(1) 气短，多汗者，可常用生脉散，泡开水代茶饮。其中还可酌情选用红参、参须、人参叶、太子参、潞党参等。

(2) 面白，肌肉不丰者，可用潞党参、莲米、淮山药、白扁豆、杜仲、沙苑蒺藜、菟丝子、当归、黄芪，水煎服或炖肉食服。

(3) 舌淡，头晕者，可用熟地黄、淮山药、潞党参、枸杞、黄芪、当归、玉竹、芡实、巴戟，炖鸡食服。

(4) 体弱瘦小，舌上苔少者，可用冬虫夏草、生地黄、熟地黄、淮山药、沙参、玉竹，炖鸭子食服。

(5) 平素体丰个大者，常有身重带下之人，可用厚朴、川芎、当归、菟丝子、羌活、荆芥、枳壳、白芍、甘草，水煎服，有热时，加素茶、黄芩。

以上药养，可一月半至二月服用一次，均有助于克服孕妇体

质偏差，从而给胎儿带来有利的影响。

另外，孕妇每次洗澡时，可用桂枝 10 克，加入水中煎至水色变桂枝色，用此水沐浴。沐浴后，每增舒适感。桂枝辛甘温无毒。《本草求真》说：桂枝“入肌表，兼入心、肝”，能温经通脉，和肌表，发汗解肌。外用沐浴，则直接作用于肌表；盖孙络满布腠理，桂枝温通，能借孙络以畅通表里气机，和利气血，有利于孕妇与胎儿之间的气血周流和新陈代谢；且能和肌表，实腠理，加强防御外邪；其发汗解肌的作用，又能直接祛除留于肌表之邪气，这邪气即指外来入侵者，又指体内代谢产物留于体表者。正因为它有这样多方面的作用，故用桂枝煎水沐浴后，孕妇每感轻爽。

肝气肝阳虚的理法方药

在治肝诸法中，历来强调清肝、疏肝、平肝、镇肝、泻肝等法，而论补肝者少，其中论补肝气、补肝阳者尤少。近年来，关于肝气肝阳虚的证治不断有人提出，但对其实践意义还阐述不足，这样一来，这个理论就有成为无根之木的危险。事实上，不少同道亦认为此纯属理论问题，而根据这些论述，临床医生对肝气肝阳虚也确较难进行诊断。另外，由于肝脾之间关系密切，《内经》亦有“厥阴不治，求之阳明”之说，所以，历来对补肝和补脾在气、阳这方面就更难区分。这里，我就这些问题谈谈自己的一些意见。

中医的理法方药，是一线贯穿的，兹分别论述于下：

一、理

秦伯未在《论肝病》中指出：“从整个肝脏生理来说，以血为体，以气为用，血属阴，气属阳，故称体阴用阳。故肝虚证有属血亏而体不充的，也有属于气衰而用不强的，应该包括气、血、阴、阳在内，即肝血虚、肝气虚、肝阴虚、肝阳虚四种。正常的肝气和肝阳是使肝脏升发和条畅的一种能力，故称作‘用’”。从理论上来说，肝之“体”为“用”的物质基础，肝之“用”为肝脏升发疏泄的一种正常生理功能，因此，肝虚证既会出现“体”不足，也会出现“用”不足。“体”不足而“用”却有余，而这种有余又不是相对的，而是实在的，这种认识，无论在理论上还是在实践上都是荒谬的。所以，肝有气、血、阴、阳四者之虚，缺一不可！在《内经》中，从生理上和病理上谈到了肝气虚和肝阳虚的问题。第汉及唐宋，对肝气肝阳虚的证治都有进一步的研究，如在《千金方》、《圣惠方》、《直指方》、《永类铃方》、《简要济众方》等书中，都专门论述了肝之虚寒证治。自金元以后，随着火热学派的蓬勃兴起，这一当时中医学学术发展的总趋势，必然会影响到肝病学说的发展和研究。火热学派“六气皆从火化”，“阳常有余，阴常不足”的基本观点，促使了人们对《内经》“肝为将军之官，厥阴内寄相火”的片面吸收，这就使人们忽略了对肝之虚寒证治的研究，直至温病学派盛行的明清时代，基本情况也是这样。尽管如此，肝气肝阳虚的问题，仍断续有人论及到，为什么这源远流长，古今又通过临床实践检验过的理论，会被长期忽视呢？我想，除上述原因外，其主要的还有以下几点：

1. 前人对于肝病虽然有深入的认识，但在名词方面有很多含

义不明确，有些本来明确的又为后来所误解。如肝气、肝阳，既是生理和病理名词，又为病名，目前均作病理和病名，极少考虑生理方面。此外，由肝脏病变引起的其它脏腑病症，或由其它脏腑病症牵涉到肝的症状，也往往称为肝病，主次模糊，因果颠倒，从而造成了概念上的混乱。因此，肝之气虚阳虚，也往往被混入到脾肾等脏之气虚、阳虚中去了。

2. 基于上述原因，建国以来的有关教材，从理论和治疗上都否认了气虚和阳虚的存在。如《中医内科学讲义》（上海中医学院主编，1965年）在肝病辨证施治要点中指出：“肝为刚脏，属春木而主风，性喜升发，故肝病多见阳亢的症候。肝之寒证，仅见寒凝少腹厥阴经脉。”中医学院试用教材《内科学》（上海中医学院主编，1975年）在虚劳病气虚中曾说：“至于肝病中多见气郁之证，若肝病累及于脾而见神疲乏力，食少便溏可按脾气虚论治。”这就从理论上基本否定了肝气肝阳虚，而一般中医基础理论的书籍也都持这种看法。

3. 由于对肝病概念认识上的混乱，以及其他因素的干扰，所以对肝气肝阳虚的诊断上就显得杂乱，不易使人理出头绪，且多和其他脏腑病变相混淆，这就为临床运用这个理论产生了一定的困难。

我的看法是，应当正视肝气虚和肝阳虚的客观存在，肝无气虚阳虚的认识，是会危害临床实践的。由于理论上缺乏对肝气虚、肝阳虚的认识，在临床上对一切肝病概认为实证，而虚证者只属于肝阴虚，并且对肝阴之补，是多从乙癸同源着手。既然肝病以阳症实证为多，虚证仅见于阴虚，那么，一见肝病恣用攻伐，迭进苦寒，是用这种有缺陷理论指导的必然结果。滥用攻伐、苦寒的结果，往往引起气虚或阳虚证，由于理论上又无肝有气虚、阳虚的明

确提法，所心，往往直至气虚，阳虚症候明显以后，才又转弯抹角地混称补脾气、补脾阳。可见肝无气虚阳虚之说，于治于防均有弊病。

有人说，只要注意到见肝治脾，就可以弥补这个缺陷。实际上那些治肝病牢记“见肝之病，知肝传脾，当先实脾”的人，也还是要吃到肝无气虚、阳虚理论的苦头。临床上，常可见到气虚、阳虚型的目疾、眩晕、痛经、月经不调、胁肋痛等与肝密切相关的疾病，饮食如常，纳化正常，却又疲乏不耐劳累，气短面白，但又无腰痠腿软之肾虚症候。病位既不在脾、肾、心、肺，自然就在肝无疑。这类肝病，如果要议益气温阳，却师出无名，因为肝无益气温阳之理，所以不敢补，也不能补。此举一例：

叶××，男，42岁，干部。病员胁肋胀满微痛二月余，口苦，心烦，夜寐多梦易惊，疲乏无力，食欲及消化均正常。经多方医治，都认为病变部位在肝，因肝无补气之法，虽有不足之症，仍以疏肝养血为主，故用四逆散、柴胡疏肝散、逍遥散等方加减调治，更增有时心悸一症。经我诊时，症状同前，两关脉弦细，两寸不足，此乃肝气不足之象，当用补气之药以治之。处方：党参15克，黄芪20克，酸枣仁15克，生地12克，白芍12克，杭菊花10克，茯神12克，柴胡6克，水煎服，服四剂即愈。

由此可见，虽牢记当先实脾，也还是要受到这种理法之缺陷的影响，而使方药不能丝丝入扣，从而给病员带来很大的痛苦。提出肝有气虚、阳虚，也有益气温阳之法，这样就更加严密了中医的脏象理论，也丰富了肝病的治法，对于纠正过度攻伐，恣行苦寒等错误作法，是大有补益的。这样对那些无心、脾、肺、肾气虚、阳虚，而又有肝病症状之种种证型的治疗，可以言正名顺地议补，用补，而对于肝之实证、热证的治疗时，则可因肝有气虚、阳虚而时_（时兼顾到，不致于矫枉过正，能够防患未然。

根据我的临床体会，结合对历代文献的复习，依据传统中医诊断的习惯和方式，我在临床上对肝气、肝阳虚的诊断主要是从

以下几个方面进行：

1. 首先决定是否为肝病，大致可从以下几点进行：

- (1) 以肝脏功能、体征、病因的特点去进行归纳；
- (2) 从病员的体质、发病的时间等具体情况去进行归纳；
- (3) 根据肝经循行的部位和肝脏归属的部位去进行归纳；
- (4) 从脏腑间相互演变的关系和特点去进行归纳。

通过从上述诸方面分析，如果病变部位在肝，那么就转入下步。

2. 然后决定是否为肝虚

肝有气血阴阳之虚，四者都有共同的虚症，肝脏富有特征性的虚症有：病者恍惚，妄见，悵悵不乐，如人将捕之，易怒善恐，心烦，胸胁满闷胀痛，小腹痛，口噤，筋挛拘急，身体麻木，指甲枯萎，视物不明，眼生黑花，头晕欲仆，耳鸣，目眩，目涩，雀盲，寒热如疟，月经后错量少，脉弦细而弱，或如张锡纯所说的“左脉微弱不起”，“左足太弱”。但这些症候并非需要全部具备，只要出现其中数症，即可诊断为肝虚。其中，肝虚和其它脏腑发生影响所表现的症状，这里未备。

当诊断为肝虚后，即可进行下步工作。

3. 最后再区别是气虚，还是阳虚

肝为人身五脏之一，肝气为人体元气之一，肝阳亦为人体元阳的一部分，所以，肝之气虚和阳虚与整个人体的气虚和阳虚并无本质差异。之所以肝不为脾、肺、心、肾，其根本区别点在于上述两项。

(1) 气虚：气短懒言，语言低微，倦怠无力，食欲不振，自汗，舌胖质淡苔少，脉虚无力等。其中尤以身疲乏力，脉弱无力为最主要的症状。

(2) 阳虚:形寒怕冷,肢末欠温,神疲乏力,阴囊冷,筋缩,倦怠喜卧,舌质淡胖而湿润,这些为诊断的主要标准。一些次要的症状,为面色㿔白,大便溏薄,小便清长或夜间尿多,面浮肢肿,脉沉迟,虚软无力等。

综上所述,肝气虚或肝阳虚的诊断步骤和要点是:首先必须决定是否为肝病,然后,再判断是否为肝虚,最后再根据是否出现整个人体所能共见的气虚或阳虚症候,从而得出倒底为肝气虚或肝阳虚的结论。如果按照这种传统中医诊断规律去对待临床,就会发现肝气肝阳虚在临床上并非罕见,而是一种常见的证型。

二、法

实则泻之,虚则补之,肝气肝阳虚当如何补之呢?

《内经》说:“肝欲酸。”“肝苦急,急食甘以缓之。”《难经》说:“损其肝者缓其中。”《金匱要略》说:“肝之病,补用酸,助用焦苦,益用甘味之药调之。”可见补肝以酸甘为主,因此,补肝气、肝阳,当以酸甘温养为主。另外,《内经》曾指出:“肝欲散,急食辛以散之,以辛补之,酸泻之。”我认为,这是根据肝喜条达,主疏泄的特性和生理,采取以散为补的治法,这就启示我们在补肝气、肝阳时,酸甘温养固为大法,倘不注意辛散之法是不行的。事实上,肝气肝阳虚的临床见症,多见肝失条达疏泄,补肝气肝阳之品,亦多具辛散之性。观历代补肝气方剂,就可以更深刻地体会到这点。

补气之品,本多甘温,补肝气亦难例外。肝主疏泄,肝气为肝“用”,肝“用”即疏泄,因此肝气虚要寓疏于补之中,才能伸运疏泄,不然补会壅滞。至于肝阳虚,温阳之药多辛温,因阳比

气更进一层，根据历代先哲的论述，善补阳者，当于阴中求阳。

综上所述，其治疗原则当为：

1. 补肝不离酸；
2. 补肝气以酸甘温养为主，辛温为辅，注意寓疏于补之中；
3. 补肝阳以酸辛温养为主，甘温为辅，注意从阴中求阳。

三、方

这里摘录一些前人对肝气肝阳虚论治的一些方剂，所选录者，都是经过我临床运用，确有疗效的。

《济生方》柏子仁汤

治肝气虚寒，两胁胀满，筋脉拘急，腰、膝、小腹痛，面青口噤。

柏子仁(炒)30克 白芍药30克 防风(去芦)30克
茯苓(去木)30克 当归(去芦，酒浸)30克 芎藭30克
附子(炮，去皮)30克 细辛(洗去土叶)15克 桂心(不见火)15克 炙甘草15克

上药锉碎，每服12克，水一盏半，姜5片，煎至七分，去渣，温服，不拘时候。

《济生方》续断汤

治肝劳虚寒，胁痛胀满，关节疼痛挛缩，烦闷，眼昏，不食。

川续断(酒浸)30克 芎藭30克 当归(去芦，酒浸)30克 橘红30克 半夏(汤泡七次)30克 干姜(炮)30克 桂心(不见火)15克 炙甘草15克

上药锉碎，每服12克，水一盏半，姜5片，煎至七分，去渣，

温服。

《圣惠方》治肝虚补肝诸方

治肝脏虚寒，头目昏疼，四肢不利，胸膈虚烦，宜服补肝防风散方：

防风(去芦头)30克 芎藭0.9克 黄芪(锉)0.3克 五味子0.9克 人参(去芦头)0.9克 茯神0.9克 独活0.9克 羚羊角屑0.9克 前胡(去芦头)0.9克 细辛15克 酸枣仁(微炒)15克 甘草(炙微赤，锉)15克

上件药，捣筛为散，每服9克，以水一中盏，入枣3枚，同煎至六分，去渣，不计时候，温服。

治肝虚，头目不利，心膈多烦，筋脉急痛，宜服补肝甘菊花散方：

甘菊花0.9克 前胡(去芦头)0.9克 防风(去芦头)0.9克 决明子0.9克 黄芪(锉)0.9克 沙参(去芦头)0.9克 枳壳(麸炒微黄，去瓤)0.9克 羚羊角屑0.9克 车前子0.9克 枸杞子0.9克 细辛0.9克 酸枣仁(微炒)0.9克

上件药，捣细罗为散，每服不计时候，以粥饮调下3克。

治肝虚寒，面色青黄，胸胁胀满，筋脉不利，背膊酸疼，羸瘦无力，宜服补肝柏子仁丸方：

柏子仁30克 黄芪(锉)30克 白茯苓30克 楮实30克 覆盆子30克 五味子30克 附子(炮裂，去皮脐)30克 石斛(去根)30克 酸枣仁(微炒)30克 鹿茸(去毛，涂酥炙令黄)30克 桂心30克 白术30克 沉香30克 枳实(麸炒令黄)30克 熟干地黄30克

上件药，捣细罗为末，炼蜜和捣三二百杵，为丸如梧桐子大，每服30丸，以温酒下，空心及晚食前服。忌生冷油腻。

《圣惠方》治肝气不足诸方

治肝气不足，筋脉不遂，心膈壅滞，左肋妨胀，不思饮食，宜服白茯苓散方：

白茯苓30克 前胡（去芦头）30克 桂心15克 黄芪（锉）30克 白术30克 沉香30克 鳖甲（涂醋炙微黄，去裙襕）30克 生干地黄0.9克 五味子0.9克 枳实（麸炒微黄）15克

上件药，捣筛为散，每服9克，以水一中盏，入生姜0.15克，同煎至六分，去渣，不计时候，温服。忌菹菜。

治肝气不足，则伤胆，胆伤则恐惧，面色青白，筋脉拘急，目视不明，宜服酸枣仁散方：

酸枣仁（微炒）30克 枳实（麸炒微黄）60克 五味子30克 白术30克 白茯苓30克 泽泻30克 芎蒭30克 麦门冬（去心）30克 黄芪（锉）30克 甘草（炙微赤，锉）15克

上件药，捣筛为散，每服9克，以水一中盏，煎至六分，去渣，不计时候，温服。

《神巧万全方》治肝虚方

治肝虚寒，色面青黄，胸胁胀满，筋脉不利，背膊酸疼，羸瘦无力，宜服益肝双补丸方：

细辛30克 酸枣仁（微炒）30克 白茯苓30克 楮实子30克 覆盆子30克 五味子30克 附子（炮）30克 石斛（去苗）30克 破故纸（炒）30克 鹿茸（去皮，酥炙令黄）30克 肉桂30克 白术30克 沉香30克 枳实（麸炒令黄）30克 熟干地黄30克

上件药杵罗为末，炼蜜丸，如梧桐子大，每服30丸，空心早晨晚食前温酒下。

治肝藏虚寒，头目昏疼，四肢不利，胸膈虚烦，宜服补肝散方：

甘菊30克 茯神9克 芎蒭9克 细辛9克 五味子9克 人参9克 独活9克 羚羊角屑9克 白术9克 肉桂9克 酸枣仁（微

炒)9克 甘草(炙)15克

上件药，杵罗为散，每服9克，以水一中盏，入枣3枚，同煎六分，去渣温服。

《简要济众方》论肝脏病

治肝脏虚寒，面青黄色，两胁胀满，筋脉不利，背膊疼痛，瘦乏无力，宜服补虚覆盆子丸方：

覆盆子30克 五味子30克 附子(炮裂，去皮脐)30克 酸枣仁30克 白术30克 熟干地黄15克

上件药，同捣罗为末，炼蜜为丸，如梧桐子大，每服20丸，空心食前温酒下，米饮亦得。

《千金方》肝虚寒

补肝汤：治肝气不足，两胁下满，筋急，不得大息，四肢厥冷，发抢心腹痛，目不明了，及妇人心痛，乳痛，膝热，消渴，爪甲枯，口面青者方：

山茱萸90克 甘草90克 桂心90克 桃仁60克 柏子仁60克 细辛60克 茯苓60克 防风60克 大枣24枚

上九味锉碎，以水9公升，煮取5公升，去渣，分三次服。

补肝散：治左胁偏痛久，宿食不消，并目眵眵昏，风泪出，见物不审，而逆风寒偏甚，消食破气止泪方：

山茱萸1.5克 桂心1.5克 薯蓣1.5克 天雄1.5克 茯苓1.5克 人参1.5克 芎藭2.1克 白术2.1克 独活2.1克 五加皮2.1克 大黄2.1克 橘皮9克 防风45克 干姜45克 丹参45克 厚朴45克 细辛95克 桔梗45克 甘草30克 甘菊花30克 贯众15克 陈麦曲1公升 大麦蘖1公升

上二十三味，治下筛，酒服3克，日二若食不消，食后服，

若止痛，食前服之。

枸杞酒：补肝治肝虚寒，或高风眼泪等杂病方。

捣碎枸杞子 10 公升，先内绢袋中，酒 20 公升渍讫，密封泥瓮，勿泄曝干，天阴勿出，三七日满，旦温酒任性饮之，忌酢。

《医方大成》五脏内外所因证治

三因方枳壳煮散：治悲哀伤肝气，痛引两胁。

防风(去芦)120 克 川芎 120 克 细辛 120 克 枳壳(麸炒) 120 克 桔梗(炒)120 克 甘草(炙)60 克 干葛 45 克

上药咬咀，每服 12 克，水一盂，姜 3 片，煎七分，空心服。

三因方枳实散：治肝气不足，两胁疼痛。

枳实 30 克 白芍药(炒)15 克 雀脑芎15 克 人参 15 克

上药为末，每服 6 克，姜盐汤酒任下。

《新效方》

五补汤：治心肝脾肺肾

莲子 枸杞子 山药 锁阳

上四味末之，沸汤调服，加酥尤妙。

仅从上述前人方中，就可以看出，这些方剂在组方上，是与“法”中关于补肝气肝阳三条原则相吻合，各方中所选药物，皆注意肝气疏泄之性矣。

以上诸方，我皆用过，按法施之，确有疗效。如《济生方》柏子仁汤，我用于平素肝阳不足之人，外感风寒，出现筋脉拘急，面青口噤者，所谓口噤，乃寒战的表现症候之一，颇有良效。有一曾在井下工作过的病员，每次感受风寒，则见筋脉拘急，腰、膝、小腹、胁肋胸腹疼痛，脉弦紧，舌苔白腻且厚，四肢着重，欠温，神疲乏力，喜卧。每用此方才能治愈。又如《济生方》续断汤，载于该书五劳六极论治中，此节首言“盖尽力谋虑成肝劳，

应乎筋极”，续断汤治肝劳，尽力谋虑也可以是此方的病因，临床上有肝气不足之人，每遇焦灼之事，坐立不安数日，就出现胁痛胀满，烦闷，眼昏，疲乏，失眠，不思食，且更见关节筋脉挛缩，暖气，自觉咽中不舒，其脉舌有寒象者，用此方疗效确实。

总之，上述方剂，不论外感内伤，只要抓准病机，加减运用，不仅能够取得效果，且能启发思路。

四、药

肝脏本身阳气虚衰，功能减弱，应该属于虚寒一类证型。其治当重在温养，因此，选用药物和组合药物，须在补气养血中使用温药以助肝之升发之力，不能纯用或重用辛散通阳之品。王旭高补肝气用天麻、白术、菊花、生姜、细辛、杜仲、羊肝；补肝阳用肉桂、吴茱萸、花椒。从其选药情况来看，固然深悟肝以散为补之旨，却因此而忽视温养比温散更有益于虚寒治疗这个原则，所以有不尽吻合之处。

张锡纯说：“愚自临证以来，凡遇肝气虚弱不能条达，用一切补肝之药皆不效，重用黄芪为主，而少佐理气之品，服之复杯即见效验。”“曾治有饮食不能消化，服健脾暖胃之药百剂不效，诊其左关太弱，知系肝阳不振，投以黄芪一两，桂枝尖三钱，数剂而愈。”黄芪不但补肝气最为得宜，只要配伍得当，补五脏六腑周身之气皆得宜也。

《本经》说：人参“主补五脏，安精神，止惊悸，除邪气，明目，开心益智。”《药性论》说：“主五脏气不足，五劳七伤。”《纲目》说：“治男妇一切虚证。”因此，人参大补元气中，包括补肝气，所以，上列方剂中亦有选用人参者。

《长沙药解》说：“桂枝，入肝家而行血分，走经络而达荣郁。善解风邪，最调木气。升清阳之脱陷，降浊阴之冲逆，舒筋脉之急挛，利关节之壅阻。”前人用桂枝明言补肝阳者，也不是罕见。

由于气和阳之间常常是程度上的区别，所以补气和补阳只能大致区别，且事相互选用，这对补阳来说更为明显。兹就一般常用药物来说分列于下：

补肝气：人参(或党参、太子参代)、黄芪、甘草、白术、干姜、五味子、枣仁、枸杞、首乌、木瓜、桂枝、龙眼肉等；

补肝阳：肉桂、肉苁蓉、仙灵脾、鹿角(鹿茸、胶、霜)、巴戟天、菟丝子、锁阳、小茴香、葫芦巴、杜仲、川续断、附子、沙苑蒺藜、狗脊、牛膝、鹿衔草、韭菜子、紫河车等。

临床上，我选用补肝气、补肝阳药物的一般规律是：

1. 阳气与精血同亏者：鹿茸(鹿胶)、紫河车、菟丝子、沙苑蒺藜、枸杞子、海狗肾或羊肾、狗肾等；

2. 阳气不足兼痹痛者：巴戟天、淫羊藿、狗脊、牛膝、杜仲、川续断、鹿衔草等；

3. 阳气不足头目不利者：枸杞子、沙苑蒺藜、五味子等；

4. 阳气不足阳道不兴者：淫羊藿、锁阳、肉苁蓉、巴戟天等；

5. 阳气不足阴寒太盛者：附子、肉桂、桂枝、吴茱萸、小茴香、细辛等；

6. 阳气不足与脾虚共见者：附片、肉桂、党参、白术、黄芪、山药、芡实等；

7. 全身气虚者：重用党参、黄芪、锁阳、杜仲、肉桂等。其他兼挟情况，也就不再一一列举了。

五脏之间只有各自正常，并相互协调，才能维持正常的人体生命活动。肝为五脏之一，并非单独存在，它的生理和病理都会

和其他脏腑发生关系，因此，前举肝气肝阳虚的治疗方剂，都往往配有其他治则和药物。如果用教科书式分类的观点，去看前人的这类方剂，当然是会感到奇怪的，故而有必要强调一句：不能把肝脏孤立起来去研究。

第三部分 治 则

涩 法 刍 议

涩法的主要作用，是固滑收脱，用于制止滑脱症况的发展，使人体气血津液不再进一步耗散的一种治疗法则。而涩药就是具有固涩收敛作用的药物。涩法治疗的病症，大体为开肠洞泻、大便不固、便溺遗失、寝汗虚脱、喘咳上奔、久嗽亡津、精滑不禁、下血不已、崩中暴下等。涩以固脱，凡是针对固脱而设的法则，就是涩法。主要突出涩法的方剂，就是涩剂。涩剂的组成中，大部分方剂有涩药，有些方剂则没有，如玉屏风散、封髓丹、驻车丸、生脉散、当归六黄汤等便是。另外，剂型对涩法也很重要，比如吴茱萸打烂敷足心，可以收敛头汗、唾液，如果内服，则呈温中散寒的作用，无此收敛之功，反有温散之力了。炮制亦是产生和增强、减弱固涩作用的因素之一，如龙骨、牡蛎，煅后固涩作用就会增强。

虚脱证用固涩，从古至今在理论上早已明确，实践上又积累了丰富的经验，可资借鉴。这里主要谈谈我对实证用涩法的体会和看法。在中医书籍中比较占上风的说法，是涩法仅可用于虚者、脱者、病久者，为正虚无邪、滑脱不禁之症而设；凡初病、实病、

暴病，或正气已虚邪实未去者，当先攻其邪，不可误用涩法。比如热痢初起、伤食腹泻、火动遗泻、血热妄行等实热症候，虽正气已虚然邪实未去，均非固涩所宜；如果实证轻易使用涩法，则正气和邪气都会被堵住，往往转生其他变症，这就是常说的有敛邪之弊。对于这个问题，我的看法是，这样讲未免有些失之偏颇，与古今的临床实践不甚相符。我的体会是，所有的治则如果用之不当，都会使邪气更甚，正气更虚，而不独涩法才会使邪气留恋。相反的，涩法如果使用得恰当、适时，不唯不敛邪，反而能有助于祛邪扶正。倘若在临床上，一定要等到病久虚象毕露后，才使用涩法，是不是有点类似渴而后掘井呢？我看这个问题值得探讨。带下过多，咳嗽太频，淋下过度，痢疾太甚，对证适当选用一些固涩之品，以止咳、涩肠、固精、止带，是有助于减轻病人的痛苦。中医传统的观点，就认为涩药有寒热温凉之性，有攻补之用，除固涩作用外，还往往兼备有其他多种治疗作用，现代药理研究也了解到，不少固涩药物除收敛固涩作用外，还具有不同程度的抗菌消炎、滋补强壮、调整神经、血管等生理机能作用。因此，可以破除一些老框框，将辨证和辨病结合起来，将理论和经验结合起来，适当地选用一些与病症相符合的固涩药物，让涩法和其他治疗法则配合起来。这样，不仅有助于治标（如止咳、止淋、止带、止痢），而且有助于治本（如补养、抗菌、协调阴阳等）。如此两全之举，我们有什么理由弃而不用呢？

为了进一步说明这个问题，不妨以下焦湿热诸症的治疗为例，来加以说明。由于肾司二阴，肝络前阴，胆降于肠，膀胱通于尿道，所以，利尿通便乃是驱除下焦湿热行之有效的治疗法则。但是，通的目的并不在于通利，而是为了借通利以排出废物和病邪，从而恢复人体功能活动的正常和协调，因此，不能因为强调通而

走上另一个极端，忘记了涩。通因通用作为一种祛邪外出的手段，其作用原理并非单纯在于泻下大便和通利小便。泄泻在不断地下，遗精在不断地遗，都是在以通的形式不断地在排除湿热，但病症仍然不能消除。可见，中医学中通因通用的方药，其本身还具有治疗湿热的作用，即通过其他途径，对湿热产生遏止和消除的作用，并非单纯在于一个通字。常用来通下大便的大黄，其作用就不仅在于泻下，而且还能消导积滞，荡涤胃肠，推陈致新，活血化瘀，止血，清降邪火，釜底抽薪。根据现代药理研究，大黄对痢疾杆菌、伤寒杆菌、霍乱弧菌、大肠杆菌、绿脓杆菌、白喉杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌、肺炎双球菌、炭疽杆菌等，均有较强的抗菌作用。因此，大黄配伍在清热解毒利湿等方剂中，除了能通过通利大便，以利排邪外出外，还有加强清解解毒的作用。如果离开了大黄的多种作用，离开了其他清解利湿药物的作用，单纯通利大便，无异于没有用药之下泻一样，是不能有效地治疗下焦湿热的。

同理，固涩药物也并非是不分青红皂白，一味地只起收涩敛聚作用，不少固涩药物都具有不同程度的抗菌、生津、滋阴、强壮等作用，纯粹收涩的药物极少。比如山萸肉、乌梅、五味子、诃子、石榴皮、金樱子、五倍子等固涩药物，都有其不同程度和范围的抗菌或抑菌作用。赤石脂一类以涩为主的药物，又有吸附消化道的有毒物质，能起到一定的祛邪作用。其他如鸡冠花、椿根白皮等，传统上都用于湿热痢疾和湿热带下；龙骨、牡蛎、石莲子等，使用在邪气正盛的下焦湿热证中的例子，也是屡见不鲜的。总之，收涩药是能通过多种不同的扶正、祛邪以及缓解症状等途径，而起到固涩滑脱症状的作用。我们决不能简单地用收涩敛聚这一形式去囊括涩法和收涩药的全部作用，因而使用固涩药物并

不能说是完全截止和阻遏了邪气的出路，不能这样看待这个问题。

古人说，文武之道，一张一弛，弦拉紧了不松是会断的。用药治病，也当如此，一味通利，也会使正气大为消耗，反致为渊驱鱼。古人用药，在这方面有不少成法，值得借鉴。寓涩于通之中，方能通而不伤正；寓通于涩之中，才会使涩而不固邪。在下焦湿热证中，将固涩药与清利湿热药配合起来，只要配合得适当，就能相反相成，两全其美。前人治疗下焦湿热诸证，不论是自觉还是不自觉，都是使用了涩法和涩药的。清化湿热，通利膀胱，以治疗膏淋的主要方剂草薢饮（《医学心悟》）中，即有文蛤粉和莲子肉；治脾胃湿热下注膀胱的草薢分清饮（《直指方》）中，即有乌药、益智仁，二药相合乃缩泉丸。湿热痢中，常用方剂芍药汤（《宣明论》）中，主药是酸收之芍药，而张锡纯的化滞汤中，选用了酸收之芍药、山楂；变理汤中，有生山药、芍药。湿热下注扰动精室的遗精，《卫生宝鉴》用猪肚丸，方中就有牡蛎，而一般治疗湿热遗精之症，亦少不了要选用一些固涩药物。肝郁化热，湿热下注的带下病，《医学入门》用侧柏樗皮丸，方中有固涩之樗根白皮。张锡纯的易黄汤，亦用芡实、山药各30克；清带汤，用龙骨、牡蛎、山药以固涩。这些例子，都足以启发我们的思路。中药是使用复方，各种药物之间，有相互协调和相互制约的关系。另外，由于中药多为动物、植物和矿物，其结构不能与收敛的西药相比，其作用往往是多方面的，也就是说，一味中药也常是一个复方，而方剂的组成，又往往是多种治则的相结合。所以，我们应该打破一些凝固地对待涩法和涩药的陈旧观点，使之能更加广泛地发挥其应有的作用。

我父亲根据对文献的学习和自己的经验体会，给我们众兄妹传下一条清规，治疗咳嗽、崩漏、带下、遗精、痢下、泄泻、汗出、喘息、潮热等病势向外类疾病，在并无明显虚象时，也要自觉地

将涩法与其他法则配合起来，要善于利用相反相成以达到邪去正安的目的。我父亲说，这样做的理论根据在于：人体的气、血、津、液贵在流通，但它们必须在一定的范围和轨道上流通方为正常，而保证这种正常流通的就是人体收敛功能，离开了人体的收敛功能，就会出现气脱、血溢、汗泄、二便失常等滑脱症状。涩法和涩药的作用，就是帮助人体收敛功能恢复正常的手段，所以，从防微杜渐这种意义上说，邪实或早期使用涩法，并非是不可以理解的。以带下为例，一般谓带下黄稠腥臭属实热者，须清化湿热，不能使用固涩法，只有在带下清稀无臭之偏寒者，才能使用固涩法以止带。临床上，我治疗湿热带下，不论带下红白黄色，只要属于实证热证，就常在重用清热解毒之品的同时，选配牡蛎、龙骨、栝根白皮、白果、山药、芡实、山萸肉之类以固涩。特别是山萸肉，用于红白相兼带下，有显著疗效；缺药时，我常用金樱子、乌梅炭、生山药合用相代。通过妇科检查，将清解药与收敛药配合起来，不仅能有效地减轻症状，而且对愈合宫颈糜烂、减少炎症部位渗出物，均有不可忽视的良好作用。诸书在治疗痢疾的禁忌中常说，下痢初起，邪实未去者，不宜过早固肠止泻，即使久痢(利)不止，若积滞未去，湿热不清者，也不可使用涩法，只有在邪实去，积滞消，正虚滑脱的情况下，才可使用固肠止泻法去进行治疗。对此，我在临床上也不奉为圣旨，选方常选芍药汤、白头翁汤、葛根黄连黄芩汤等，并选加收涩药物如石榴皮、赤石脂、五倍子等。伤阴时，选加乌梅；脾虚时，选加山药等。对于那种里急后重，下坠感特别明显者，我常用大黄类攻下药与收敛药同用，每收捷效。总之，治疗痢疾泄泻，我是将清热、解毒、导滞、收涩等治则熔于一炉，根据具体情况，而各有所侧重。至于外感内伤咳嗽而痰多者，虽日久不愈，先应祛痰，不可早用涩法，以防

恋邪之说，也不可过于拘泥。我在临床上感到，纵然久咳不愈，耗气伤阴，致使痰少难咯者，不配伍化痰之品，单用敛肺之药，咳虽减少，但却常会加重痰不易出，胸闷等症。因此，问题的关键还不在于使用涩法的早晚，而在于如何使用涩法。《伤寒论》中的小青龙汤能解表化饮，用于肺有痰饮兼感风寒的病症，方中收涩药物五味子半升，白芍三两，剂量并不少于发散之麻黄三两，桂枝三两，这种收与散相配伍的方法，赢得了百世的称赞。补气固表止汗的玉屏风散，临床上老幼感冒风寒，我常将此方作为基本方去加减使用，对于容易感冒的病员，此方之效已为不少报道所证实。真正治疗气虚自汗，牡蛎散显然比此方更为中肯合拍。因此，对于各种实证，只能说需要慎用固涩方药，而决不能说必须禁用固涩。

另外，涩法用于实证，还可以避免和减少祛邪药的副作用，以及防止药力过度而造成伤正的情况。如《伤寒论》大青龙汤方下说：“汗出多者，温粉粉之。”《伤寒论》所用的温粉究系何物，书中未曾记载，但使用的目的在于遏止大青龙汤所致汗出过多的作用却是显明的。根据唐代孙思邈《千金要方》记载，是用煅龙骨、煅牡蛎末、黄芪末各9克，糯米粉30克，诸药合匀，用稀绢包，扑身。此亦是属于涩法范畴者。

至于涩法能不能治本，在中医书籍中，一般还是认为不能治本，带有对症治疗（治标）的意思。我认为，涩法除了治标外，应该还能治本，表虚固表，里脱固里，只要我们不把涩法当作涩药的简单组合或参与去看待，那么，就是一种包含着治本意义的治则。治疗疾病的目的是什么？归根到底，还是为了使人体的功能活动重新恢复正常和协调。滑者涩之，也如热者寒之，寒者热之，闭者通之，惊者平之等治则一样，都是治本之法，也就是说，都是针对疾病基本病机加以调整的治疗法则，这应当是很容易理解

的道理。休克汗出，用生脉散是治本还是治标？湿热痢用芍药汤是治本还是治标？诸如此类的问题，是很容易加以判断的。

综上所述，那种认为涩法是为纯虚无邪，滑脱不禁之证而设，若邪未去，当先攻其邪，不可误用涩法，需待邪去才用固涩的观点是站不住脚的。这种结论的产生，是把涩法和治疗复杂疾病割裂开去的必然结果，这种结果有它正确的一面，它注意到了使用固涩方法不当，会导致出现收敛邪气并使之不易祛除的情况。但这种观点也有它凝固和僵化的一面，不善于利用涩法的收敛作用去扶正和祛邪。涩法作为一种治疗法则，也同其他治疗法则一样，各自有其适应范围，不能相互取代，只能相互补充、促进。各种治疗法则，针对复杂多变的疾病，只要配合得恰当、巧妙，就能减少病员痛苦，缩短疗程，促进康复。由于疾病的情况会受到气候、体质、情志等方面的影响，从而呈现复杂的情况，因此，相应的治疗方药，就不能限于一方一法，涩法在这些错综复杂的情况下，完全有发挥作用于邪实诸证的可能性。

总之，随着中医学的日益进展，把涩法仍禁锢在旧有的认识中，是既不恰当也不可能了，应该而且必须让涩法这一祖国医学遗产中的一株灿烂之花开得更加绚丽多姿。

下法运用点滴

历代前贤都强调治疗有邪之疾，其中特别是有形之邪，当为邪气开辟出路。所谓开辟出路，一般即指借汗、吐、下、利四条

途径，其中利是指通利小便，证之临床，开辟与不开辟出路的治疗效果大不一样。今试就我使用下法的粗浅体会整理简介于下：

一、下法的作用

下法的作用，主要有以下五点：

1. 荡涤、疏通、清洁胃肠，直接排除肠胃内的有形之物，如痰、饮、食、血、燥粪、蛔虫等。

2. 攻逐邪热，分间接和直接两个方面。凡肺胃郁火、肝火、风热拂郁于上，都可使用下法，以釜底抽薪，这是间接撤热；直接就是针对中下焦热盛，热结胃肠等症，使用下法可以起到斩关夺将的作用。

3. 攻逐寒积，暴饮过量冷物，冷积停滞于肠胃，或寒痰结滞，脾胃冷积，寒实结胸等症，均可用下法以去有形之邪。

4. 调整气机，脾胃是全身气机升降的枢纽，脾升胃降，利用下法下行的趋势，顺应了胃肠、胆、肺之气的下行，借以调整全身气机升降流通，消除清理人体各部的有形或无形郁滞。这样一来，就能影响人体气化活动，对人体气血津液之间的相互转化，以及人体对饮食营养的吸收都会产生一定的影响，只要善于利用这种影响，就能达到治病疗疾的目的。

5. 通下补虚，下法能补虚，前人论述有二：一是运用得当，可以借通为补，借攻为补；二是叶天士所提出的“胃虚通补”说，主张脾胃分治。叶氏认为，胃为六腑之一，主受纳，司传导，泻而不藏，满而不实，动而不静，降而不升，见症如噎膈、反胃、痞塞、便秘、腹胀者，皆因胃虚气乱，浊气在上，变通为滞，由降反逆。若遵李东垣风药升阳，徒使气逆，甘温守补，反致壅胀，

补虚要顺其性而用之，方为得体，胃宜降则和，所以胃虚当通补为是。叶氏通补之通，并非专以下法为限，但其中包括下法。各种急性病后期，以及其他慢性病表现出消化系统功能减弱、胃肠蠕动减慢，出现腹胀、便秘、食欲不振等一派虚弱的症候，我常在补益方中，根据具体情况而配以不同程度的润下、缓下、间隔下等不同方式的下法，对促进胃肠功能的恢复，以及虚证的改善，均有积极的作用。另外，关于下法能直接补虚，将在后面讨论。

二、下法的形式

下法分急下和缓下两大类。这两大类又可进一步分为燥下和润下，再进一步还可以分为热下和寒下。若连续使用它们，就称为连续下；若间隔使用它们，就称为间隔下。

三、对下法的评介

下法是攻逐体内结滞，通泄大便，疏通清洁胃肠的一种治法，具有排除蓄积、调理气机、攻逐邪热等作用。如果运用得巧，可以借通为补，借攻为补。张子和所说：“陈莖去而肠胃洁，症结尽而营卫昌，不补之中，有真补存焉。”这是颇有见解的。

但是，下法并非纯为泻法，可分为补和泻两个门路。泻法以燥下为多，主要用于实证，其使用范围较广，正如丹波元坚在《药治通义·下法》中所说：“干霍暴痛，诸危急证，宜峻下之，固不待言，凡沉痾痼癖，如顽痰宿饮，积食老血，及狂痫梅癩诸疾，皆有不可不下者。”下法不仅使用范围广，而且能提高疗效，加速疾病好转，张子和就说过，下法能使“病生于外，瘴气贼魅，虫

毒蜚尸鬼击、冲薄坠堕、风寒暑湿、斫射剥割撞仆之类，至如落马、坠井、打仆损伤、汤浇火烧、在狂犬伤、肿发掀痛，立获大效，病去如扫。”润下以补为多，属胃虚通补之法，不少润下药物，如蜂蜜、玄参、三角胡麻、当归、松子仁、生首乌、芝麻等，均具滋补之力，因此，下法就不单是一个补法，也不单是一个泻法，也不单是一个借通为补的治法，它本身就是直接通补的治法，因而也可以说是一个借补为通的治法。由于下法有轻重缓急润燥之分，又能与多种治则相配合，特别是它下行的趋势正顺应了六腑气机运行的方向，因此，我主张对下法应当广用、善用和巧用，对它不应当畏之如虎。

四、临床举例

1. 跌打损伤

《灵枢·邪气脏腑病形篇》说：“人有所堕坠，恶血留内，腹中满胀，不得前后，先饮利药。”后世宗此说者不在少数。《沈氏尊生书》说：“恶血在内，先要清心行血，通利大小肠。”《得效方》说：“先用通利二便药，和童便服。”《伤科秘要》说：“瘀血停滞或积于脏腑者，宜攻利之，先逐其瘀，而后和营止痛，自无不效。《疡科大全》引陈远公言：“瘀血留脏腑，人必昏迷不醒，二便必难，大成汤通利二便，其人必醒。”《金匱要略》指出：“斯须通利数行，痛楚立瘳，利及浴水赤，勿怪，即瘀血也。”这些文献论述，说明下法是治疗跌打损伤所致瘀血证的有效、有力、而又迅速的治则之一。不过，这里应当强调的是，使用下法时，即使无便秘症状亦可使用，在跌打损伤证中，特别是伤及胸腹腰肋的情况下，更应该根据瘀血蓄积的情况，使用不同形式

和程度的下法。我在临床上治疗此等症候，不论伤处颜色如何，也不论是否出血，只要伤处在胸腹腰肋部位，即使并无便秘现象，也在祛瘀疗伤的应证剂中，酌情（即根据体质等情况）加入泻下药物，如大黄、番泻叶、当归、胡麻仁、生首乌等，能增强疗效。如泻下之物色黑，乃瘀血也，可根据情况，再使用下法，至大便色正为度。

殷××，男，56岁，负重跌仆，胸部挫伤十余日，疼痛不可转侧，呼吸引痛，用血府逐瘀汤、跌打丸、七厘散等内服无效。大便正常，舌质红，苔黄腻，用柴胡疏肝散加苏木、枳实、厚朴、大黄，泻下数次而疼痛递减，两剂后，即活动自如，痊愈。

2. 痢 疾

凡痢疾初起，因宿食积滞，里热较甚，使用下法，最为适合。《简明医彙》说：“里邪实热者下之，及头面周身火热炽盛皆可下之，痢疾腹痛等症，下之即畅，如痢疾初起失下，大痛口渴，肛门肿闭，小便不畅，粒米不进，气息如微，一下霍然。”近年来，颇有仿效西药抗菌、制菌的原理，只重视对有抗菌作用的中药，加以收集组合，因此，很少使用下法等为邪找出路的方法。但这种仿效西药的方法而转为慢性，或后遗症性肠炎等类疾病的病员较多，这可能与炮制、剂型不当，药物苦寒伤胃，以及抗菌、制菌作用终不如西药强等因素有关。我认为，中医治疗感染性疾病，是通过多种途径进行的，使用下法以荡涤胃肠，推陈致新，亦是一种有效途径。治疗痢疾，不管是细菌性的，还是原虫性的，使用下法以通导，上述后果就比较少见。古今文献对此都有颇为精辟的论述，如朱丹溪说：“痢疾初得一二日间，以利为法，切不可使用止涩之剂。若实者，调胃承气，大小承气，三一承气汤下之。”以桃仁承气汤治疗痢疾来说，吴昆认为：“痢疾初起质实者此方主之。若初间失下，反用固涩之药，以致邪热内蓄，血不得行，腹

痛欲死者，急以此方主之。”吉益东洞认为，桃仁承气汤主治“痢疾小腹急痛者。”我在临床实践中，也加深了对下法的体会，这可能是因为泻下药不仅有制菌杀菌作用，而且还能使肠道得到较好的清理，使细菌及毒素得以迅速排出体外，从而减少了全身毛细血管中毒症状等，这样就能减少后患。因此，痢疾的治疗中，调气、行血、解毒固然是重要的，而攻下法亦是不可忽视的有效治则。

对于经常发作或反复发作的慢性肠炎、慢性结肠炎、慢性痢疾，凡是伴有腹痛症状者，我常使用泻下法，使痛随泻减。即使不伴腹痛者，亦间隔使用泻法，如芒硝冲服，或配大黄，或配番泻叶，泻下数次后，即停服泻药，然后仅服应证方药，不仅病员主观感觉良好，而且疗效亦颇佳。在用理中汤、四神丸等方治疗上述病症时，我亦喜加用大黄和肉桂各3~4.5克，为末冲服，疗效比不加这两味更好。当然，急性者用此二味入方亦是颇有疗效，肉桂用于急性滞下，前人方中常可见到。《普济方》中桂连丸，即用桂心、黄连各等分，治小儿痢下赤白，腹痛不可食。《河间六书》之芍药汤治湿热痢，方中亦有肉桂。用肉桂之意，在于取寒温之间相须相使之义。因此，也有用其他温性药者，如朱良春氏用《镜花缘》验方痢泻散，方中川乌与大黄合用，对菌痢及急、慢性泄泻，均有显效。

张××，女，32岁。病员发烧，恶心，腹痛，痢下赤白胶状粘液，经氯霉素治疗5天，疗效不佳，转中医治疗。现腹痛加剧，痢下鲜红胶冻样，日10余次，里急后重明显，舌苔黄厚腻，质红，脉数。处方：当归15克，白芍15克，槟榔10克，滑石18克，木香6克，枳壳10克，莱菔子12克，石榴皮15克，大黄（后下）6克，肉桂末（吞服）3克。二剂后，里急减轻，大便色黄，日5次。再服二剂，便色正常，质稀软，日4次，无里急后重现象。去大黄、肉桂，加焦三仙、白术，服二剂，即痊愈。

3. 上部出血症

临床遇肺胃、肝胆、郁火或实火所致之咯血、鼻衄、眼部充血等上部出血症，我常用大黄或芒硝、番泻叶等泡服，以釜底抽薪，撤火止血、祛瘀。特别是儿童、青少年鼻衄不止，并见口苦，舌质红，脉数，心烦者，用之更佳。

刘××，女，13岁。病员素患鼻衄，经常反复发作，今鼻出血止而复来，达半月之久，仅用大黄一味泡开水服，泻下数次而不甚。数次后，鼻衄即未再发，不仅止血快，而且不再缠绵。《圣济总录》曾记载治鼻衄不止，用玄明粉，卧时用冷熟水调下二钱匕。

近年来，多有报道大黄粉口服治疗上消化道出血，认为除肝硬化食道静脉曲张破裂出血外，不受年龄、出血轻重及有无并发症的限制，特点是止血快，有效率高，腹泻次数较多。不少文章指出，这不仅与大黄具有止血作用有关，而且与大黄的泻下作用有关。用这种止血逐瘀法，既能达到迅速有效的止血目的，又能及时排除瘀血，使大便隐血转阴时间明显缩短，而泻下又有助于临床对出血是否继续的鉴定，并减少了瘀血所致的吸收热和氮质潴留，由此可见，下法对上消化道出血的治疗有着重要的作用。黑大便，中医认为是瘀血，应当排出体外，在有热象时，我常根据前人经验，用桃仁承气汤之类下之逐瘀；虚象出现者，可加人参等补正。虚寒性上消化道出血而导致的黑大便，我常用黄土汤温脾摄血，再吞服止血散，由干漆粉1克（对漆过敏者忌用），大黄粉15克，白芨粉20克，赤石脂粉20克组成，四药和匀用汤药吞服，每天10克。疗效比单用黄土汤一类温摄之剂效果好。《张氏医通》认为，黑大便属于蓄血症，主张攻下逐瘀，论之颇详，并引不少医案以证之，读后能发人深思。我认为，虚寒证亦不当例外，补虚逐瘀，不仅两不相碍，且能互有助益，可以并进。

张××，男，27岁。病员近三年来，每年农历七月左右即出现黑大便，经吞钡透视，诊断为十二指肠球部溃疡。前两年出血，用黄土汤加仙鹤草、

艾叶炭、茜草炭，吞服三七粉，另服维生素K片等，都是4~5天大便转黄，7~12天大便隐血转阴。这次出血，用黄土汤加服止血散，未服其他西药止血，2天后大便转黄，4天大便隐血转阴。

4. 斑疹、感冒、手掌足底脱皮

一般来说，在表邪未解，里实不甚之时，治疗应根据先表后里的原则，首先解表，只有表邪已解，里实已成之时，方可使用泻法，否则就会引邪入里。但有一般也就会有特殊，临床上往往还可以看到里气郁而致表气不通的情况，所谓表气不通，是指表症不为汗解或用发表剂不能作汗，斑疹一类不能透发等。里气郁是指诸如食滞、停饮、腑实、痰遏等有形之物阻塞于内。在这种情况下，如果在发表剂中佐以通里法，里气一畅，升降正常，表气往往随之即能宣发，这在临床上是效能复制的。

李×，男，5岁。病员发烧39℃，手足抽搐，无汗，皮肤灼手，脉数，舌尖红，苔薄滑、微黄、中心略腻，经推拿颊车、地仓、头维、人中、承浆、上星等穴后，抽搐止，仍无汗。用藿香正气水一支（10毫升），大黄3克，泡开水兑服，大便泻下极臭，出汗后，体温即退。

王××，男，6岁半。病员体温39.5℃，麻疹隐隐，色暗，昏睡，神识朦胧，腹胀拒按，气息粗，脉紧数，舌苔黄腻，口中有秽气，大便一日未解，视其所服之方为：银花、连翘、蝉蜕、葛根、升麻、芫荽须、枳壳、防风、牛蒡子等，然而无效，乃里气郁滞的缘故。仍用上方加莱菔子、芒硝、大黄，服一剂后，病员疹透，神清，哭声朗然。

杂病中此症亦多，当疏通里气，才能治在表之症。我治疗手掌足底脱皮，喜用猪苓汤加味，疗效颇佳。又曾治一手掌足底脱皮的男性青年病员，其肠间时时水鸣、腹满，用《金匱》杞椒苧黄丸，为水煎剂而取效。肠燥津枯便秘之人，一旦出现皮肤发痒、麻木、甚至燥裂起屑，往往与里燥有关，用当归、首乌、党参、黄芪、桃仁、郁杏仁、核桃仁、陈皮、枳壳等为末，以蜂蜜收膏，每日服用，效果良好，在这里，润下起到了畅里疏表的作用，使

津液能畅达表里。

5. 肝火头痛、眩晕，肝风抽搐、麻木

肝火上攻于头，常见头痛眩晕，面红目赤，耳聋耳鸣，胁肋疼痛，口干口苦，脉弦数，舌质红、苔黄。而肝风内动，一是热极生风，为高热抽搐；二是阴虚阳亢，如类中风；三是肝失濡养，多表现为肢端麻木，肌肉震颤。以上情况，不少病员往往伴有便秘、便闭等症，于此，我常根据其具体情况配用适当的下法，一般是肝火上炎和热极生风多使用峻下，肝失濡养者多使用缓下和润下。为什么要使用下法呢？我的认识是因为脾胃为人身气机升降的枢纽，黄坤载就说过，脾气升则肝气升，胃气降则胆气降。不论是肝火上炎、肝血不足，还是热伤津液，造成胃气不能正常下降而导致便闭，就又会反过来影响上炎和内动的病机。肺与大肠相表里，胃肠便闭，就不仅会通过胆而波及到肝，而且还会影响到肺气的肃降，这样就会加重或促成肝火犯肺、犯胃而导致咳血、吐血。对于类中风来说，便闭势必加重气之与血并走于上的病机。使用下法，胃肠通畅，气机下降，就能引血下行，降低脑中血管的压力，减少脑中继续溢血或促使瘀血疏通。至于肝失濡养症，便闭又会干扰到肝之疏泄，而缓下、润下通过下能帮助肝气疏泄，且润下之品，既能滋补，又能通络、熄风、润肝，多方面都能兼顾。

雷××，女，26岁。病员头晕，吐涎，咳嗽，时头面烘热，烘热时耳鸣如潮，头痛如裂。暖气，不思食，两颧嫩红，体质清瘦，面色皖白，舌光如镜，中有裂纹，舌根部略有白色无根腐苔。此肺胃阴亏，肝阳上亢。处方：刺蒺藜10克，菊花10克，石决明15克，牡蛎15克，钩藤12克，白芍12克，当归10克，石斛10克，台乌3克。水煎服，三剂。

二诊，诸症依旧，上方加生地25克，雅连3克，天麻10克。水煎服，三剂。

三诊，能思食，头晕如故，面热耳鸣，头痛略减。自诉大便

干燥，近一月来大便逐渐为2~3日一次，有时甚至4~5日一次，且干结如羊粪。处方：钩藤12克，菊花10克，刺蒺藜10克，珍珠母（先煎）24克，草决明15克，生地12克，玄参12克，白芍10克，白薇10克，天麻10克，玉竹10克，夏枯草10克，三角胡麻10克，生首乌12克，生大黄6克（泡开水兑服）。

服药后大便通畅，病自此后迅速发生转机。食欲、消化增强，头痛、头晕、耳鸣、头面烘热皆明显减轻，能下床活动，解除了长达两月的卧床痛苦。

6. 胃气虚弱兼便秘的诸证

下法能补虚，这个补不是指的借通为补的补，乃是说下法能直接补正，且补也并不仅限于补胃虚。这是因为一方面不少润下药物，均具有滋补之力，如蜂蜜、元参、三角胡麻、当归、松子仁、首乌、芝麻仁等；另一方面，下法顺应和帮助了胃肠气机的下降，这就调整了胃之受盛、大肠之传导、小肠之分清泌浊的功能活动。由于下法有轻重缓急润燥之分，又能与多种治则相配合，特别是它下行的趋势正顺应了六腑气机运行的方向。因此，下法就不仅能通补胃虚，且能通过调整人体六腑气机之降，而达到调整人体五脏气机之升，所以这种补法的作用就比较广泛了。对多种虚证的治疗，能起到良好的调整作用。特别是润下法，并不单是一个借通为补的治法，它本身就是直接的滋补之法。现代医学亦认为，中医的下法能及时恢复胃肠功能，加强其对食物营养的吸收，这仍是着眼于胃肠功能，其实下法的作用远非仅作用于胃肠。由于下法在使用时的配伍形式，选用泻下药物的不同，再加上下法的化学、物理等作用，以及病员当时的种种具体情况，其临床作用早已不被局限在胃肠范围。因此，我在临床上使用下法补虚时，主要用于两种情况，一是胃虚，兼大便干燥之诸证；二是其

他虚损病症出现便结、便秘。

下法补虚，一是选用润下药物，这类药物既能致下，又能补虚；二是选用硝黄一类下药再配以补药，使之相伍，这种配伍的方式能否谈得上是补虚的下法呢？我认为，不论从作用机制上讲，还是从药物作用的配伍上讲，都可以肯定这种下法是补虚的下法，而非攻逐实邪的下法。只不过这种补法与其他补法的名称不同，不叫滋阴补虚、温阳补虚、益气补虚，而叫做通下补虚罢了。

在临床上，当胃气虚弱，精神疲乏，食欲不振、纳而不化，腹胀闷不舒、呃气，大便干结时，可以用下法以通补胃气，使胃气得到舒展充盛。而其他各种虚损病症，一旦出现上述胃虚症状，或者出现便秘并由此而加重虚症时，都应当根据具体情况而配用通下补虚法，方能使病情得到迅速的机转。例如，《金匱要略》的大半夏汤，是治“胃反呕吐”的方剂，我每用此方于胃气虚弱之呃气、不思食、大便干结、汤药入胃则呕者，屡建奇功。特别是在不少疾病的后期（主要是指急性热病），大病去后，出现胃气虚弱，形体消耗，纳而不下，下而不化者，更见效力。

赵××，女，46岁。病员平素体弱，大病后自认为已无生望，心中忧郁悲伤，时发干呕，不能饮食，嗳气，腕肋不舒，腹自觉胀而按之平软，气短，心悸，面浮，目窝微肿，大便干结，舌淡苔薄白，脉濡。处方：大半夏汤（方中用红参）加青皮、桂枝、茯苓，嘱少量慢饮，不拘次数。一剂后，即能食少量稀粥，十日后，胸肋胀减，食欲增，大便日行一次，较畅，自觉胸膈舒展。停服三日，又感不舒，连服一月而诸症悉除，健壮如昔。

另外，如脾胃虚寒之习惯性便秘，我对中阳虚者用理中汤加大黄末吞服，中气虚者用四君子汤加砂仁、炒莱菔子末吞服。当久病之后，或年老体弱之人，正气虚衰，皮肤干燥起屑，食少便艰，干燥有如羊粪，每次便后，顿觉舒畅，而一旦数日不通，一身便觉不可言状之苦楚，每至此时，常用砂仁泡水，搅入蜂蜜，

加姜汁数十滴，少入陈皮末当茶饮，每获良效，便通食增，对身体恢复颇有益处。

长期实践，使我体会到，各种虚弱病员，只要具备有胃虚便秘之症，都应当使用通下补虚法，才能增强疗效，加快正气恢复。可见胃气强则重病可望来苏这句话，实实在在对于临床有着重要的指导意义，不可忽视。

五、注意事项

1. 量人虚实，度邪轻重，察病缓急，揣邪多寡，投药毋太过不及，以早拔病根为要。

2. 纯属卫分表证，恶寒较显著而热势不甚，或老年体弱，孕妇及妇女经期，宜慎用。

3. 脾虚溏泄，或肾虚关门不固者，均当慎用或禁用。

4. 使用下法，要注意下法轻重缓急和润燥的区别，以适应病体的新久缓急，寒热虚实，而灵活运用。

使用下法，有常有变，但变法亦是根据常法善用和巧用而来。总而言之，知常则达变，由会用进而巧用，就能收到很好的临床效果。那些畏下如虎和滥用攻下都一样，都有可能在临床治疗上坐失良机或矫枉过正，从而给病员增加痛苦。下法的实质就是这样，必须认真审慎对待。

热因热用举隅

用温热药物治疗表现为有温热性症候的病证，就是热因热用。热治之法，即是温治之法，有温补、温下、温开、温通、温散、温气、温阳等温法，各有其适应的范围和使用特点。热因热用之热用，也离不开使用上述具体热法。热证有虚热和实热之分，实热证能不能用热药，古今医家众说纷纭。我认为，实热证中用得巧疗效非常好，如果做些理论上的总结工作，还会丰富中医治则，提高中医治疗艺术。在临床上，我使用热因热用法，可归纳为以下十一种形式：

一、真寒假热，阴阳离决

人体阳气不足而呈本质上的虚寒，又表现出种种假热的症状。这种阴阳离决而表现真寒假热的情况，主要包括两种类型：一种是戴阳证，表现为上热下寒，症见气短，呼吸迫促，倦怠懒言，头晕心悸，四肢冷，小便清，大便稀溏，舌质胖嫩，苔黑而润等真寒表现。又能见到面色微红似酡，烦躁，口鼻有时出血，口燥齿浮，咽喉疼痛，脉浮大或沉细，按之空虚无力等假热症状。当急用回阳救逆方剂，可加猪胆汁或黄连少许反佐，亦可冷服，以防寒热格拒。另一种类型是格阳证，表现为内寒外热，症见恶寒、神倦、肢冷、下利、脉微等内真寒症候外，还能见到身热却反喜

盖衣被，口渴却喝水不多，或索水又不想喝，或喜热饮，手足躁动，但神态安静，脉虽洪大，却按之无力，或脉微而弱，或数而虚。由于两种证型的本质都是真寒假热，阴阳离决，所以治疗原则，都是以回阳救逆为大法。我常以人参、附片、干姜、甘草为基础方加味治疗。就临床观察来说，二者进一步皆可出现亡阳症候，戴阳以额汗为多，格阳以体汗为多，尽管出现的地方不一样，而病机是一样的。根据具体症候表现不同，在临床上对上方我有如下的加味法：

1. 脉浮大无根，或脉微细，吐利不止，体润，汗出，但见一症，均为气阴两伤之象，单用辛热峻烈则更伤气阴，故俱加龙骨、牡蛎、黄芪、五味子等敛阴固脱之品。

2. 脉沉细，舌苔白腻且厚，加肉桂或桂枝、茯苓、白术。

3. 舌苔薄白，舌质瘦小，加白芍、鸡子黄或童便、猪胆汁，以回阳复阴，并缓和姜、附燥热之性。

4. 舌质胖大而有齿痕，可加白术、黄芪、龙骨、山萸肉。

但是，这里应当加以强调的是，阴阳离决之前是早有征兆的，要早期使用救逆回阳之剂，不要待离决时再用。

二、血虚发热

血虚发热，多为低热，临床见症是在血虚症候的基础上，再出现发热症状。一般来说，面色苍白或萎黄，指甲色淡，心悸，失眠，脉细，头晕眼花，唇舌淡白，是各种血虚的主要症候。血虚之发热，其特征为小有烦劳即能引起低热，轻者但觉头面烘热，手足心烦热，出汗，体力疲乏异常，心情不好，情绪不佳时，更明显出现上述热象。血虚证由失血过多或生血不足所致，所以常伴见气虚的症状，因而对血虚发热的治疗，我认为不能脱离甘温

濡养的大法，即是有外感郁火、实热，也必须在这个大法的基础上去清泄和祛邪。一般常用的药物，如党参、黄芪、当归、首乌、龙眼肉、枸杞子、阿胶、鸡血藤、白芍等；常用的方剂，如当归补血汤、参芪四物汤、归脾汤、圣愈汤等。血虚发热倘兼有实热症候，亦可用苦寒之品，如当归六黄汤。产后发热，多为血虚发热，这里举一例产后外感风寒而致发热治验：

张××，女，28岁，教师。产后发热，体温38.5℃，舌淡苔白，头痛，身痛，恶寒，汗多，畏风，口中和，脉浮紧。处方：桂枝、附片（先煎）、泡参、防风、白芍、桔梗、秦艽、甘草、鲜竹叶、大枣、葛根，水煎服。二剂热退，痛愈，用益气补血剂调养。

三、气虚发热

急性热病日久不愈，或治疗不当，都能引起气虚发热。慢性病久病正虚，亦常见气虚发热。治疗多用甘温除热法。

急性热病后期，病员常会出现疲乏无力，气短胸闷，食欲不振，精神萎顿等症候。这时体温常稽留在38℃左右，虽然热象犹存，但由于气虚亦见，治疗时就应当适当地增添人参、黄芪、白术、甘草、茯苓等甘温益气之品，这种扶正祛邪并举，标本兼顾的治法，不仅病员主观感觉较好，而且余热消除也较快。

吴××，男，9岁，1975年9月20日初诊，病始发烧，口渴，嗜睡，不思食，咳嗽，胸部隐隐作痛，叠经青霉素注射、输液十余日。目前口渴，一昼夜喝三瓶半开水（约十七磅），思温饮，站立则发抖。目半闭而精神萎顿，面色潮红，消瘦，热汗时时涉额过腮，脉数，舌质红，无苔但伸舌时有痰涎起丝状。胸中感到发胀发烧。曾进清瘟败毒饮、白虎汤，以及千金苇茎汤等无甚疗效。乃肺胃阴亏，痰热阻遏，寒之不寒，责无水也，宜甘寒生津，清热化痰。

处方：沙参12克，玉竹12克，麦冬15克，扁豆10克，花

粉 10 克，石斛 12 克，山药 10 克，桑叶 10 克，菖蒲 3 克，胆星 3 克，枳壳 10 克，牛蒡 10 克，银花 12 克，连翘 12 克，葛根 10 克，姜汁数滴。水煎服，二剂。

9 月 22 日二诊，服上方第二剂时，患儿于 21 日午后阵阵恶心，继而呕吐浓痰两大堆，约 300 毫升，浓痰中夹有血丝，血色鲜红。吐出一小时后，患儿精神逐渐好转，口渴心烧，胃胀，发烧，汗出等症状亦减轻，下午略有思食感，为十余日来所未有的好转现象。再服上方一剂。

9 月 23 日三诊，22 日又吐浓痰，性状同前，约 70 毫升。现饮水基本正常，胸部有舒适感，自呼要吃东西，能下床略为行动。消瘦，面色苍白，有汗，脉数，舌质红而无苔。因要返家，处方两张，交替服用，至症状消失，舌苔复生止。

处方一：沙参 10 克，玉竹 10 克，麦冬 12 克，冬桑叶 10 克，扁豆 10 克，花粉 10 克，山药 10 克，粉葛根 10 克，石斛 10 克，银花 10 克，连翘 10 克。

处方二：党参 10 克，白术 10 克，茯苓 10 克，粉甘草 3 克，砂仁 3 克，木香 3 克，当归 6 克，京半夏 10 克，红枣 4 枚，生姜 3 片，陈皮 6 克，淮山药 12 克。

本案诸症减退后，即出现面色苍白等脾阳不足之象，可见当时思热饮是欲借温力以行积水，而脾阳不足引起积水，又为热邪煎液为痰造成了条件，这是本病产生的内在因素。故尔，病变后期舌红无苔，却须配伍阳药，否则苔将无从生矣。正因为顾及于此，所以患儿恢复较快，且愈后也较为巩固。

在慢性病中的气虚发热，为低热，有外感时热度可增高，治疗亦不离益气之法。正如张景岳论补中益气汤说：“东垣用此以治劳倦内伤发热等症，虽曰助阳，非发汗也，然实有不散而散之

意，故于劳倦感寒或阳虚痿症及脾气下陷等症则最所宜也。若全无表邪寒热，而但有中气亏甚者，则升、柴之类，大非所宜。”

汤××，男，45岁。自诉三个月来腰背疼痛，左边上下肢麻木，低烧，心中烦躁，脉细无力，舌苔白略腻。并询知其长期坐办公室，遂用补中益气汤加木香、麦冬、香附、羌活、乌药、防风。三剂后，手足麻木大为好转，仍低烧、乏力，用八珍汤加陈皮、法夏、桂枝、羌活、防风、秦艽、牛膝。四剂后，麻木基本消失，腰微痛、低烧，乏力明显减轻，气血未复，用十全大补汤加牛膝、秦艽、杜仲，服十剂痊愈。

四、阳虚发热

阳虚的常见症状为形寒，乏力，面色㿔白，或灰滞，或面目浮肿，或腰痠腿软，舌质淡白，舌体胖嫩而有齿痕，舌苔白或灰黑滑苔，或黄腻苔，但苔质不粗糙反较细嫩。阳虚为气虚进一步发展的结果，由于阳气是营血和津液温运的根本动力，所以阳气一虚，常伴见水饮留聚和血运瘀滞。如心肺阳虚，常见口唇青紫，脉象结代等，脾肾阳虚常少浮肿，痰饮病当以温药和之的治疗原则，也含有这种意思在内。因此，阳虚发热有三种情况：一是由阳损及阴，阴虚生热；二是阳虚而致停水留瘀，郁而化热；三是阳虚之质受外感而致发热。三者的治疗，虽各有别，但补阳却是必须顾及到的共同点，因面甘温或辛温的补阳法，为阳虚发热的基本治疗法则。

王××，男，49岁，^①干部。近六年来，无法上班工作，胃痛吐酸二十余年，曾作~~空~~腹胃液检验，吞钡透视并摄片，诊断为慢性肥大型胃炎。六年前因患急性肾炎，曾住××医院治疗8个月，肿势虽减轻，但却呈反复间歇水肿。肢体浮肿，腰痠，便溏，面色㿔白，四肢清冷，肩背不温，肢乏体倦，精神萎靡，舌质淡白无华，苔白而滑润，边有齿印，脉沉细，但小便却黄少，口苦，眼角生眵，心中烦热，每一感冒风寒则口鼻干燥，如有椒面刺激，无涕等燥热证更加严重，平素亦少津液润泽上窍。

处方：党参 20 克，黄芪 20 克，枳实 10 克，附片 15 克，干姜 15 克（二味先煎半小时），白术 12 克，甘草 3 克，茯苓 10 克，厚朴 10 克。经服药治疗 5 个月，胃痛、水肿基本痊愈，恢复正常工作。

五、外感寒邪发热

外感寒邪发热者，甚时有体若燔炭的情况，其着眼点当在于体温虽高而口不渴，咽喉、舌质之红与体温并不成正比，舌苔亦可无热象，一般薄白而润，或厚腻而白，而且肢体疼痛酸楚明显，不若风温外感发热，往往舌苔薄白欠润，舌边尖红。此种发热不欲去衣被，与温病之欲去衣被有别，且脉少见洪大，常有紧感。治宜辛温解表，误认为热证使用寒凉之剂，往往会愤事。

黄××，女，27岁，上下肢关节疼痛，双膝红肿发热，抚之灼手，行动艰难，心跳，畏寒，发热，体温 39.5°C ，左膝有环形红斑现于皮下，舌边尖不红，咽喉肿痛却不甚红，口不渴，舌苔白腻多津，恶寒，衣着较厚。查血，血红蛋白 9 克，红细胞 365 万/立方毫米，白细胞 8800/立方毫米，嗜中性粒细胞 80%，红细胞沉降率 102 毫米/小时（长管法）。脉紧略数。处方，干姜 6 克，附片 6 克，制川乌 4.5 克（三味先煎半小时以上），麻黄 6 克，细辛 3 克，防风 10 克，威灵仙 12 克，甘草 3 克。一剂后，即能下床活动，体温正常，而疼痛顿减。后以此方加减，连服十余剂，并配合艾灸而愈。复查红细胞沉降率三次，均在 20 毫米/小时以下。并已能参加农业生产劳动。

以下几个部分，均是着重探讨实热证使用热药的机制。

六、热毒壅盛，表卫不通

里热壅盛而卫分无汗的症候，常需在清泄攻下法中，少配以辛温宣发之品，以助清解。这类病员表里俱热，三焦火盛，壮热

无汗，面赤目红，鼻干口渴，小便短赤或大便秘结，甚则谵妄鼻衄，或发疮疡肿毒，脉滑数或洪数。这类热毒充斥一身表里上下皆热之证，治疗除常法清热解毒或通腑泻热外，还可以根据身热无汗的表卫不通症候，配以适当的辛温发表之品，¹使汗出，邪火得以通行，能有外达的去路。如《宣明论》中的防风通圣散，功用为散风解表、清热泻火、通便，多用于表里俱实，风火壅盛的实热证。见症有恶寒壮热、烦躁、头痛、便秘、尿赤、舌苔厚腻或垢浊、脉滑或弦数等，为表里双解的复方。方中宣通表卫选用了辛温的防风、荆芥、麻黄等。我在临床上，还将此方加减用于急性荨麻疹、过敏性药疹、痈肿初起、急性副鼻窦炎、丹斑隐疹等，属于里热壅盛，表卫闭郁者。我根据此方汗、清、下并用的特点，对常在火旁工作，或饮食又较肥美之人，外感风寒而见面赤、口干、便秘者，颇有良效。肝阳上亢之证，常导致热郁胃肠，而见便秘腹满、头晕头昏头痛加重，再症现目赤、口鼻干燥、体丰者，用此方后血压下降，病员感到轻快，颇佳。《外台秘要》石膏汤，方中使用麻黄、淡豆豉，亦属同一机理。凡外感热病致发烧，宜体表微微有汗，特别是邪在卫分气分尤应如此，倘身热无汗，即为表卫闭郁，当开发之，可用辛温走表之品，表卫开泄，邪热自易溃散。

七、实热郁积

在实热证中，特别是热毒之邪最易郁积，如疮、痈、疽、疔、疹、疖、流注、白虎历节、火邪犯肺之咳嗽、口糜、胃痛、痞结等一类病症，都是热邪郁积之象。对这一类病症的治疗，就应该针对具体情况，相应地配合一点热药，以达郁散积。治疗痈肿的代

表方剂仙方活命饮，方中就选用了防风、白芷散风消肿，当归活血，陈皮行气，乳香调气托毒外透，这些温热性的药物起到了清解药物所起不到的作用。《外科正宗》透脓散中之生黄芪、川芎、当归；《金匱要略》薏苡附子败酱散中之附子，尤在泾对此解释说：“附子则假其辛热以行郁滞耳。”《景岳全书》所载肠痈秘方，以好酒两碗，煎一碗服，其酒乃温热之品。以上这些都是根据性用相须则寒热相济的原则而具体运用的。《丹溪心法》之左金丸，是治疗肝火旺盛，左胁作痛，吐酸吞酸，舌红脉数之症，方中辛热之吴茱萸，不但能行气解郁，并且还能制止黄连苦寒伤损胃阳，热药在这里起到了一箭双雕的作用。钱乙清泻肝经实火的泻青丸中，用了辛温的防风、羌活，以搜风散火；刘河间治疗肝胆实火的当归龙荟丸，方中亦选用了辛温的木香、麝香，以调气，助诸药清热泻火的力量更加迅速猛烈。另外，如龙胆泻肝汤、普济消毒饮、清瘟败毒饮、栀子豉汤、黑膏方、芍药汤、升阳散火汤、泻黄散、消斑青黛饮（陶节庵）、辛夷散、苍耳散、紫雪丹、至宝丹、安宫牛黄丸、神犀丹等清热泻火之剂中，都适当地选用了温热类药物。《伤寒论》中之半夏泻心汤，方中亦有辛温的干姜、半夏，其中也明显含有寒温相济之义，所以，本方应用根广，不仅伤寒误下成痞，即不由误下而寒热中阻致痞，以及湿热留恋，脾胃虚弱，升降失调致痞者，多从此方加减，而且疗效颇好。

归纳起来，上述清解方中佐用一定温热药的作用大致为：1. 由于寒则冰凝，热则流通，热之性本为行，所以为防止寒凉药以治实热证时会产生凉遏格拒壅结者，非热莫属；2. 热性流通，有助于气机畅利，已经郁积之热，可得热性以助行散，含有火郁发之之义；3. 大队寒凉药中配伍一定温热之品，能利用阳药去推动阴药，增其流动之性，有助于寒凉药物发挥作用。综上所述，

当热邪郁积之时，佐用一定比例的温热之品，是有必要的。

这里举两例病案加以说明。

魏××，男，10岁。病员高烧39℃，大便不通已6日，口渴，腹痛拒按，小便黄，有矢气甚臭，舌苔黄腻，舌质红。查血，白细胞12000/立方毫米，嗜中性粒细胞80%。处方：蜂蜜30克，生姜汁15克，大黄6克。一剂而便通，所下如败酱，臭秽异常，腹痛顿减。连服三剂，体温正常，腹痛递减至消失，用沙参玉竹麦冬汤以善其后。

魏××，女，36岁。病员左鼻孔旁生一疔，整个颜面红肿，左边尤甚，脉滑数，舌质红，苔黄，口渴，心烦，疼痛厉害，说话困难。此毒热蕴邪，火毒结聚（鼻疔），当清热解毒消肿，处方：辛夷花10克，黄芩12克，杏仁10克，薄荷6克，苡仁18克，冬瓜仁20克，苇根30克，蒲公英20克。水煎服。二剂后，肿消大半，前方去杏仁，减黄芩为10克，蒲公英为12克，加蝉蜕6克，桃仁9克，苍耳9克。另用菊花、甘草适量，泡水当茶饮。三日后，平复如常。此案方中辛温之辛夷花，使用于整个治疗过程之中，后又选加苍耳，亦温药也。其作用除二味所具的通肺窍功效外，还具有上述所归纳的三条作用在内，故而疗效较好。倘纯选苦寒清解之品，效既无此速，且还有壅遏之弊。

八、壮火食气

少火生气，壮火食气，食气后须配热药以补气。壮火食气，可产生于两个方面：一方面热盛会耗伤阴精，阴精耗损到一定程度，就会减少生发阳气的物质基础，从而出现气虚，甚至可以引起阳虚。另一方面，正如《内经》所说：“热盛则气泄。”就是说热盛的本身也会直接耗伤阳气。因为热盛产热过多，必然也会导致散热过多，散热须肌腠开泄，开泄过甚则阳气必然散失，暑病就是典型的例子。暑热病常有心悸、气短、四肢乏力等气虚表现，重症中暑就更是阳气暴脱的征兆，所以《素问·刺志论》说：“气虚

身热，得之伤暑。”基于上述两方面的因素，壮火在一定的情况下，就会出现食气的病理状况。

张景岳说得好，“阳和之火则生物，亢烈之火反害物，故火太过则气反衰，火和平则气就壮。”认清了这个道理，在热病的治疗中，就能掌握主动权，就不会对火热之症的治疗只知清热泄火。正因为如此，所以在对温病、瘟疫的治疗各种大法中，回阳固脱法仍占有重要的地位，而未能偏废。也正因为壮火会食气，所以温热病的治疗中，常会出现不同程度的气虚情况，如人参白虎汤证、东垣清暑益气汤证、竹叶石膏汤证、生脉散证等，都是不同程度的壮火食气后所表现出来的证型。这类方剂中，均用了适当温热之品以益气，这些行之有效的良方，实在值得我们深思其中三昧。

在临床中，我体会到，壮火食气的理法方药是一个值得深入研究和探讨的重要课题，只要认证准确，选药恰当，对疾病的治疗、病体的康复，从远期疗效来看，均有着非常积极的影响，不应该忽视这个问题。

九、取热药之用

热之性本为行，以上是讨论了用热药之性的一些问题，这里准备讨论取热药之用于热病治疗中的作用。

取热药之用，而不顾其热，或巧借其热以疗热病的例子，在古今方剂中不胜枚举。麻黄为平喘要药，但性温，麻杏甘石汤治肺热之喘，取用麻黄是主要取其功用；又如《宣明论》桂苓甘露散为清暑泄热、化气利湿之方，方中官桂也即取其用。总之，在大队寒凉药中，再配伍一定的温热药，既能利用阳药去推动阴药，

增其流动之性，又能顾及阴阳互根之理，不使矫枉过正。不论是用其性，还是取其用，药一下咽，性用都会发生作用的。因此，常会因用之巧，而发生良好的、同时取得多方面的作用。需要注意的是，在上述的情况下，使用热药，都要恰当掌握寒热之间的比例。如果不适当地重用热药，就会喧宾夺主，非但不能发挥其巧的作用，反而会抱薪救火，酿成燎原之灾，此不可不慎。

十、体质的需要

阳气不足的体质，发生各种热证，都要注意使用以热治热的方法。平素脾胃阳虚或肾阳不足之人，外感风寒或风热，都要注意使用温补中下之品，单用辛温或辛凉解表，或用苦寒清里，往往更伐阳气，使热势缠绵不已，延长病程，我称此举为只顾现在而丧失将来。倘热势一旦控制，不顾阳气之亏，更会变症丛生。我于1979年9月，咳嗽一月余，吐浓痰，干酪状，色黄成块。体温 39.5°C ，查血，白细胞14000/立方毫米，嗜中性粒细胞86%，双肺可闻及粗糙呼吸音，并有干性粗罗音。汗多，脉浮数，口不渴，舌质红，苔黄欠润。处方：黄芪15克，白术15克，防风10克，苇茎30克，银花15克，连翘15克，桃仁10克，杏仁10克，薏苡仁15克。五剂后，痰转稀白，体温正常，因食欲不好，用大半夏汤善后，一月后精神食欲均回复到未病时。另外，临床上常可见到久病脾虚的病员，出现发热口干不思饮，舌质淡而光亮，舌苔黄腻，尿短色黄，属于湿热蕴结之象。虽用清热利湿，芳香化湿等法，但舌苔黄腻，尿黄等热症依然存在。如在上述治法中加入补益脾气之药，如人参、黄芪、白术之类，黄腻苔即可转为薄白，且口干亦解，尿黄亦退。

十一、病的需要

《金匱要略》说：“病痰饮者，当以温药和之。”痰饮病员即使有热象，也要顾及当以温药和之这个原则，远期疗效才会好，否则，常造成弊端而遗患无穷。我在临床中体会到，不仅痰饮病是这样，瘀血病也往往是这样，都当注意以温药和之，正如《医碥》所说：“因血属阴类，非阳不运，故遇寒而凝。”寒凉过度，是会加重或造成新的痰饮和瘀血。凡是病的本身需要使用温法者，遇有热症，纵是实热，都应当重视使用以热治热之法，偏废和忽视热药的配合运用，往往会为今后造成某种麻烦。湿邪的治疗，也是属于这种情况，以湿温病为例，其治则归纳起来，大约有三，即化、清、攻下。化是指苦温芳化，治湿不可远温，温才能化，凉遇冰伏均会助桀为虐。我认为，凡是津液、营血等物质代谢障碍而发生潴留的慢性疾病，都要恰当地以温药和之，这是因为气机、气化正常，津液才会正常运行于体内而不潴留，而气机、气化得以进行的根本动力是阳气。

综上所述，热因热用的实质，主要有两点：1. 抓住疾病的本质进行治疗，这就透过了发热的现象；2. 巧妙地运用热药的性和用，以帮助机体阴阳的调节和清解药物发挥作用。总之，研究和·使用热因热用，实是一件富有趣味和引人入胜的事情。

甘温除热法使用我见

甘入脾胃，温益阳气，甘温剂者，即温补脾气之剂也。由于人以胃气为本，元气充足，须赖脾胃之气无所伤，所以，甘温法能通过对脾胃阳气的补养，对升降出入的调整，使人体元气充沛，增加抗病能力，至于帮助消化，增进食欲等，只是上述作用结果的一部分，而不是全部，这些概念首先是应当明确的。甘温除热法，就是用甘温之剂去治疗发热证，这种治疗法则构成东垣脾胃内伤学说中的一个重要内容。甘温除热法的基本精神，是扶正达邪以协调阴阳，治虚实夹杂之证，其虚为中焦阳气虚，其实为各种致热之病邪。我认为甘温除热法的结构，一般由三个方面组成：1. 温补中气，也就是说用甘温补气；2. 调整升降出入，消除由气机、气化失常所致的病理产物；3. 祛除各种致热的病因。为什么会得出这样的结论呢？这是因为脾气（阳）不足，脾胃升降出入功能就会发生与之相应的紊乱，这样就会影响到津液和水谷的正常代谢过程和途经，久之，还会波及到血，从而造成水、饮、痰、食、瘀等病理代谢产物潴留于体内致病，这些有形之邪壅塞可以化热，郁积更可以化热，这是气虚和发热共存的一种可能。另一方面，中气一馁，元气不足，邪气也容易乘虚入侵，六淫侵袭，也是引起发热的原因之一。这两种热，不论其热势高低，都是由实邪而致的热，非虚热也。如把这种热当作虚热，就容易混淆概念，无法正确地进一步推论下去。另外，当气虚进而产生阴虚后，体

内又会因阴虚而产生热，这种热才是虚热。这种虚热和上述邪热都是在气虚的基础上错综产生的，故为虚实夹杂之热。因此，东垣的脾胃内伤学说，其基本精神在于扶正达邪，脾胃内伤病证，并非单纯的虚证，绝大多数是虚实夹杂证。据我在临床上的体会，东垣所说的“阴火”，大多数是指的实邪所致之热，这种热是与脾胃气（阳）虚同时出现，这种局面的产生，不论是由虚及实，还是由实及虚，在治疗上都必须共同解决。从东垣的用药规律中也可以看出这个问题，因为是实邪所致之热，所以才用黄连、黄芩、黄柏泻火，才用羌活、防风、葛根、柴胡散火。除此以外，东垣使用甘温剂还常常与祛除气机、气化障碍的代谢产物的治法相配合运用，如利水用猪苓、茯苓、泽泻；化湿用苍术、陈皮、木香；理气行气用青皮、陈皮；活血祛瘀用当归、川芎、红花、苏木；消食积用麦芽、神曲、三棱、莪术等。从东垣到今天，甘温除热法的各种配伍已经大大地扩展了，但无论如何扩展，都不过是从如何正确地处理气（阳）虚、热象和气机、气化障碍及其产物这三个部分而出发的。这个基础结构一直没有发生变化。

东垣用药，药量小而药味多，后世对这种用药方法有褒有贬，赞者云其多而不乱，恶者谓之杂乱无章。我几十年的临床体会到，当“脾胃之气下流”，“阴火上乘”，津液和营血又容易瘀积的时候，既要权衡升降，又要掌握补泻，已非易事，再感六淫，或伤七情，病情自然就会更加复杂。试问，那时到底抓住哪个环节，才能够出现理论上所谓的纲举目张？所以，东垣的这种用药方法，也是从临床实践中不断摸索出来的治则。药味多，才能处处兼顾到，药量少，才不会再伤脾胃。临床证明，这种从实践中产生的多方兼顾的用药法，有它的客观道理，有它的使用范围，这决非杜撰标新，而是行之有效的。因此，有在临床实践中进一步发展、

完善和充实这种用药法的必要。

使用甘温除热法，要想取得较好的疗效，我认为必须抓住以下几个要点：

1. 脾宜升则健，胃宜降则和，升降运动是脾胃的主要活动，而这一活动又是全身气机升降的枢纽。升降是相辅相成的，有时清气不升，是因为浊气不降，降浊则清升；有时浊气不降，是因为清气不升，升清则浊降。所以，使用甘温除热法，要善于权衡升降，不要把升降看得绝对，要灵活地运用升降间相互调整的规律。

2. 发热和气机障碍的产物之间，总是相互联系、相互影响的。痰、瘀、水、湿、食等有形之物，可以郁而化热，这种热多为低热；外邪入侵又往往与之相结合而形成痰热、瘀热、湿热等，往往又表现为高热。我把这种情况称为外内合邪，治疗上不内外兼顾是不行的。

3. 人身五脏六腑、十四经脉，三百六十五络，不可能是一热俱热，一寒俱寒，总是此寒彼热，此虚彼实。从整体上看去，就是寒热并存，虚实共见的局面。因此，甘温除热法应根据具体的情况，与清化湿热，温化水饮，温补肾阳，滋养肝肾，疏风解表，活血化瘀等治则相配伍，这不仅在理论上合乎逻辑，而且临床实践也证明了其正确性。

4. 脾喜刚燥，胃喜柔润，甘温之剂除要权衡升降外，更要注意调整其润燥。倘病员肝肾阴亏，或胃液不足，而中气又虚馁，用药就既要忌臃滞以防更伤中阳，也要避温燥以防更耗阴液。但这个忌和避不是绝对不用的意思，象圣愈汤中参、芪和地、芍同用，说到底，就是一个燥润得宜，刚柔相济的问题，此时，甘温濡润，最为得宜。

5. 发热之疾需用甘温剂者，其诊断要点有：面色晄白或黯；疲

乏，精神萎顿，困倦，语音无力，甚者觉气息下坠；食欲不佳，或劳动后食量当增而反不欲食；脉不论浮、沉、迟、数，以虚为主；大便常溏薄不成形。不论病的症候表现得如何复杂，这些本质性的表现总是兼挟在其中，只要从中抓住它们，就可以放胆地使用甘温除热法与其他治则相互配合。兹举两例验案于后：

张××，女，27岁，教师。1976年9月12日，病员从本月7日发病，腰痛厉害，心中发冷，皮肤发热，呕吐，口干，汗多，纳差，饮水即吐，卧床五天，转中医治疗。脉沉数，舌质红，苔干黄且厚，平素面白疲乏，大便溏薄。处方：草果10克，知母10克，乌梅10克，生姜汁1勺，厚朴10克，黄芩10克，法半夏10克，天花粉12克，麦冬12克，党参20克，黄芪15克。水煎服。一剂。

9月13日，病员呕吐、自汗均止。午后潮热，面红耳赤，发热时有汗，仍用上方加青蒿10克，鳖甲10克。水煎服，二剂。

9月15日，病员能起床活动，食欲及诸痛的好转，午后潮热减，舌苔减少，口苦，小便黄，大便溏薄。仍用上方加炒白术10克。水煎服，二剂。

9月19日，热解痛微，双手肩髃穴至合谷穴中有冷痛感，口干，脉弦细，面色白，精神不振，舌质淡红，苔白薄滑。此正如叶天士所说的“面色白者须要顾其阳气，湿盛则阳微也。法应清凉，然到十分之六、七，即不可过于寒凉，恐成功反弃，何以故耶？湿热一去，阳亦微也。”用《济生》归脾汤，五剂，得以恢复，返回工作单位，其体力精神均已恢复如昔。

刘××，女，36岁。七月盛夏，陪客游玩，出汗较多，又食油腻，归家后次日即高烧发40℃，因困倦乏力，精神萎顿，汗多口渴，面色潮红，尺肤灼热，自觉气息下坠，烦躁欲死。舌质红，苔滑微黄，日痛泻五、六次，所下秽臭如酱，服王孟英清暑益气汤，无效。越三日邀我诊时，症状仍如上述，病员面色灰如着粉状，踟卧懒言，脉虚大面缓，此乃暑伤元气，兼挟湿邪。用李东垣清暑益气汤加味：党参10克，黄芪10克，苍术6克，升麻3克，泽泻9克，陈皮4.5克，白术9克，当归6克，麦冬10克，炙甘草4.5克，炒神曲6克，炒山楂6克，炒麦芽6克，生姜1片，大枣3枚，黄柏9克，青皮5克，葛根10克，五味子4.5克。水煎服，一剂。

服药后，于当日晚即趋平稳，次日来诊，已能起坐床头，原

方再服二剂，遂愈。

孟英方适用于暑热偏重，胃津耗损的病员，症见肌肤灼热，舌绛咽干，汗出烦渴，食纳不佳，大便燥结，脉呈弦细而数者。东垣之方用于暑中挟湿、暑伤元气者，症见四肢无力困倦，精神萎顿，胸满气促，身热心烦，口渴多汗，大便溏色黄而脉虚者，此乃甘温除热剂也。

总之，所谓甘温除大热者，即中气（阳）不足之人，因外感六淫，或内伤七情，以及夹杂痰、饮、食、湿、瘀等有形之邪而致发热的病症，此等情况，不用甘温补其中气（阳），正气不支，则邪难退却，实乃治体顾正之法，并非甘温本身即能除大热也。经云“甚者从之”，就是这个意思。

第四部分 方 剂

傅山宣郁通经汤

宣郁通经汤是《傅青主女科》中的一个方剂，傅氏用于治疗经水未来腹先疼，疼痛数日后，经来多是紫黑色血块，其病机是肝中之郁火焚烧，用此方补肝血、解肝郁、利肝气、降肝火。方药组成：白芍（酒炒）15克，当归（酒洗）15克，丹皮15克，山梔（炒）10克，白芥子（炒研）6克，柴胡3克，香附（酒炒）3克，黄芩（酒炒）3克，生甘草3克，川郁金（醋炒）3克。水煎服，连服四剂。

几十年来，我运用此方，积有所得，临床上感到颇为顺手。这里主要介绍我对宣郁通经汤使用的诊断要点和在虚寒与肝火并见时运用本方的一些体会。

傅氏在书中指出，运用此方的症候为：经水未来腹先疼数日，经来多是紫黑血块。但据我的临床体验，这些症候即使对典型的病例也只能作为其中一部分诊断依据，对于较为复杂的病例，就更不能作为诊断要点。我临床使用此方的主要指征，可以归纳为如下三点：

一、主要是用于治疗肝郁化火，血瘀胞络而致的痛经病。就

临床体验来看，痛的时间，有在经前，有在经后，有在行经期中，不似傅氏所讲，仅在经前疼痛。其月经多表现为先后不定期、经行不畅、少腹作胀、乳房胀痛、胸胁胀闷、脉弦等症。至于疼痛的性质，有参考价值，比如胀痛厉害者，可加台乌、沉香等行气之品；如刺痛明显者，可加蒲黄、五灵脂等活血止痛之品。

二、经来时，既可以是紫黑色的血块，但也可以是淡色的血液，这可以根据病员的具体情况而有所不同，着眼点还在于月经量较少，和经行不畅等肝郁气滞症共见。

三、舌质红，舌苔或白或黄一般不厚，口干，口苦，脉弦数，心烦易怒，头痛耳鸣，眼睛有红丝。

不论是单纯的，或是兼挟较为复杂的肝经郁火所致的痛经病，只要在肝气郁结的基础上，再具备痛经、月经量少、舌质红、口苦、脉弦数等主要症候，都可以使用此方。再根据临床上的其他具体情况，加减出入，皆能获得良好的疗效。试举两例虚寒和肝热并存的痛经验案，说明以上诊断要点的临床运用。

冯××，女，33岁。1964年，经期涉冷水后，便发生痛经，经来量少，色淡，少腹疼痛，有时经期疼痛厉害，简直无经血，有时经来色紫，但经水有瘀块的时间极少。经期延后。多次到外地检查治疗，诊断为虚寒性痛经，习惯性痛经，但经治疗却无效，一直未生育。1979年5、6、7三个月月经来时，疼痛特别厉害，发生不同程度的昏厥。

1979年7月10日初诊，正值经来，脉沉略数，舌边尖红，苔白，四肢微冷，月经量少色淡，口苦，心烦，少腹疼痛厉害。用宣郁通经汤合玄胡金铃子散，当归15克，白芍15克，香附12克，丹皮12克，白芥子10克，柴胡3克，郁金6克，栀子12克，黄芩10克，玄胡索10克，金铃子10克，水煎服，三剂。

8月11日二诊，病员服上方后，经期疼痛明显减轻，由往昔连续疼痛2~3天减少到5~6小时，痛时自觉双下肢发冷，准备服药预早防痛，仍处以上方三剂，嘱经期服。另开一月经过后服方：党参15克，白术15克，茯苓12克，莲子12克，陈皮10克，炒谷芽10克，炒麦芽10克，炮姜6克。

9月16日三诊，病员8月份月经来前基本不痛，经来后也仅痛2小的左右。昨日晚又开始行经，双下肢微冷，胃胀，疼痛明显短暂，仅40多分钟。舌质赤，脉弦数，心烦，神识有时恍惚而不能控制。询其原因，谓今年4月份晚上行路被惊吓后，不仅使5、6、7月份痛经更加严重，并且增加神识恍惚一症。处方：

一方：栀子10克，良姜10克，香附10克，丹参20克，枳壳10克，没药3克，鳖甲15克，柴胡3克，僵蚕10克，甲珠3克，桃仁6克，地鳖虫3克，水煎服。

二方：白术15克，山药20克，党参30克，茯苓10克，巴戟10克，扁豆12克，白果10枚，莲子15克，桃仁6克，红花6克，木香6克，水煎服。

嘱病员经期服一方，平时服二方。

此案痛经，长达十五年之久，得病之由，为经期涉冷水，自后经来量少色淡，四肢发冷，脉沉，经期延后。这些症状很容易使人诊断为虚寒性痛经，经云“寒甚则痛”，厉害的疼痛自然也很容易使人联想到是寒客胞宫。但此病员舌边尖红，心烦，口苦，脉虽沉却略数，这些症状却无法用虚寒痛经的病机去得到圆满解释，而是痛经的本质表现。在临床上，不论病员的兼挟情况表现得如何复杂，这些本质性的症状却往往夹杂在其中，在变化中保持着不变的地位，抓住了它们，就能把握住整个病机。所以，此案使用宣郁通经汤后而疗效颇著。使长期的痛经病在短期内得到控制。

黄××，女，23岁。1977年7月初诊，结婚时适逢经期、淋雨，后即发生痛经。经来量少，夹少量血块，色紫，乳房胀痛，胸胁闷胀，少腹冷痛，痛时喜蜷缩，盖被而卧，经期有时提前，有时又缩后，极不规则。平时畏寒，面白，颜面略浮肿，肌肉松弛，四肢无力，疲乏，大便溏。结婚三年未生育。今舌边尖红赤，苔薄白，口中腻而微苦。诊其脉并不沉迟，也不浮数，每分钟70次，应指无力，白带量多有时色黄。处方：

一方：当归15克，白芍15克，香附12克，丹皮12克，白芥子10克，柴胡3克，郁金6克，栀子12克，黄芩10克，木香6克，水煎服。

二方：党参12克，白术12克，茯苓12克，甘草3克，巴戟10克，山药15克，益母草20克，陈艾叶（醋炒）10克，陈皮10克，煨姜2片。水煎服。

嘱病员经来时服一方，平时服二方。

8月二诊，病员经来疼痛减轻，精神好转，上二方已各服三剂，这次月经来时经量较前为多，畏寒、疲乏、便溏等症均有好转。仍用上二方，服法照旧。

11月三诊，近几月来，痛经基本痊愈，经期亦正常，上一方加丹参15克，二方加桑寄生12克，仍照旧服用。察精神好转，食量增加，体力渐旺。

1978年2月，停经两月，出现妊娠反应，处以第二方，去陈艾叶、巴戟、益母草，加青果10克，黄芩10克。

孕妇足月后，顺产一男孩。

此案病起于结婚遇经期、淋雨之后，即出现月经不调、痛经，其中面色㿠白、浮肿、肌肉松弛、四肢无力、大便溏薄等症，为脾气虚的常见症候。而舌边尖红赤、心烦、口略苦，经来有少量紫色血块，又为肝经郁火，兼挟瘀血之特征。这里值得提出的是，肝经郁火又何以脉不数？从理论上推测，脾胃虚寒脉当迟，肝经郁火脉又当数，二者相合，所以脉之至数反较正常。因此这类病症，着眼点应当放在舌质和舌苔上，特别是舌质一般很难受到干扰。当虚寒重于郁火时，脉反呈迟，当郁火重于虚寒时，脉又会偏数，但不论迟或数，均难以出现实证的有力搏动。

以上两案，均确有虚寒症候，但按虚寒治疗，却疗效较差。这都说明导致痛经的直接原因是肝郁化火瘀阻胞宫，而虚寒乃是其他脏腑的问题，并不是构成痛经的直接原因。由虚寒而直接引起的痛经，往往表现为绵绵而痛，受凉更甚，得温即缓，舌质淡。我治疗这种寒热夹杂的痛经病，在月经期中用宣郁通经汤，平时使用甘温补剂，这种治法通过临床实践，是行之有效的，颇能切中病机，对于体质的改善，疼痛的缓解，均比寒热攻补，处处兼顾，汇于一方不分时间服用者为好。这是为什么呢？我认为，痛经是有规律的经来腹痛，既

然肝经郁火、瘀阻胞宫为导致痛经的直接原因，那么，经期疼痛时，理所当然应该以清肝泻火祛瘀为主要治则。当月经过后，疼痛停止，而虚寒证仍存，这时它脏虚寒也就自然上升为主要矛盾了。因此，如果把温、清、补、泻汇于一方，表面上似处处都顾及到了，实质上却主次不分，阶段不明，使治疗的针对性发生了误差，所以，治疗不分阶段和时间，是造成上述两案久治不愈的根本原因。

综上所述，此方不仅可以用于除肝经郁火外，其它脏腑亦同时呈现热象的痛经，也可以用于其他脏腑同时呈现虚寒症候的痛经，其病机区别的关键在于痛经的直接原因是否是由于肝经郁火、瘀血阻滞胞络而引起。只要这个基本因素存在，其他脏腑的寒热虚实均不影响对此方的使用。

使用此方的诊断要点为：痛经，经来量少，舌质红，心烦，口干，口苦，脉数。其中特别是痛经，量少，舌质红（临床上主要是舌边尖红）为必具的症状，这几点在行经期间其表现尤其明显。至于经来有血块、色紫黑等，乃是对典型证型的叙述罢了。

使用此方治疗痛经，最好是在经期阶段服用。在开始有疼痛感觉时，服药至月经干净，只有在这个时候服用此方疗效最佳。若平时服用，有的人根本毫无效果。而平素虚寒者，甚至可能有副作用。

薛生白仿吴又可三甲散

薛生白仿吴又可三甲散，由醉地鳖虫、醋炒鳖甲、土炒穿山甲、生僵蚕、柴胡、桃仁泥六味药组成。薛氏将此方用于湿温证

中，暑湿不得外泄，深入厥阴，引起络脉凝瘀，心主阻遏，灵气不通，而出现神识昏迷，默默无语，口不渴，与饮食亦不却等症候，进辛开凉泄、芳香逐秽之法俱无效者，用此方“破滞破瘀，斯络脉通而邪得解矣。”（薛生白《湿热病篇》34条自注）

薛氏方中桃仁、地鳖虫善破血行瘀，鳖甲、地鳖虫能软坚消癖，僵蚕、鳖甲消痰散结，甲珠是透达经络的要药，柴胡则疏肝理气，宣畅气血。整个处方性偏寒凉，味属咸苦，是一张逐瘀消痰、软坚散结的昆虫动物类通络方剂。早岁行医时，我按薛氏所叙之症运用，尚属应手，临证时间长了，逐渐体会到薛氏方对于痰热与瘀血胶结脉络，阻碍人体气机，从而表现出的多种病症均能异病同治，并且有着较好的疗效。从络脉分布情况来看，十五（六）络脉不断分支，脉气逐渐细小，由线状延展扩大为面状弥散，输送营卫气血以渗灌温养濡润周身组织，络脉不仅分布于体表，也进入胸腹里，联系内脏。如《灵枢·痛疽》说：“中焦出气如雾，上注溪谷，而渗孙络，津液和调，变化而赤为血。血和则孙络先满溢。”十五大络统帅全身络脉，《内经》对十五大络所举其病变的具体内容虽然不多，但从中可以看出，基本上是符合于十二经脉脏腑症候的范围。这就说明络脉病变完全可以通过内在的联系进而影响到十二经和五脏六腑发生病理变化。由于细小的络脉遍及全身各处，所以湿热和瘀血既可能相互胶结在心包，造成薛氏所叙之症，也可能阻遏在另外的部位，造成另外的危害，引起其他的症候。因此，这张处方，完全可以异病同治痰热和瘀血相互胶结于任何络脉之中的所表现出来的任何病症。今试举几种病症的治验来加以讨论，谈谈我对薛氏方的临床使用体会。

一、胃痛（湿热瘀血痞结胃脘痛）

胥××，女，27岁，社员。1973年8月初诊，病员胃脘部持续疼痛，拒按，

不思饮食，心中烦热，时觉畏寒，已二十余日。形容消瘦，面色青白，语音低微，呻吟不已。妊娠七月，脉却弦数，左寸隐伏而涩。舌下金津玉液两穴处青筋显露肿胀，色紫黑，苔灰腻、微黄，属湿热痞结胃脘，挟瘀作祟。治以辛开苦降，^①佐以活血化瘀，用吴鞠通椒梅汤加减：乌梅10克，白芍10克，法夏10克，黄连10克，黄芩10克，良姜10克，枳实10克，党参12克，丹参18克，花椒20粒，木香6克，官桂10克，乳香3克，没药3克。水煎服。

二诊，疼痛略减，寒热除，余症如前。攻邪即是保胎，亦如急下存阴，本属一理。宜继续用药，更进一畴。

梔子10克，良姜10克，香附10克，丹参15克，玄胡10克，鳖甲15克，甲珠6克，地鳖虫10克，柴胡10克，桃仁10克，没药3克。水煎，少量频服。

三诊，疼痛大减，渐思饮食，脉诊仍不见胎脉，续服此方，小其制，减桃仁为6克，丹参10克，地鳖虫6克，加煅牡蛎12克。水煎服。

四诊，疼痛更减，发作之时亦少，昨夜腹胀骤加，以致不能入寐。滑利之胎脉已现，知其气道已通，气化欲行。灰黄之苔色已去，惟余腻象，今之胀者，乃欲行之气化阻于水气不通也，通之即快。

山楂31克，莱菔子（炒）10克，紫苏梗10克，通草6克。水煎服。

五诊，痛去胀止，大病去后顿感疲惫，拟用加味四物，一靖余氛，一养胎元。

当归12克，川芎10克，生地20克，白芍10克，杜仲10克，川断12克，黄芩10克，苡实31克，青果10克，桑寄生15克，菟丝子12克。水煎服。

三月后，孕妇顺产一女孩。随访至1981年，身体健康，智力正常。

二、头痛（阳气虚弱、痰瘀互阻头痛）

李××，女，51岁，干部。病员近十年来头汗颇多，脉却沉细而微，每年入冬两足厥冷不敢相倚。1976年2月值夜班于凌晨4时许，曾昏迷，自后时时感到疲乏头昏。3月份洗头后，即感右颞痛，遭刮大风，即此卧床不起，右边前额、眼眶并连及牙齿，时刺痛、时压痛、时酸痛、时胀痛，总之，无法形容其的疼痛难受的感觉。痛时痛处潮润多汗，口鼻气冷。病员素体阳虚，手足夙昔不温，今更甚，必重衾厚帽。每因天气变化而加重，尤以吹风天最难受。舌质淡，苔薄白根部微腻。近半年来，曾服羌活附子汤、指迷附子细辛汤及白通汤、白通加猪胆汁汤、选奇汤、四逆汤、当归四逆汤等，均无甚疗效。因考虑到病变部位如此固定，痛处皮色较它处为深，眼眶略肿，7月

中旬以后，就开始将温阳益气之剂与血府逐瘀汤合方，服数剂后，疼痛程度虽未明显减轻，但发作时间有所减少。8月中旬，我诊视后，书与薛氏之方合四逆汤，其效甚著，三剂后，疼痛基本得到控制。为了巩固疗效，至11月份，续服此方30多剂，停药后，除头痛未曾复发外，在服薛氏方期间，还明显感到有特殊好转现象，头汗有所好转；沉微之脉与厥冷双足有好转；幼时不慎压坏了右手食指，指甲凸起增厚变形，几十年来一直未曾长好，服薛氏方后，居然逐渐完好矣；痔疮多年，平时经常出血下坠，年年春秋必然大发作，今已数历秋春，尚未再度依季而发作。

三、梅核气（痰瘀胶结梅核气）

白××，女，37岁，社员，1975年11月初诊，平素心胸隘，稍不惬意，即郁郁不乐。1975年5月份，感到大抒，肺俞穴处有疼痛酸麻感觉，食道喉头部似有物阻塞，吞之不进，吐之不出。此症于1974年亦曾发生过，但没有这次严重和持久，两次发作均在连续生气之后才出现。医生以梅核气治之，所服的方如四七汤、半夏厚朴汤、瓜蒌薤白汤等等，一时有效，一时又无效。食道吞钡透视，无异常发现。口苦，心烦，急躁，脉弦滑，舌尖略红，苔黄根腻，乃用温胆汤加柴胡、玄胡、香附、木香，初服尚可，续服却依然如故。其舌质虽无瘀点，但病程长，病位恒定，情怀抑郁，气滞既久，必致留瘀积痰，治痰不效，乃痰瘀胶结未能兼备之故也，舌下青筋肿胀，完全支持这种看法。用薛氏方加枳壳、菖蒲、法夏，服六剂后，就控制了上述症状，尔后偶有发作，一服上方即愈。

四、痿痹（湿热淫筋、气钝血滞痿痹）

李××，男，3岁，身体素壮。1976年11月麻疹愈后，右下肢突不能站立，晚上发烧，饭量减少，经×医院检查，疑为小儿麻痹症，每日注射加兰他敏，口服强的松、维生素B₁片剂等，住院治疗一月无效，而转中医门诊治疗。

1976年12月26日初诊，患儿能坐不能立，立则哭泣，肚脐右边见一小疱，发红，舌苔黄腻，小便黄，额热有汗，脉浮数，喜饮温水，患肢皮下青筋明显隆起。此湿热淫筋，气钝血滞之痿痹，宜薛氏方加味：

银花18克，连翘18克，丹皮10克，赤芍10克，重楼12克，白芷10克，僵蚕10克，柴胡6克，桃仁6克，甲珠6克，鳖甲12克，地鳖虫3克。水煎服。

1977年2月13日，共服六剂，每服后肌表均透发一次痒疹，而逐次减轻，痒疹也随之而逐渐好转。五剂后，患儿即能如从前一样跑跳和站立，仅一身发痒但不甚。夜寐常蹬被，此湿热外透之佳兆。口渴舌质红，用叶氏养胃汤加土茯苓10克，地肤子15克，以善其后。随访至1981年，痊愈如初。

五、心悸（心脾两亏、痰瘀阻遏心悸）

郭××，女，33岁，干部。1972年12月底，被猪咬住摔伤，左脚膝上和右下腹部破皮出血。不久又长途乘敞车受凉感冒，适逢月经到来，自此即感心跳、心慌，严重时行动都感困难，只能卧床休息。每次发作时，脉搏却基本正常。平时有一种莫名其妙的害怕感，甚至听到别人高声说话，也自觉心跳不已。如果心中觉得拿不起一个茶盅，那么，未拿之前就觉疲乏和心跳，怎么也没有力量去拿。倘若事先没有想到过拿不起，那么，拿比茶盅重几倍的东西也是轻而易举的事，既不疲乏，也不心跳。病员也自知这些，但无法克服，不仅如此，且愈想克服愈不能控制。在××神经病医院按神经官能症治疗一段时间无效，后转中医治疗，大抵为安神镇静、补养心脾之剂，逐渐好转到能支持上班工作半天。

1976年9月，刚上班几天，因口鼻气热，经某医书方（黄连、黄芩、黄柏、滑石、生地、地骨皮），服一剂后遂使诸症严重复发。9月底便住入某医院，请我诊治，舌面两畔有明显瘀点，舌下青筋显露，得知病起于猪咬伤和经期受凉，更兼之病程长久，病位固定，症状无甚变化，乃处以薛氏方配仁熟散（柏子仁、熟地、枸杞子、五味子、山萸肉、桂枝心、党参、菊花、枳壳），服一剂后果然收到捷效。自此以后，病情厉害时，就服薛氏方配仁熟散，发作轻时就用血府逐瘀汤合仁熟散，平时则服用《济生》归脾汤。到1975年12月，已能整天工作，随访至1981年，疗效仍然巩固。

讨 论

一、薛氏方中使用了昆虫动物类药物，这与相同作用的植物类药物有一定的区别。唐容川在《本草问答》中指出：“草木植物也，昆虫动物也，动物之攻利，尤甚于植物，尤其动物之性本能

行，而又具有攻性，则较之植物本不能行者，其攻更有力也。”所例验案，似能支持这种看法。例一有一般活血祛瘀之剂与薛氏方的对比，例三有一般豁痰破滞和清化痰热药物与薛氏方的对比。而例二用血府逐瘀汤有些疗效，用薛氏方则疗效显著，例五轻时用血府逐瘀汤有效，重时就只有求助于薛氏方。由此可见薛氏方破滞破瘀、化痰散结比同类植物药物作用更强。因此，临床上用一般植物对症之药无效，但无弊，或有效不显著者，均可选加同类昆虫动物类药物治疗之。正如叶桂所说：“久则邪正混处其间，草木不能见效，当以虫蚁疏通逐邪。”

二、叶桂说：“非辛香无以入络。”而薛氏通络方却以咸味为主。对治疗痰瘀的药物来说，一般辛味疏散开通理气，流畅和利血脉，咸味攻坚削垒，软坚散结消癖，较之辛味更有力于固结之邪。另一方面，叶氏又强调病情留伏较深，必用虫蚁搜剔，病情轻浅，多用行气活血之品。并认为虫蚁迅速飞走诸灵，能使血无凝著，气可宣通，可以松透病根，治疗一些干血、恶瘀结聚很深的劳伤血痹等顽固疾病。而虫蚁之品其味又以咸味为主。因此，我认为辛升咸降，辛散咸软，辛流气和血，咸软坚消癖，在对痰瘀固结症候的治疗中，于咸味中佐以辛香，能有协同作用，既攻坚垒，又畅气血，对气机的恢复，痰瘀的排除，比单用咸味更能顾及周到。具体使用方法有两种：一是配伍以辛香之药，如例一配伍香附，例五配伍桂枝心、枳壳等；二是炮制，使之具备辛香，如酒炒地鳖虫、土炒穿山甲、炒香枳壳等。

三、《本草纲目》认为，穿山甲能消痈肿，排脓血。《本经》说：鳖甲“主心腹癥瘕坚积、寒热，去痞息肉、阴蚀恶肉。”僵蚕亦有行经散结的作用，陈源生老中医临床治验，用僵蚕配乌梅蜜制为丸，治各种瘰肉。一般来说，活血祛瘀和软坚散结的方剂，均有

除旧生新的作用。从例二痔疮好转和指甲复原的情况来看，是与薛氏方的这些作用有关。对于攻坚破积，软坚散结，破血消癥，从而推陈出新的方剂的使用指征，我的体会是不能完全局限在视之有物，触之有形这个范围内，因为这里有个由量变到质变的过程。坚谓坚固，血有死血，络脉蚕丛而弥漫，痰瘀留于其中，亦是癥，也是结，胶结于细微曲折之处，就是坚。于此等症候，猛剂攻消无益，辛香疏散不易，唯宜用软坚散结，破血消癥，通络化痰之剂缓缓图治，尚望络通，络通则气血流畅，气机、气化正常自能去旧生新。因此，我使用此方，不仅用于有形之疾，更用于无形之疾，诸如梅核气、痿痹之类疾病的治疗，就是基于这种认识去指导施治的。

四、有诸内必形诸外，络诊方法，古已有之。《灵枢·经脉篇》说：“凡此十五络者，实则必见，虚则必下。”“胃中寒手鱼际之络多青矣；胃中热，手鱼际络赤。”一般规律是以络脉的隆起和下陷来判断病变的范围。络诊对薛氏方的使用有一定的指导价值，痰瘀交阻属实，脉络隆起易见。所举案中一种是注意病变部位的脉络情况，如例二痛处皮色较它处为深，眼眶略肿；例四患肢皮下静脉青紫隆起明显。另一种是采用张赞臣医师“舌下望诊法”文中介绍的，“如舌下经脉粗胀，色作青紫，甚则带有黑者，大都肝郁失疏，痰热内阻，瘀血郁积之证……舌下经脉与心肝两经有密切关系，不论身体任何部位有何瘀积或痰湿内阻，脉道不利时，皆可现之于舌下经脉，且其部位又在薄膜之内，清晰可辨，检查方便。”我认为，络诊方法确实能补充其它诊法之不足，象“然经年累月，外邪留著，气血皆伤其化为败瘀，凝痰混处经络。”“远客路途，风寒外受，热气内蒸，痰饮日聚于脏腑之外，络脉之中。”（《临证指南》）诸如此类病症，倘若舌苔不腻，舌质无瘀点、瘀斑，就

只能从“久病入络”去进行诊断，倘辅以络诊，则诊断准确性就可以提高，否则，往往会因为舌苔不腻，舌质无瘀点、瘀斑，而忽视或无视对痰瘀互阻的诊断。

五、《素问·六元正纪大论》说：“黄帝问曰：妇人身重毒之何为？岐伯曰：大积大聚，其何犯也，衰其大半而止，过者死。”妊娠患者，需要使用通络之剂，也必须遵照以上原则。何谓大半？标准为何？关于这一点，各人有各自不同的体会，临床中我发现不少需要使用攻逐之剂的妊娠患者，常常是脉诊无胎脉感，因而我使用攻逐之剂，就是以胎脉出现为不再使用的标准之一。如例一脉诊无胎脉，胎脉出现后，即不再使用薛氏方。至于此案服药采取少量频服，是既便于观察情况，又有利于中病即止，还能使药力持续。我体会到这种服药方法，既不影响疗效，同时保险系数又大，值得注意。

六、例二系素体阳虚，用此咸寒之剂的原因何在？例二头汗多，环项而止，是局部早有化热现象，所以半年来服温阳益气、驱风除湿而无甚疗效。这里就需要将整体与局部的矛盾兼备起来，四逆汤合薛氏方正兼备了这点，故尔见效较速。另外，薛氏方亦可用了寒证，单取其破滞破瘀的功用，也如性寒之大黄一样，有大黄附子之配伍形式。

七、络病之邪，除血瘀凝痹外，往往兼挟有痰饮、湿浊、阴寒、燥火等邪，而薛氏方所治之证，以血瘀痰浊凝着，兼挟燥火为主的络病，临床上诊断的要点为：

1. 有络脉瘀阻之征，如疼痛，脉涩，而色、舌色、舌底有瘀点、瘀斑、紫暗，腹腔痞胀、积聚等；

2. 有痰浊留瘀滞络的表现，如苔腻，舌下青筋肿胀，舌体略胖等；

3. 病程较长，病位固定等。

八、无痰瘀胶结之证，阴寒之证均当慎用薛氏方，用之不当不唯不效，反而有时会加重原有症状，因为薛氏方毕竟是咸寒通络之剂。

一、三甲散理法再探

三甲散出自吴又可《温疫论》，方由鳖甲、龟板、穿山甲、蝉蜕、僵蚕、麝虫、白芍、当归、牡蛎、甘草等十味药组成，治疫病中之“主客交浑”证。吴氏谓其病机是“客邪胶固于血脉，主客交浑，最难得解，且愈久益固。”但对症状，却仅说“谷食暴绝，更加胸膈痞闷，身疼发热，彻夜不寐。”薛生白可谓善于吸取前人经验，他在《湿热病篇》中，将吴氏三甲散加减为：醉地鳖虫、醋炒鳖甲、土炒穿山甲、生僵蚕、柴胡、桃仁泥，治湿温证暑湿不得外泄，深入厥阴，导致络脉凝瘀，心主阻遏，灵气不通者，是已超越治疫范围。薛氏对病机亦有更清楚的说明，认为主客浑受乃是“阴阳两困，气钝血滞而暑湿不得外泄，遂深入厥阴，络脉凝滞。”用三甲散“破滞破瘀，斯络脉通而邪得解矣”。由于吴氏言之较略，薛氏又把适应证局限于厥阴，更兼其他种种缘故，三甲散所传不广，临证使用范围较窄。而此方一旦运用得法，又颇能显出其独特疗效，故值得进一步阐发。

综观叶天士论述络病当用虫类药物时，其语言酷似吴氏“客邪胶固于血脉，主客交浑”等语。故而薛氏便遂言三甲散证为络病。《内经》所举络病症候范围，未离十二经脉、五脏、六腑，叶天士络病症候亦未超越这个范围。由此可见，脏腑支配经脉，经脉统率络脉这个规律，在络脉的病变中仍起着作用。我认为，络

脉病变的产生有两种途径和传变趋势，一是脏腑经脉病变引起络脉病变，二是络脉病变进而引起经脉脏腑发生病变。叶氏初病在经久延血络的说法，应该说只讲明了络病产生的一个途径和发展趋势。而络脉自身和直接的病变，应当是初伤血络，久延脏腑。不承认络病有两种产生途径和发展趋势，也就是说不承认初病即有伤络和在络的情况，就既不能很好地解释，更不能很好地指导临床。比如虫、蛇、蝎等咬伤中毒的过程，疔疮走黄过程，由经穴伤而造成内脏伤损，由针刺而造成气胸，溃疡引起穿孔，都明显是由络病而延及经脉脏腑，至于跌打损伤则更是初伤络脉了。只有正视和承认络病既可由经脉脏腑久延而来，又可直接产生的客观事实，才能提高临床络病的诊治水平。

吴、薛二氏的三甲散，共同药物为虻虫、鳖甲、僵蚕、穿山甲。此四味皆为虫类药物，合用则收剔，通透血络的作用较强。鳖甲善长于软坚消痞，《本草便读》说“性本咸寒，入肝达络，功行瘀癖，退热潜阳。”《医学衷中参西录》说：穿山甲“气腥而窜，其走窜之性无微不至，故能宣通脏腑，贯彻经络，透达关窍，凡血凝、血聚为病，皆能开之……若旦知其长于治疮，而忘其他长，犹浅之乎视山甲也。”僵蚕熄风解痉，化痰散结是其主要作用，《本草纲目》指出：“治风、化痰、散结、行经，所谓因其气相感，而以意使之也。”综合起来，其作用为行瘀消癖、软坚散结、解痉化痰，这些作用可以广泛用于多种络病的治疗。何以说此四味可以广泛用于络病的治疗呢？这是因为络脉中运行的是气、血、津、液，因此，一旦络脉瘀阻，虽以血瘀凝癖为主，却自然常会兼挟痰饮、湿浊，倘外邪相加，还会兼挟阴寒、燥火、风湿等。吴氏所谓疫邪胶固血脉，薛氏所谓暑邪深入厥阴，就是指此而言。这些邪气兼挟沉混，阻于络脉，用此行瘀消癖、软坚散结之品，就

其病理机制来说，是再恰当不过的了。

二、三甲散证的诊断要点

络病可因其病变范围的大小、部位的不同而表现出多种多样的病变和症状，因此，对三甲散证的临床诊断不能局限为某些病或症。不论何种病症，只要病变部位比较固定，就具备了络病的根本特征，不论其病程长久与否。目前临床上一般认为，疼痛、脉涩、舌色有瘀点、瘀斑或紫暗、腹腔痞块、积聚等，为有络脉瘀阻之征；以苔腻、舌下青筋肿胀、舌体略胖涎多等，为有痰浊阻络的表现，我在临床上也重视这些诊断方法。但我认为，当不具备这些明显的外在表现时，只要病位比较固定，再加上有络脉不通所表现的症状，三甲散就可以作为基础方而加减使用。归纳起来，诊断要点有四：

1. 病变部位比较固定；
2. 出现明显的痰瘀胶固络脉症状（可参考上文讨论）；
3. 表现为局限性经络的异常而呈持续的状态，如疼痛、麻木、酸胀等；
4. 有直接损伤络脉的病史，如血症、外伤、经产、手术等，这些病史又为其他病症产生的原因。

前三个要点中，第一条是根本，非此莫属络病，在其基础上出现第二条或三条，而第四条必须出现前三条中的情况，就可以作为三甲散的适应证。至于病程的长久与否，并不能决定三甲散之能否使用，但却能帮助对络脉瘀滞程度的了解，所以，我一般不列入诊断要点内。

由于叶氏强调久病入络之说，所以，一般对虫类药物的运用，

以久病为依据。但是我在临床上，发现不少疾病病变并不长久，也常常具备上述络病特征，用一般草木之剂无效，或有效不显，则使用三甲散以通络则常获显效，这就为初病亦有在络的理论提供了临床实践依据。所以，我在归纳诊断要点时，未将时间长久作为必据者，事实上，临床中久病不入络者亦非少见。我认为，薛氏使用三甲散之证亦非久病，我在临床上所见这类证型不少，除薛氏所叙情况外，妇女热入血室的类型中亦可见到，我也曾用薛氏原方治愈多例暑温病人外伤后变为典型薛氏所谓深入厥阴之证，其病史均在数天之内。所以，对三甲散的运用千万不能拘泥于时间之长短，要以上述四条综合判断。兹分析两例病案以证之。

曾××，男，30岁，驾驶员。五年前曾患坐骨神经痛，经理疗及服中西药治疗数月而愈。今出差潮湿地区一月半，回来后数日即感左下肢从环跳至承山处麻木、重着，腿伸直则拘急疼痛。舌质正常，苔薄白，脉弦紧。处方：地鳖虫3克，鳖甲12克，僵蚕9克，穿山甲6克，白花蛇1条，全蝎1.5克，当归12克，牛膝10克，桂枝12克，桑寄生15克，细辛4.5克，水煎服。服十剂，即痊愈。

此症初起，但病变部位固定，呈持续的麻木、重着，且并不移动游走他处，因此，具备了络病的基本要素。症见太阳经脉所过之处拘急、麻木，是明显的经气不通，因最近在潮湿地区工作后才发生，可见与湿邪有关，虽然舌苔不腻，但麻木、重着乃湿邪阻遏经络的症候，所以在疏风祛湿、散寒温阳药的基础上，使用三甲散，就迅速取得了疗效。可见三甲散这类虫药搜剔之剂，在初病也仍然可用，并且能够有效地遏止病情发展。

刘××，男，35岁，教师。1979年1月上旬，打篮球被人撞了一下胸部，但并不严重，时值感冒风热，自此后胸部就一直隐隐作痛，有时又似胀闷，经养血祛瘀，舒肝理气等法治疗三个多月无效。5月经我诊视，问明致病经

过，虽找不出其他有瘀之兆，处方：地鳖虫3克，鳖甲12克，甲珠3克，柴胡10克，瓜蒌12克，桃仁10克，栀子10克，良姜10克。水煎服。服三剂，即痊愈。

此案外伤后，有持续的疼痛和固定的病变部位，这就具备了络病诊断要点中的两条，显为络病无疑，所以用三甲散加味取得了满意的疗效。

三、使用三甲散应当注意的事项

三甲散虽性偏寒凉，但对于虚寒或实寒之络脉痹阻者仍可使用，且不影响疗效。比如我临床对虚寒性的痔疮、痹证、慢性肝炎、慢性盆腔炎等，就常用三甲散配伍大剂附片、干姜等温阳之品，每获良效。

《本草新编》说：“鳖甲善能攻坚，又不损气，阴阳上下有痞滞不除者，皆宜用之。但宜研末调服，世人俱炙片入汤药中煮之，则不得其功矣。”从中医文献看来，虫类药入散、丸剂比入汤剂作用大的记载不是少数。我对于积聚、痞滞、梅核气等慢性疾病，常用三甲散打粉冲服，既能节省药物，又能增强疗效，更便于久服。

罗××，男，32岁，社员。咽中如有一物，吞之不进，吐之不出，夜寐梦多，心烦，已有三年。攻补诸药遍服，极难有效，情绪不佳时更甚。处方：生鳖甲12克，地鳖虫10克，穿山甲10克，桃仁12克，红花10克，僵蚕12克，马勃6克，山豆根10克。共为细末，用青果泡开水吞服，日2~3次，每次1~2克。水煎服。服二剂后，即痊愈，仅极度生气后稍有不适的感觉。

当归贝母苦参丸

《金匱要略》说：“妊娠小便难，饮食如故，当归贝母苦参丸主之，当归、贝母、苦参各四两，右三味末之，炼蜜为丸如小豆大，饮服3丸，加至10丸。”

古今文献对这条经文的想法，归纳起来不外三种：一是认为方证相符；二是认为方证不合，存疑，无法解；三是认为小便难应该是大便难之误。我认为，这条经文方证是相符的，用于治疗大便难对指导临床也确有补益，但这也和用于治疗其它多种病症一样，都不过是中医辨证论治中异病同治的表现罢了，也可以说是后世人前辈人经验的继承和发挥的结果。我在临床上，常将此方用于内、妇、儿以及皮肤科中的多种疾病，均能获得满意的疗效，兹略述于下：

一、治妊娠大小便难

贝母苦寒清热，功专治肺，《本经》记载主淋漓邪气，可能如尤在泾所谓与开肺气助肃降有关。肺主周身之气，司“通调水道，下输膀胱”，既是水之上源，又与大肠相表里，肺气以肃降为顺，肺气郁就可能影响到大小便的通畅。反过来看，大小便不通畅，又会引起肺气郁闭，对这种情况的治疗，就必须上下兼顾，方不致于制肘。尤在泾就是用这种肃降与大小便之关系的观点来解释此方治疗妊娠小便难的机理，他说：“当归补血，苦参除热，贝母

主淋漓邪气，以肺主治节行于膀胱，则邪热之气除，而淋漓愈矣，此兼清水液之源也。”前人称这类治法为“提壶揭盖法”，临床上我使用此法，热者寒之，用贝母、瓜蒌之类；寒者热之，选桔梗、白芥子之属，这种治法对大小便难都具有一定的辅助作用。前人在这方面也有不少经验，李东垣认为：“渴而小便不利者，是热在上焦，肺之分……宜清肺为滋其化源也。”并且制定了清肺饮（《兰室秘藏》）。此后，李士材以生脉散加紫菀，治金燥不生水的溺闭（《医宗必读》）；马元仪以紫菀、葛根、杏仁、苏子、薄荷、枳壳、桔梗治金被火制，气化不及膀胱的小便淋闭（《印机草》）；李冠仙以沙参、天麦冬、黄芩、知母、甘草梢、车前子治肺失清肃，小便不通（《仿寓意草》）。自《史载之方》以一味紫菀立法，清肃肺气，以治大便秘结后，叶天士屡用开降肺气的方法，治便秘肠痹，这不仅是“腑病治脏”，也含有“下病治上”的深义。前人的这些理法，对当归贝母苦参丸治大小便难机制的理解是很有启发意义的。

由于苦参清心府小便之火，治溺有余沥，用于湿热内蕴，小便不利症，能建清热利尿之功，当归补血润燥滑肠通便，对血虚肠燥便秘者，颇为恰当。所以，贝母与当归、苦参相配伍，无疑有助于治疗大小便难。但是，此方却不独用于妊娠之疾，一切燥热之证，只要有肺气闭郁和下焦湿热并存时，均可以选用此方加减使用。下焦湿热之小便难，是指溺有淋漓之苦，大便难是谓肛门有灼热感而解便不舒。临床上常常见到此方肺气郁的症状是：燥咳、痰少、胸闷等，肺郁和大小便难是相互可以影响的。

二、治 带 下

湿热带下，凡症见舌尖红，苔黄腻，脉数，心烦，口苦，尿

黄淋漓，阴道痒痛，带下秽臭，质浓者，即可用此方随症加味治之，此略举数则加味情况于下：

1. 兼有头昏闷、精神不振、食欲减少等脾虚症状者，可将此方为丸，用傅山完带汤加白果、贯众煎汤吞服此丸。

2. 兼有眩晕、腰痠、脚软等肾虚症状，可用益肾止带汤（郭贞卿方）：鹿角霜、菟丝子、巴戟天、芡实、枸杞、山萸肉，煎汤吞服此丸。

3. 如湿热症候严重，甚则黄白带下，中夹血丝，外阴红肿、充血、糜烂者，用此方加白头翁煎汤坐浴；并用此方加土茯苓、草薢、车前草、樗根白皮，水煎服。

三、治湿热痢疾

前人有用当归、苦参治湿热痢疾的记载，并非少见。在《本草纲目》中，有苦参治肠风泻血、热痢，以及血痢不止的记载。而当归、芍药是自古治红白痢的要药。因此，我常用此方加白芍、黄连、枳壳、槟榔、地榆，方中贝母选用浙贝母，治疗湿热痢疾症见痢下红白相兼、腹痛和里急后重较著，对发热、心烦、口渴、脉数、苔黄腻且厚、舌质红者疗效颇佳。倘湿邪偏重，症见恶心胸闷、脉濡、苔白腻者，加藿香、厚朴、苍术。

如湿热痢疾，痢下不爽，日十数行，登厕难解者，我常于加味的方中，再加大黄、肉桂，大黄常用9~15克（一半生用，一半炒炭合煎），肉桂3克，常能取得满意效果。此种加味法，亦用于治疗湿热痢疾，兼有呕吐，不能进食和进药的情况。

四、治疗黄疸

前人有云，治湿热黄疸，不利小便，非其治也。苦参有利湿清热的作用，用于黄疸湿热盛时，较为合拍，当归活血，贝母解郁，用之皆合法度。临床上，我治疗阳黄，症见一般阳黄必具之症外，倘出现心烦、口苦、溺黄且涩、舌苔厚腻而黄者，常将此方与茵陈蒿汤相合，加木香、郁金、龙胆草，方中茵陈一般用量为21克。随着湿热的减轻，苦参的剂量也应当减轻，当腻苔退净后，苦参应当减去不用，而当归、贝母仍可留用方中。周学海在《读医随笔》里论黄疸时说：“黄之为色，血与水和杂而然也。”对一般湿热发黄及阴黄的治疗，“总须用化血之品一、二味，如桃仁、红花、茜草、丹参之类，为其已坏之血不能复还原质，必须化之，而后无碍于新血之流行也。”我宗这种观点，所以选当归养血行血，至于选用贝母是因黄疸乃血与水杂合之故。舌苔黄腻时，用浙贝母，以清化痰热，散结软坚；舌苔退净后，用川贝母，以消痰解郁，润心肺。我认为，当归与贝母合用，能治疗痰热与瘀血互结的症候，二者配伍力量虽不甚强，却正切合黄疸病机，倘痰瘀互结症候已经明显，就要加强这种配伍的力量。临床实践证明，这种治法有利于肝脏回缩，能加快退黄的时间。近年来，很少有人使用苦参治疗黄疸，我认为这是一件憾事。

五、治阴痒、疥疮等

湿热蕴毒而致皮肤疮痒，用当归活血，苦参渗湿，本是对症主药。《本草纲目》载贝母治恶疮，《本经》又谓其主金疮，亦有用

于治紫白癍斑者。前人和今人用苦参治疗大风癩疾、湿疹、遍身风疹、皮肤瘙痒、疥癣恶疮、阴痒等症的记载，则比比皆是。《本草纲目》谓当归能润皮肤，治痈疽，皮肤病中是取其和血润肤之用，有一定的好处。因此，用此方治疗皮肤病，在理论和实践上都是有一定根据的。试举三则于下：

1. 治妇女前阴瘙痒。此症是一种比较痛苦的皮肤病，多是由于湿热生虫所致。凡症见阴痒带下，常流黄水，心烦，溺赤疼痛者，可用此方加蛇床子、枯矾、黄柏、百部，煎汤冲洗外阴。如阴痒而阴道又干涩，可用此方加花椒、硼砂、桃仁，煎汤冲洗之。

2. 疥疮、皮肤局部干燥脱屑之瘙痒症，均可用此方加槟榔、白芥子、僵蚕、硫磺，共为细末，前者用香油调匀擦患处，后者用细末（由于方中有当归、白芥子，故细末油润）直接擦搓患处。

3. 湿疹溃烂流黄水，又痒又痛，用此方加黄柏、甘草为细末，撒于湿疹上面。如与内服药相结合，疗效更好。

关于此方的《金匱要略》条文，尤在泾、赵德芳等认为，“小便难而饮食如故，则病不由中焦出。”我认为这种看法虽不为错，但并不十分中肯和完善。苦参苦寒碍胃，忌用于脾胃虚寒而饮食减少者，妊娠后，小便难而需要用当归贝母苦参丸时，要注意到饮食如故才可与服，炼蜜为丸更是考虑到遏制苦参苦寒伤胃而设，临床上，食减便溏之脾胃虚寒患者，服用苦寒剂，常常发生不良反应。因此，这样理解似能贯穿中医辨证论治的精神，对所治疗各种病症来说，如果将此方内服，都要注意到胃是否能够接受。就临床观察来看，若饮食正常的病员，使用丸剂内服，一般不会影响到脾胃功能。如果病员口苦苔腻，且平素无脾胃虚寒的情况，

用汤剂也无妨碍，不仅如此，反而往往随着口苦苔腻的好转而增进或恢复食欲。

经验方二十首

一、楂 薏 饮

风疹块即荨麻疹，是一种变态反应性疾病。我治此病，特别是慢性反复发作的荨麻疹更强调三点，即祛风、和血和改善体质，因为正气内充，气血流畅，何病之有。治疗此病，我以楂薏饮为基本方剂，使用五十多年，疗效较好，对一些慢性反复发作者尤佳。

方剂组成：山楂45克，红薏15克，蝉蜕6克，僵蚕10克，防风10克，绿豆皮30克，紫荆皮21克，竹叶心1束，白砂糖30克。

煎煮取汁，兑入白砂糖调匀服，急性可每日服5~6次，慢性每日2~3次。

加减法：血燥血虚者，加当归、赤芍、地黄、首乌；血热者，加生地、丹皮、紫草；风胜者，加苍耳子、乌梢蛇、地龙、甲珠、浮萍；挟湿者，加薏苡仁、土茯苓、白藓皮。

五十多年前，曾治一孕妇，平素有时吃鸡、鱼、魔芋后，即有腹痛、浑身发风疹块等情况，但一日半日即过。这次发作却较为厉害，瘙痒难忍，并伴呕吐，更医数次，而无甚疗效，已一月余。适逢我二哥到此，为之诊视，处方：山楂45克，红薏15克，

绿豆皮30克，老白糖30克，竹叶心1束，因其瘙痒处红肿，更加银花12克，连翘12克，续服四剂，痊愈。随访病员数年，未曾复发。自此后，我即用此方加味治疗漆疮、药疹等多种过敏性疾病。兹举一例：

徐××，女，49岁，干部。1977年3月，病员鼻孔内生一疔疮，红肿，痒痛，恶寒，经服清解中药肿痛已减。因局部外用碘胺软膏后，诸症较前更为严重，整个颜面出现红斑丘疹，流黄水，舌质红、苔黄，口渴，心烦。用楂薤饮加辛夷花10克，苍耳子10克，丹皮10克，赤芍10克，菊花10克，甘草3克。服一剂后，瘙痒减轻，黄水减少。续服三剂，大量脱皮而痊愈。

用此方时，山楂宜用大剂量，一般不得少于45克，根据具体情况，还可酌情增加。在前人方剂和民间验方、单方中，亦有用山楂治疗荨麻疹的。据现代药理研究，山楂含有黄酮类物质，有抗过敏作用。此外，似也应当与山楂解肉积、活血祛瘀、行滞散结等作用有关。

二、固表祛邪方

我早岁行医，接受父亲的经验，对于老幼以及常易感冒之人，只要具备鼻塞多嚏、流涕、头痛、恶风等主要症候，常用玉屏风散加味治疗。后来，我在这个基础上，制成固表祛邪方，专用于老幼和常易感冒的青壮年病员。近年来，我对于一切人感冒，只要无继发感染者，都以此方加味治疗，对症状的改善和感冒的预防确好处。

方剂组成：黄芪24克，白术12克，防风10克，葛根12克，羌活10克，薄荷6克，甘草3克。先用温水浸泡1~2小时，后用武火煎，沸3~5分钟，日服三次。

加减法：风热者，可减轻黄芪用量，加银花、连翘、芦根(均重剂)，咳嗽者，加杏仁、贝母、前胡；头痛较甚者，加桑叶、菊花；热盛痰唾黄稠者，加知母、瓜蒌皮；风寒者，加白芷、辛夷、生姜、葱白；咳嗽者，加金沸草、款冬花、百部；头痛甚者，加川芎、细辛；身痛者，加桑寄生、秦艽；挟湿一身重痛者，加羌活、独活、苍术；胸闷，呕恶，纳呆者，加厚朴、半夏、茯苓之类；挟暑，暑重于湿者，加麦冬、五味、滑石、荷叶之类；湿重于暑者，用芳香化浊之藿香、佩兰、蔻仁，或用辛开苦降之厚朴、半夏等，当视症而定，但均可加香薷。

我认为，婴幼儿为纯阳之体，稚阴稚阳，元真未充，老年元真不固，根本动摇，治疗他们的伤风症，就应以补为攻，守住根本，不可一味表散。就临床观察来看，对老幼感冒尤为稳妥，而对平素常易感冒或气虚感冒的青年、中年、壮年病员，服用此方，不仅症状改善较快，而且感冒次数也明显减少。根据《本草备要》记载，黄芪“生用固表，无汗能发，有汗能止，温分肉，实腠理，泻阴火，解肌热。”《本草汇言》载有黄芪“补肺健脾，实卫敛汗，驱风运毒之药也”等论述，再结合我的临床体会，感到黄芪的补肺实卫，以及“解肌热”“驱风运毒”的功用，不仅有利于解表祛邪，而且有助于腠理致密抵御外邪侵袭，于治于防，两能兼之。故对一切感冒病员，以此方为基础方，临床证明，确有较好的疗效。

三、二甲二虫散

咽中如有炙脔，咯之不出，咽之不下，是为梅核气，常伴有精神忧郁，胸闷善太息等症。其病因病理，主要是由于精神不遂，

气郁生痰，痰气交阻所致。我的体会是，此症初伤气分，久延血分，痰淤交阻，郁而发热，草木攻病，难以见功，不若用虫类搜剔，使散剂缓攻，能达消而去之的目的。于是选善化痰之麤虫，养阴消癖之鳖甲，消痰散结之僵蚕，透达经络之穿山甲，组成一张性偏寒凉、味属咸苦的昆虫动物类的逐痰消痰通络方剂。

方剂组成：鳖甲、穿山甲、麤虫、僵蚕。其分量的比例为4:1:1:4，共为细末，每服1克，日二次。

《本草新编》载：“鳖甲善能攻坚，又不损气，阴阳上下有痞滞不除者，皆宜用之，但宜研末调服，世人俱炙片入汤药中煮之，则不得其功矣。”其他如僵蚕、甲片、麤虫当须为末吞服的记载，亦复不少。此方治梅核气久者较佳，久病入络，叶天士主张丸药缓攻，用散剂亦有缓攻之意，缓缓图治，络通痰消则气血流畅，病自消除。我主张使用散剂，一是服用方便，二是便于久服，三是疗效确比汤剂好，这与文献中对此几味药的最佳服法是为末吞服的记载相一致。此方对于慢性扁桃体炎、慢性咽炎、慢性鼻窦炎等而致的梅核气，在无急性感染的情况下，疗效颇佳；对于由精神刺激或精神紧张、心情抑郁等疾病引起的梅核气，亦较令人满意。

服用此散剂，我一般常根据具体病情，处以汤剂吞服，一般作法是：血虚肝郁者，用逍遥散；心脾两亏者，用归脾汤；痰气交阻，胃失和降，偏寒者用半夏厚朴汤，偏热者用温胆汤。

四、加味小柴胡汤

火眼，通常称为红眼病。由外感风热引起，突然发病，眼睑红肿，结膜呈鲜红色网状充血，又痛又痒，怕热怕光，睁眼不开，

流热泪，眼眵多，通常兼有头痛、鼻塞、恶寒、发烧等症状。治疗此症，我用加味小柴胡汤，疗效确切。

方剂组成：柴胡15克，法夏9克，沙苑子10克，栀子10克，甘草3克，羌活3克，黄芩10克，芒硝9克（用酒溶化，待诸药煎好后，再兑入），日服三次。

使用此方应当注意：一是使用辛温的羌活量要少，取其既能驱风镇痛，又能反佐苦寒；二是使用咸寒软坚的芒硝，不一定要有便秘之症，泻下能釜底抽薪，使上焦之壅热能随泻下而得到排出。临床上，此症往往泻后痛减痒轻，次日肿退眵少，疗效颇为满意。

加减法：泪多者，加夏枯草、秦皮、青葙子、桑叶、龙胆草等；肿甚者，加车前草、木通、密蒙花、泽泻；痒甚者，加荆芥、防风、菊花、薄荷；充血凶者，加仙鹤草、紫珠草、红花、白茅根、丹皮。

服药期间，忌辛辣油腻，保持二便通畅。

五、夜啼方

小儿为稚阴稚阳之体，生机蓬勃，尽管易虚易实，易寒易热，但痊愈和恢复也较迅速。因此，把小儿纯粹当作成人的缩影是错误的。小儿用药宜轻，所谓轻者，一是清淡，二是轻灵，三是中病即已，同时用药还要有引导性。基于这种思想，我选用民间验方蝉花散加味名为夜啼方，以治疗此症。

方剂组成：蝉蜕（去头足）7个，薄荷叶1.5克，广木香1.5克，通草1.5克，甘草1.5克。水煎，日服三次。

加减法：心热者，加淡竹叶，兼导赤之意，况蝉蜕甘寒能散

风热，薄荷叶辛凉能疏解风热，二药又善清心除烦。脾寒，脾脏虚寒，阴盛气滞，以致郁积不舒，或绵绵腹痛而致夜啼。轻者，方中有甘草、广木香，已足以对付；重者，根据其程度，加炮姜、砂仁等。惊吓，在一般情况下，我不主张用重镇安神药，如龙齿、琥珀、辰砂之类。小儿思维和成人迥异，惊则气散，气散常并痰升，上逆于心，他不会因为思虑忧愁而加重气散；小儿常会由痰升阻碍气机，使气散不得归，因此，受惊后的主要问题，在于气散痰升，所以，只需要在夜啼方中加胆星之类。

六、加减玉女煎

牙痛有虚实之分，虚责之于肾，实责之于胃。足阳明入上齿龈，手阳明络下齿龈，但肾主骨，齿为骨之余，所以，牙痛无不关乎于胃肾，治疗上需要善于调整二者。

东垣清胃散（当归、黄连、生地、丹皮、升麻），治实火牙痛。《医方集解》引录此方时，更加石膏，则清胃之功更显著。景岳的玉女煎，本为少阴不足，阳明有余之牙痛而设，实有深义。经我长期观察，发现阳明气火有余，少阴阴精不足的牙痛，不是少数。绝大多数的牙痛患者，都有不同程度的阴精不足现象，因而加减配成此方，做为临床治火热上攻牙痛的基础方。

方剂组成：生地20克，牛膝12克，石膏30克，麦冬18克，知母10克，防风10克，刺蒺藜12克，骨碎补10克，蜂房10克，蝉蜕10克，地骨皮20克，细辛4.5克，白芷10克，升麻10克。水煎服。

阳明为多气多血之经，胃热多为血气俱热，故除清阳明经热的石膏、知母之外，更配伍凉血的地骨皮、生地。《内经》说：“火郁发之。”用防风、刺蒺藜，正合此义。从东垣清胃散看来，升麻

一味既能作为引经药，又具有清热解毒之功，况石膏与升麻并用，除能升泄阳明气分之热外，又有清解炎上热毒之效。牛膝导热下行，骨碎补苦温补肾、活血、坚骨，治牙疼古有记载。露蜂房治风火牙痛，方书中多以噙、搽或漱的方式用药，至于入煎剂，我体会也较好。细辛的作用当一分为二，辛温之性能起反佐作用，镇痛之用可治其标。麦冬与生地相合，是取其金水相生之义。临床用之，常有效应。

加减法：大便干燥者，加大黄；疼痛厉害者，用花椒、细辛、石膏煎水漱口；牙痛久治不愈者，加肉桂1克，附子1.5克，以引火归源；有风热表证者，加薄荷、葛根；项下结核、目赤耳鸣者，加夏枯草、梔子。

忌一切辛燥、油腻、腥腐之物。

七、丹参鳖甲饮

郁热瘀血而致胃痛，临床症状常表现出如下几个要点：1.心烦，舌苔微黄略腻、苔可薄可微厚，但舌尖红、舌畔有瘀点或瘀斑，或舌下青筋紫黯、粗隆；2.除胃痛症状外，还具有肝气不舒的症状，如肋胁胀闷、呃气等；3.胃痛时间较长。具备以上几点主要症状后，即可使用丹参鳖甲饮以加减治疗。

方剂组成：梔子12克，良姜12克，香附10克，丹参20克，白芍12克，枳实10克，没药3克，鳖甲15克，桃仁10克，甲珠3克，柴胡3克～10克。水煎服。

加减法：疼痛厉害者，加延胡索、金铃子；胸腹胀闷甚者，加檀香、佛手、降香；口苦，苔黄者，加黄连。

使用此方时，舌苔厚腻和无苔都不很适宜；倘舌体胖大、色

淡，也不适宜。

八、公 丁 散

寒湿胃痛，临床上的诊断要点为：1.舌苔厚腻、色白或淡灰；2.舌质色正，口中和或泛清涎；3.胃痛绵绵不休，有畏寒感。见此主要症候者，可用公丁散。

方剂组成：公丁香、吴萸、小茴香、广木香、官桂、砂仁、良姜，各等分，共为细末，用白饮吞服，每日服2~3次，每次3~6克。

配合服法：外感风寒，恶寒无汗者，可用辛温解表剂，如荆防败毒散之类，煎汤吞服此散；脾胃气虚者，神疲肢冷，大便溏薄，舌淡而胖嫩，用黄芪建中汤一类，煎汤吞服此散；至于寒热错杂，用清热除湿之方煎汤，吞服此散，效果亦颇佳。

口渴，舌质红，苔黄、无苔等，俱不适宜使用此散。

九、解郁舒心汤

情志之郁，总由乎心，隐情曲意不伸，是为心疾，最易波及肝脾。伤心则出现神志恍惚，悲忧善哭，时时欠伸等症状，伤肝脾则腹中窄隘不舒。解郁舒心汤治郁伤心神为主，肝气郁结为主者，不在治之范围。使用本方临床表现主要点为：1.有明显的精神刺激病因；2.表现为曲意不伸之精神症状；3.脉或弦、或紧而数，舌边尖红，有舌苔。

方剂组成：香附10克，茯神10克，炙甘草6克，白芍10克，川芎10克，天花粉10克，藕节10克，黄芩10克，延胡索6克，灯芯6

克。

冷水浸泡半小时后，文火煎。每日服三次，空腹服。

加减法：心烦，口苦者，加黄连、青黛；痞满腹闷者，加厚朴、枳壳；舌质紫黯，胸肋刺痛者，加桃仁、红花；舌苔白腻，咽中如有物阻者，加半夏、瓜蒌、南星，另用肉桂炭吞服；悲伤欲哭，舌苔少者，加小麦、大枣；胃脘痞闷，饮食不消者，加麦芽、山楂、神曲；失眠者，加夜交藤、合欢皮、琥珀。

本方对忧思气郁伤心，临床运用疗效颇佳。病案举例：

童××，女，45岁。素常心胸狭隘，吵架后，过度悲痛。《灵枢·口问篇》说：“悲哀忧愁则心动，心动则五脏六腑皆摇。”怒郁伤及肝脾，而致胸胁胀闷，喉中如梗，纳谷不香，食而难化，郁伤心神，则精神恍惚，夜梦纷纭，悲伤欲哭，时时欠伸。舌苔白腻，舌质黯，脉弦细。病历一月，为时不久，诺其可治，嘱其能怡情自遣，宽怀调养。用解郁舒心汤加小麦、大枣，四剂后，诸证向愈。因其白带多且清稀，用傅青主完带汤二剂，善后三月后追访，病未复发。

刘××，男，48岁。因被诬陷受罚，怒郁难伸，因之精神恍惚，无故痴呆苦笑，长呼短叹，胸胁疼痛，多方调治，诸证如旧。经我诊时，舌边尖红，苔薄微黄，脉弦数；用解郁舒心汤二剂而心胸开展，精神明显好转，续服几剂，恢复常态。

方义解释：方中香附、川芎、延胡，皆为行气和血止痛之品，其中延胡以治诸痛为主，川芎、香附为行气开郁之要药。三药皆通而能窜，是能行能走之动药。白芍养阴补血柔肝，且能镇痛，与川芎、香附配伍，刚柔相济；与黄芩一炉，则能清泻血分热结，与甘草同行，则酸甘化阴。郁伤心神，除引起气机升降出入逆乱外，心阴心神常因神伤而亏，何也？夜难成寐，神不守舍，神无宁时，精气必过耗而致亏损。故切忌纯用刚药以解郁耗气。我常想，比如灯暗挑灯，纯用刚药是只挑灯芯不加油，促其早灭，只用柔药是加油而不挑灯芯，有油而不亮，只有又加油又挑灯芯，才能

维持其持久的光明。天花粉清热生津，能助白芍、黄芩、灯芯清心降火，利尿安神。用清热药何故？这是因为郁能化热，郁怒越速，越烈，则化热愈快，不清热利尿则心热无出路，不生津则川芎、香附嫌其燥。至于用“凉血养血，利水通经”的藕节，有防其动血的另一层含义；用平肝安神的茯神，自是理所当然的。

十、楂通莱苏饮

饮食过度，恣啖酒肉油腻，或脾胃伤损，稍多纳入，则停饮留食，可谓之积。《医学心悟》说：“脏腑经络肌肉之间本无此物，而忽有之，必为消散，乃得其平。”此方主要治疗饮食停滞，气机不畅所致之以气胀为主的腹胀，症见噎气，腹胀，叩之如鼓响，舌苔腻或腐。

方剂组成：山楂30克，通草6克，莱菔子18克，紫苏梗10克，广木香3克。水煎服。

加减法：大便干燥者，炒莱菔子可用至30克；小便不利者，加泽泻、茯苓、前仁等；苔厚呃腐者，加炒焦麦芽、神曲；饮食停滞者，加槟榔、枳实；胀而且痛者，加延胡索、厚朴、青木香；大便不通者，加大黄、槟榔、厚朴。

十一、朱苓止泪汤

眼睑红烂，流泪不止，舌质红，苔黄，口渴，脉数等。此病现代医学称为睑缘炎，中医称为睑弦赤烂，俗称红眼边。此症以热与湿毒相搏，停于眼睑为多，可用此方加减治疗。

方剂组成：朱苓12克，茯苓12克，泽泻12克，滑石18克，木

贼10克，玄参12克，白芷10克，菊花10克，阿胶（烔化）10克，大黄6克（酒泡后下）。水煎服。

加减法：炎症明显，红赤较甚者，加蒲公英；糜烂、红久不愈者，加白藜；畏光较著者，加山梔、青箱子、野菊花。

十二、地竹润目汤

眼目中自觉干涩，且痒，揉拭则略好，停后又痒涩，且愈揉愈干涩。平时并无红赤现象，亦无其它明显痛苦，此乃血虚风邪乘之，可用地竹润目汤，补肝肾之阴，祛风邪，润目止痒。

方剂组成：熟地20克，生地15克，玉竹18克，石斛12克，夜明砂10克，桑叶10克，黑芝麻30克。水煎服。

加减法：痒甚者，加刺蒺藜、花椒、防风；有轻微红赤者，加当归、红花；苔腻者，加朱苓、茯苓、车前草；有气虚者，加党参、黄芪；血虚者，加当归、首乌、阿胶。

十三、健脾消胀汤

脾虚之胀，症见腹胀，按之中空无物，矢气或暖气后较为轻松，食欲不振，倦怠无力，舌淡苔薄，口中无味，精神抑郁，时呃腐，多见于体质较差或老年人生气或伤食之后。

方剂组成：白术15克，茯苓12克，薏苡仁15克，甘草5克，官桂9克，枳壳10克，党参15克，山药15克，神曲10克，车前仁10克，莱菔子10克。水煎服。

脾胃虚弱之人，怒郁伤肝，肝气不舒犯脾，或略为多食，及不易消化之物后，所致腹胀不思食。治疗此症，要以健脾理气为

主，略佐消导，而单从疏肝理气及消导着手，很难见效，且益致伤损脾胃。

加减法：血虚者，加当归、白芍；气虚下陷者，加黄芪、升麻；脘闷者，加薄荷梗、香附；伤食者，加焦三仙。

十四、檀香汤

肝气犯胃而致呃气，胃脘胀痛，干呕，胁肋不舒，舌苔腻或白或薄黄，口苦，脉弦，心烦。可用檀香汤加减治疗。

方剂组成：丹参20克，檀香6克，延胡10克，金铃炭10克，白芍12克，甘草3克，砂仁6克，良姜10克，广木香4.5克，官桂10克。水煎服。

加减法：口苦，呕吐者，加竹茹、黄连；肠鸣，腹痛且泻者，加陈皮、白术、防风；泛吐酸水，时时嘈杂者，加煅瓦楞子或左金丸，以平肝和胃。

十五、益气补肾汤

本方主治眩晕，视物旋转欲倒，严重者不能张目，胸中泛漾欲吐，动作则加剧，舌质淡或胖嫩，脉细。特别是持久劳累后所致四肢无力，肢节疼痛，头昏晕，不思食等症，更为适当。

方剂组成：熟地24克，山药18克，枸杞15克，芡实30克，巴戟12克，党参20克，玉竹20克，当归15克，天麻10克。水煎，日服三次，体弱者，加鸡炖服。

加减法：五心烦热，舌质红，脉弦细，加桑椹子、菟丝子、首乌、银柴胡、胡黄连；四肢欠温，腰膝酸软或疼痛，舌质淡者，

加鹿角胶、肉桂、菟丝子、狗脊、杜仲，面色㿠白，神疲力乏者，加黄芪、白术。

十六、清肺解毒饮

鼻上生疔起疳，或鼻窍内发热，红赤，出气觉烧等，又肺痈、咳吐脓血臭痰。胸中隐隐作痛，脉滑数者，均可用此方加减治疗。

方剂组成：浙贝母10克，辛夷花10克，甘草6克，黄芩15克，杏仁10克，薄荷叶6克，薏苡仁12克，蒲公英20克。水煎服。

加减法：痰多质稠者，加桃仁、桔梗、冬瓜仁；发烧甚者，加银花、连翘、丹皮、鱼腥草；肝火旺者，加丹皮、山栀、夏枯草；伤阴者，加玄参、石斛、麦冬；气虚者，加黄芪、白术。

十七、固经汤

《济生方》说：“崩漏之病，本乎一证，轻者谓之漏下，甚者谓之崩中。”崩漏的病因，多是血热、气虚、气郁、血瘀等，但发病的主要机理，还是由于冲任损伤，不能固摄所致。所以，治本之法，当是固摄冲任，故以固经汤为治本之剂，以此随症加减。此方主要用于血热不甚者。

方剂组成：党参（重者可用红参）20克，白术15克，熟地（血热者用生地）18克，山萸肉15克，五味子9克，杜仲9克，远志3克，炙甘草6克，乌贼骨（煅）12克，莲房炭15克。水煎服。

加减法：血热者，加青果、地榆、白茅根、生地；气虚者，加黄芪，党参易人参；血瘀者，加五灵脂、蒲黄、参三七、花蕊

石；血寒者，加艾叶、吴茱萸、黑姜；气郁者，加益母草、血余炭、藕节。

方中党参、白术、炙甘草补气培元固中；熟地滋阴补血；山萸肉、五味子温补肝肾，澹精固气；杜仲甘微辛温，甘温能补肝肾之阳，辛温能畅气血之滞，使无留淤作弊；远志交通心肾，与归脾汤中用此同义；乌贼骨收敛止血，用于下元不固。莲房炭为治崩漏出血之专药。整个处方，偏于温补，因此治疗崩漏，又不可用于热象较显的病员，主要用于崩漏日久，气血两亏，或素体气虚之人患崩漏，以及崩之太盛而致血去过多，时虽不长，却气随血衰。临床表现为体倦，食少，面色无华，精神萎靡，腰膝酸软，耳鸣，心跳等症，至于所下之血色，可随证而变，血热色紫，血淤凝块，血寒色淡。在血热崩漏证，过用寒凉后，或日久不止者，出现上述症状，亦当用此方加减使用。

十八、参蛇洗剂

此方主治外阴瘙痒症。此症为一种妇科常见而又痛苦的病症，我根据前人蛇床子散衍化为此方，治疗感染及外阴湿疹所致的阴痒，有明显疗效。对于其他如糖尿病之尿液的刺激、外阴静脉曲张、外阴白斑等病出现的瘙痒症，仅适用于其中湿热下注的类型。

方剂组成：蛇床子12克，当归10克，花椒10克，刺蒺藜12克，黄柏12克，贝母3克，苍耳子（或叶）10克，苦参12克。

水煎后澄净，冲洗外阴部。

本方对阴道、外阴有霉菌、滴虫、阴虱和蛲虫等感染，对外阴湿疹等均有明显疗效。对于湿热带下，不论有无外阴瘙痒，均

可用本方煎水冲洗外阴，有一定的治疗效果。

十九、催乳补需汤

产后乳汁甚少，或完全无乳，均称乳汁不下。若属气血虚弱者，乳房无胀痛感，面色萎黄或白；若属肝气郁结者，乳房胀满且痛，甚或发热，精神郁闷。总之，产后以虚为主，肝气之疏泄亦关乎乳汁之舒畅与否，所以，大补气血和疏肝通络当为治此症的大法。据此，拟定此方。

方剂组成：当归15克，黄芪20克，党参20克，黄精15克，山药20克，白芷9克，通草6克，甲珠6克，王不留行10克，墨鱼2条，金钩6克，淡菜15克，猪蹄1对。

炖汤吃，可以放盐、葱花等调味品。

二十、云母散

产后腹痛，即产妇分娩后，子宫收缩的过程中，所出现的阵发性腹痛，按之有硬块，一般称为“儿枕痛”。因产后有血虚多淤和气滞的特点。因此，产生本病的原因，主要是气血运行不畅，而导致不畅的机理，一般认为又有血虚、寒凝两种症型。综合起来，总的治疗原则是以养血调气为主，佐以温散、行滞、活血之品。我认为，产后特点不仅是血虚多淤和气滞，而且还有积水的问题存在，治疗产后腹痛，还要注意区分蓄血和蓄水的孰多孰少，基于这种认识。我自制此方为治此症的基本方，临床验证，用之对证，屡试成功。

方剂组成：党参15克，当归12克，茯苓12克，防风10克，云

母石15克，草薺10克，木瓜10克，薏苡仁10克，炒金鈴10克，蚕砂12克，海桐皮9克，附片（先煎）9克，川芎6克，益母草12克。水煎服。

加减法：少腹疼痛，拒按，触之坚硬，小便利为淤血重，方中活血药剂量大于利湿药；少腹硬而小便不利，或淋漓胀痛，乃积水重，方中利湿药用量大于活血药；少腹冷痛拒按，触之有块，得热稍减，面色青白，四肢不温者，加桂枝心、木香；头晕耳鸣，腰部坠胀，大便结燥，脉虚细者，加熟地、阿胶珠、续断、麦冬。

李××，女，30岁。孕四产三，产后阵发性腹痛，按之有硬块，痛时甚剧，拒按，得热稍减，舌质淡，苔白，脉沉滑。疼痛每因哺乳加重。经医院妇产科检查，诊断为产后宫缩痛，排除有血块、部分胎盘、胎膜残留所致，口服复方阿司匹林无效，我诊后，询知小便利，用上方，服一剂知，续服二剂即痊愈。此类验案甚多。值得提及的是，产后恶露未尽、血晕等症中伴随的腹痛，一般不属于单纯使用本方的范围。

《妇人良方》载产后腹痛如绞，用当归末五钱，白蜜一合，水一盞，煎服。当归与川芎合用，名为佛手散，能行血活血，加配金鈴子则止痛作用更强。防风祛风解表，胜湿解痉，前人称为风药中润剂，为产后防止及治疗风邪入侵的要药。风为百病之长，在此症中自当为选用之药。茯苓、薏苡仁利水渗湿，蚕砂，海桐皮均能祛风除湿，故尔入方。《睥子本草》认为木瓜能治心腹痛，《圣惠方》中的木瓜丸，用以治积年气块，脐腹疼痛，其与行散药物相配，能使之敛散得宜。附片在此方中，有寒时则为温散之品，可视病情而定剂量，无寒时则为推动之药，益母草既能活血，又能利水，功兼两用，故均入选。至于方名冠以云母，是因为此物长于纳气坠痰，止血敛疮。《本经》谓其“主身皮死肌。”《别录》谓其“下气坚肌，续绝补中，疗五劳七伤，虚损少气。”从病机上

看，颇与产后腹痛宜。另外，《千金翼方》用云母粉服三方寸匕，三五服，治带下。《积德堂经验方》用云母粉15克，温酒调服，治妇人难产，经日不生。据此，我体会到此物之长，用于产后能坚固肌理，利水泄湿，这于产后腹痛，当有益处，用于临床，效果良好。

第五部分 探 讨

瘀血证必须广开治路

随着活血祛瘀法日益显示出其治疗的广泛性，很自然也加重了这样一种倾向：即认为一见有瘀血之征，就以活血祛瘀法为主，而且临证处方，动笔就来，把此法看作能通治百病。我认为产生这种倾向的原因是多方面的，把对瘀血证的治疗和活血化瘀治则的使用，这两种不同的概念弄混淆了，就是其中之一。从作为一种治疗法则来说，活血祛瘀和其他治则一样，各有其适应范围，不能因为使用广泛，就能取代其他治疗法则。而作为对瘀血证的治疗来说，因为是证，所以就应当辨证求本，不能见血治血，必须广开治路，不能囿于活血祛瘀一法。

从气和血的关系来说，气对血的作用主要表现在行血、生血和摄血三个方面。而这三种作用，对保障营血能正常运行而不发生瘀滞有着重要作用。气不生血，血量不足，则往来艰涩；气不行血，更是产生瘀血的直接原因；一旦气不摄血，离经之血便是瘀血。从气对血的作用着手，简单地铺开去，我们就能看到：

1. 行气，能调整人体功能障碍，有助于血行，这已被中医各家所公认。

2. 清气，对气热而引起血瘀的防治，不清气是舍本逐末。

3. 温气，寒则温之，对气寒引起营血凝泣诸证，能起到消而去之的作用。

4. 舒展气机，可以消除湿邪等有形之邪对经脉的压迫和堵塞，这样就可以治疗由此而引起的血瘀。

5. 用各种方法调理脾胃之气，使脾气健，则运化健旺，使胃气旺，则生化之源充足，这样，营血的质和量自无后顾之忧，由此而造成的瘀血自可消除。

6. 用各种方式保证肝气疏泄条达，则气机舒畅，血脉和利，由此而引起的瘀血自然能够治愈。

7. 肾气足，则生化无穷，临床上已经证明，而且将继续证明，肾气充足，对生血、行血和摄血起着重要的作用，而使肾气充足又将有多种途径。

由此可以类推，治法也就相应地增多了。中医学认为，“气为血帅，血为气母”，“阴阳互根，气血相关”，血与气有密切关系，气血学说是一个整体。正因为如此，所以一些传统上不属于活血化瘀而属于固脱益气、回阳救逆的方药，如独参汤、四逆汤等，也可使血瘀证病员获效，而且不论是用中医或现代医学所视为能反应血瘀的客观指标起到变化。由此可见，从气对血的作用关系来看，就要求瘀血证治法多端。

辨证论治的这个证，具体说来，就是概括了体质因素、天人相应因素、病变的部位、原因、病态、病机等方面。其中任何因素的改变，都可以导致证的改变，从而导致治则的改变。徐洄溪在《医学源流》中，曾以发热为例，论述了原因不同、体质不同，也就是说证不同，治则不同这个问题。他说：“如同一身热也，有风有寒，有痰有食，有阴虚火升，有郁怒忧思，劳怯虫疟，此谓

之因，知其因，则不得专以寒凉治热病矣。盖热同，而所以致热者不同，则用药迥异，凡病之因不同，而治各别者尽然，则一病而治法多端矣。”由此可以推而知之，同一瘀血，引起的原因不同，则治法也当各异，专以活血祛瘀一法去统治瘀血证，显然是一种形而上学的观点。所以，从病因辨证的角度去看，也是要求瘀血证广开治路。

除了不同质的矛盾要用不同质的方法去解决外，还需要注意分清矛盾的主次关系，否则还是不能很好地对瘀血证进行治疗。若弄不清瘀血在疾病中的主次位置，不是滥用活血祛瘀法，就是有的不放矢。比如心阳不足所致的心血瘀阻，单以活血祛瘀而不与其他治则结合使用，实质上是舍本逐末，见效难得。而干血癆是由于瘀血阻塞经脉，以致体力日耗，治宜先去其瘀方能生新。如果不明标本，不分先后缓急，不辨矛盾的主次，这种治法不是守株待兔，就是盲人瞎马，结果往往事与愿违。

据上面所谈，活血祛瘀法虽然是治疗瘀血证的重要治则，但不是唯一的治则。由于各个病员体质上的差异，兼挟症候的不同，引起瘀血的原因不同，瘀血在病症中的地位不同，程度不同，对瘀血的消除方法也就不同。或者以祛瘀为主，或者根本不能祛瘀，或者祛瘀作为其它治则的辅佐。可以这样说，活血祛瘀法只有根据瘀血证的具体情况，或取或舍，或先或后，或与他法相伍，并恰当地处理好主次配合关系，才能有力地消除瘀血。那种仅仅拘泥于活血祛瘀药物和方剂的选择，乃是一种见血治血的方法，不是辨证论治的方法，因而不能有效地治疗瘀血证。总之，从辨证求本这一观点出发，就必然要求对瘀血证广开治路。在活血祛瘀法广泛适用于临床，并取得了可喜成就的今天，对瘀血证的治疗，就更应该坚持这个观点，并且要把它上升到理论的高度来认识和

对待。这对进一步提高瘀血证的治疗效果，为中西医结合创造我国统一的新医药学提供更多的素材，实为有益的。

古往今来的临床实践，也正是这样向我们展示出一种意味深长的结果：一方面，不少病症并无瘀血征兆，用活血祛瘀法却取得了满意的疗效；另一方面，不少有明显瘀血症状的病症，用活血祛瘀法疗效反而不佳，有的甚至发生其它不良变化，改用其他治则，又能有力地消除瘀血症状，岳美中老中医说：“冠心病之治疗，常用‘活血化瘀’之法，认为是‘血瘀’所致，但需深入分析。依中医理论，胸阳衰弱，浊阴干犯清阳之府，乃是该病之基本病机。……本院所用冠心病的宽胸丸（藿藜、良姜、细辛、玄胡索、檀香、冰片）并无直接‘化瘀’之药。因其行气通阳而治病。若确有瘀血之征，即使要使用活血化瘀药，也宜加入黄芪、薤白等行阳之品，其效方佳。”《新医药学杂志》1978年第4期《169例急性心肌梗塞舌象的初步观察》一文也指出，气虚血瘀是导致本病发生发展的内在因素，贯穿本病的始终，是本病辨证的主要依据。《新医药与杂志》1976年第4期《辨证论治40例冠心病临床总结》通过临床证明，通（活血化瘀，通阳宣痹、行气豁痰、温通血脉等）补（补气养血、滋阴和阳、益气养阴等）兼施，标本同治，相得益彰，能获得较为满意的疗效。《新医药学杂志》1978年第7期《活血化瘀及益气活血方药对犬实验性心肌梗塞的影响》一文，其实验结果表明，活血化瘀的冠心Ⅱ号方，益母草及益气活血的抗心梗合剂，对犬的实验性心肌梗塞具有一定的防治作用，特别提出引起注意的是，抗心梗合剂由于在活血药的基础上加用益气药，效果优于前二者。可能由于急性心肌梗塞具有本虚标实的特点，益气治本，活血治标，标本兼治，所以效果更佳。可见对瘀血的治疗，若不究因果，不考虑标本兼挟，单着眼于瘀血，收效总是

事倍功半的，甚或走向愿望的反面。《中医杂志》1961年第3期《17例风湿性心脏病与1例肺原性心脏病的辨证论治》一文中，讨论了由气虚不能维持行血而引起瘀血的治疗，该文认为，在这种情况下气虚为本，血瘀为标，在气虚纠正到一定程度后，瘀血症候亦往往会随之消失，若在危重阶段祛瘀血，则有可能造成血去气脱的后果。《景岳全书·妇人规》中提到血枯经闭时，说：“枯之为义，无血而然，……欲其不枯，无如养营，欲以通之，无如充之。……奈何今之为治者，不论有滞无滞，多兼开导之药，其有甚者，则专以桃仁、红花之类，通利为事，岂知血滞者可通，血枯者不可通也。血既枯矣，而复通之，则枯者愈枯，其与榨干汁者何异。为不知枯字之义耳，为害不小，无或不蹈此弊也。”《近代中医流派经验选集》书中《妇科陈筱宝的学术理论和临床经验简介》一文里，就介绍了这样一个血枯经闭医案，颇值得借鉴。原文：

陈桂春太太，病伤寒之后，越半年而经水不至，手足烦热，肌肤枯索。一日经突来临不多而有瘀块，医者以为必有停瘀，方用桃仁、红花、当归等药五六剂后，经水仍不至，见胸腹胀满，认定瘀不下，更加京三棱、蓬莪术，病者遂见潮热、心悸、不寐等。先君诊之，谓此犯虚虚之戒，化源告竭，恣意通利之法，无怪病日增重，乃予回天大补膏，嘱每日进服。二月后诸恙渐瘳，三月后经行正常，病痊愈。

此案经闭，手足烦热，肌肤枯索，经突来临而有瘀块，诊断为有瘀血并无原则错误，用活血破瘀药而病反加重，是因为没有弄清楚此证的瘀血是气血虚弱而致的血行不畅，忽视了化源告竭而致的瘀血证，必须待气血充沛后，才能得到消除的这个特点，犯了虚虚之戒。瘀血亦有虚实之分，虚补实泻并非不实用于瘀血证。回天大补膏的组成：人参、茯苓、当归、白芍、川芎、生熟地、

陈阿胶、知母、红花、山药、玄参、丹皮、龟板胶、牛羊乳、柿霜、梨汁、天门冬、银柴胡、鳖甲胶、八制香附。陈筱宝先生认为，妇人月事不行，症见肌肉瘦削，皮肤枯索，爪甲泛青，口干口燥，掌心灼热，脉沉细等，纯由血枯营少所致，不同于其他由七情六淫等导致经闭的实证，以此缓缓图治，多获良效。陈氏认为，此方作用在于滋荣。这类经闭，若欲经行必须养营，营血充盈则经血自至，专以行血逐瘀为害非浅。我也深深地体会到，不能用活血祛瘀法去统治一切瘀血证，如果不辨证论治，往往会坏事，举两例验案分析于下：

赵××，男，32岁，干部。1976年1月2日初诊，病员八年前患急性黄疽性肝炎，自后一直肋痛，乏力，食欲不振，腹胀，便溏，长期失眠。1975年因肝脏肿大2厘米，有压痛，白蛋白降低，球蛋白增高，白/球比例变小，诊断为慢性肝炎，住某医院治疗半年多。住院期间服活血化瘀药物较久，肝功好转不大，且体力显著减退，因而回四川治疗。舌质红、苔薄黄，舌畔有瘀点，腰痛，面色萎黄，疲乏无力，四肢肘膝下发冷，胸中烦热。处方：柴胡6克，半夏10克，党参12克，黄芩10克，白术10克，茯苓12克，甘草3克，茵陈24克，姜黄10克，附片12克（先煎），大枣5枚，生姜3片。水煎服，五剂。

1月21日二诊，用上方加红枣12克，生地12克，当归10克，续服十剂。

2月20日三诊，病员头昏、失眠、疲乏、食欲及大便均有好转，腹胀明显减轻。处方：连翘12克，赤小豆12克，山梔仁10克，淡豆豉10克，党参15克。此方与上方交替服用。

3月25日四诊，病员自觉症状均已基本消失。仍用上二方交替服用到五月初。肝功正常，肝未扪及，返单位工作。

本案肝大肋痛，属中医积聚痞癖范畴，且病有八年之久，因此，不论从久病入络，还是从痞癖的角度来看，都与瘀血有关，更何况舌有瘀斑，痛有定点。但用祛瘀之剂效差，则是因为瘀血

并非本病主因。且便溏，四末冷，腰痛均如脾肾阳虚之征，腹胀、胁痛、食欲不振乃肝脾不和，疲乏无力、面色萎黄、精神倦怠都是一派虚象，仅胸中烦躁、舌苔薄黄是郁热的表现。所以，治疗当以两补脾肾为主，舒肝调脾，清泄郁热为辅，脾肾阳复，肝气条达，瘀血自可消溶。可见当瘀血是处于从属地位时，以祛瘀为主要治则是难以获效的。

张××，男，51岁，干部。1976年5月，病员因劳动不慎扭伤腰部，隔日更甚，转动俯仰疼痛加剧，针灸及内服活血舒筋、通络疗伤方药其效不显，半月不解。病员身体壮实，平素无脾肾虚弱表现和其他慢性疾病。用六味地黄丸，加杜仲、续断、狗脊、骨碎补、当归、鹿角霜。配合针灸治疗，效果良好，服药三剂，针六次后，即痊愈。尔后，每次腰部扭伤，均需服此方，疗效方佳。

腰部扭伤一般使用活血舒筋疗伤之剂，临床上我常发现不少病例效果不好，除平素肾气不足之人外，即使是体质壮实者，亦有这种情况。在这种情况下，我往往使用上方治疗，将活血疗伤退居次要地位，甚至不用，疗效颇佳。气行则血行，新伤气滞血瘀，所瘀之血与陈伤久瘀之血仍有区别，可以通过气机活动的加强而得到消除，不必非求助于活血逐瘀不可，而过用活血逐瘀又往往耗伤正气，反而使气机不畅，伤痛缠绵。肾气充沛气机流畅，气化旺盛，则腰部瘀血可去，新血可生，故见效迅速。不明气机、气化之理，只着眼于瘀血显然是不行的。

另外，活血祛瘀作为一种治则，它就不仅可用于各种不同程度的瘀血症候，而且也可以用于没有瘀血的疾病。前人所谓“治风先治血，血行风自灭”，“活血以透疹”，“活血以解毒”，“活血以开窍”等法则，就是善于使用的结果。我在临床上利用活血祛瘀法于非瘀血证中，主要作用有：防止瘀血出现；牵制和减少

其它方药的副作用；帮助和协同其它方药更好发挥作用。比如，朱丹溪说：“血气冲和，万病不生，一有拂郁，诸病生焉。”我就常用活血祛瘀法去调畅气血以防病，或辅助补益药物更好发挥作用。《仁斋直指方》说：“气血和平，关络条畅，则痰散而无。”据此，我常用活血法去帮助各种治则发挥作用。如久服潜镇滋腻之品，有碍气血流通，我常根据情况配以活血法，既能有助于滋腻之品发挥作用，同时又能防止其有碍气血流畅的副作用，可谓两全其美。

综上所述，活血祛瘀法可以广泛地用于瘀血证以外的疾病，而瘀血证的本身又要求广开治路，这都是治病求本的必然结果。近年来，随着活血祛瘀法日益显示出其广阔的治疗范围，临床就较为普遍地出现了这样一种倾向，一见有瘀血症候和征兆，就使用活血祛瘀法，而每一使用活血祛瘀法，就一定要设法指出某症为有瘀之征。我认为，这种做法和看法，与中医辨证论治的精神相违背，值得研究和改进。

略论见瘀休治瘀

要提高瘀血证的治疗水平，防止活血祛瘀法的滥用，我认为措施之一，就是应该加强对见瘀休治瘀这个课题的研究。所谓见瘀休治瘀，乃是见血休治血这个论断的引伸，其实质含义，是说不能把活血祛瘀法当作治疗瘀血证的唯一或必用的治则，更不能

将祛除瘀血作为治疗瘀血证的终极目的。如果这样做，就会滥用活血祛瘀法，降低瘀血证的治疗水平。中医的医理和药理是统一的，中医是根据中医的基本理论指导全部治疗工作的。当前的倾向是，往往只注意中药某些符合现在西医药理学的方面，承认中药这方面的治疗作用，忽视甚至否定不能用西医药理学解释的中医药理知识方面。滥用活血化瘀法，就是这种重药用、轻医理倾向的必然产物。本文试从中医理论的几个方面，对见瘀休治瘀作一粗浅探讨。

一、治病的目的、着眼点和手段

治疗疾病的终极目的，不仅是为着消除六淫、七情等致病因素，祛除痰、饮、瘀、食等病理产物，以及减轻病人主观痛苦。治病的终极目的，是要通过各种方法，改变正邪双方力量的对比，使疾病朝有利于人体的方向转化，从而重新恢复到过去“阴平阳秘”的状态，而其最佳恢复，是使体内阴阳之平衡，恢复到既不低于也不高于正常水准的常阈动态平衡。《内经》说：“亢则害，承乃制，制则生化。”阴平阳秘才能谓之承，这是生命存在和发展的根本条件，同时也是健康的根本标志，这是中医学关于治病终极目的的辨证观点。如果治疗的目的是祛邪务尽，那么，为了祛邪则有可能导致疾病虽去而正气大伤，病体不易恢复，或病邪未去正气已衰等情况，造成新的矛盾影响进一步的治疗。目的决定治疗的着眼点和手段，所以滥用的重要原因之一，就是对治病的目的见解有误或者不明确。

人体发生疾病，要产生两种主要矛盾，一是病邪与正气之争，称为邪正斗争，也即是人体抗病防卫反应；二是人体内部阴阳失

去相对平衡，称为阴阳失调，也即是人体自稳调节能力失常。这两种矛盾是相互影响的，比如阴阳失调，既可以是邪正斗争的内在基础，也可以是邪正斗争的产物。所以，不论是内伤、外感，这两种矛盾往往是同时存在。对这两种矛盾在临床上表现出来的诸多症状，经过辨证辨病而作为目前治疗对象者，即是我们的着眼点。治病的目的不同，辨证的水平不同，就会对相同的疾病得出不同的轻重、缓急、主次认识结论，因而就会因着眼点不同，而采取不同的治疗手段。瘀血证作为一个“证”来说，是属于着眼点范畴的，滥用活血祛瘀法，就往往是因为没有正确地把握住疾病的主次缓急，从而使着眼点发生了偏差的结果。比如说瘀血不是主症，而是兼症、次要症，不是主要症候的原因，而是它们的结果，它的存在又仅限于该病的某个阶段。那么，如果我们错误地认为瘀血是原因，是贯串疾病过程始终的主症，把瘀血作为着眼点而加以重点对待，其结果自然就是滥用活血祛瘀法。

活血祛瘀法属于治疗手段。手段是根据着眼点而选用的，为治疗目的服务。若颠倒这个关系，对手段的作用估计过高，以其运用范围广而忽视了终有限制，从这种角度出发，去找寻和确定着眼点，这样做故可侥倖一时，但终归属于不正确的论治方法，因而常常会出现滥用现象。

实际上，临床中一旦见到瘀血症状，至少必须考虑到以下三点，才能比较正确和全面地进行辨证论治：

1. 在整个病机中，瘀血居于何种地位，是主症？还是兼症？是主要作为病因？还是主要作为结果？
2. 解决它是否能够缩短疗程？是否有利于人体正气的恢复？
3. 如果必须解决它，那么，是使用活血祛瘀法还是使用其它治法（因为其他治法也可以起到活血祛瘀的作用）？倘若要使用，

又应该在什么阶段，使用到何种程度，以及与哪些治法相配合，才能收到最佳效果。

由此可见，一见到瘀血症状，就使用活血祛瘀法是欠妥的，其结果常常是滥用而已。

二、邪正标本关系

邪乃指体外之致病因子和体内各种病理产物，如痰、饮、瘀、食等；而正在疾病的情况下，是指人体对病邪的抵抗力和修复力，在无邪气干扰时，则指人体维持气机和气化活动并使之正常和协调的能力。人之能受病，受病的轻重，恢复的快慢，都视人体正气情况而定，就是对各种治疗方式和方法的选择，都须根据人体正气的情况而决定。倘正气不支，则有些治法难以发挥其应有的作用。基于这些认识，对邪正之间的标本关系，中医学认为是邪气为标，正气为本，这是中医学的基本观点。兹就其标本具体关系分析于下：

1. 标本缓急。临床上标本缓急的治疗原则，是急则治其标，缓则治其本。我认为，应该将其内容补充为标急于本则治标，本急于标则治本才更全面。如本急于标，不从本治，不仅会蔓延滋生出许多“标”病，而且还会危及生命。而标急于本，不急加处理，矛盾的性质可以转化，会由标急而造成本急。不论标本缓急的治疗情况如何，其根本立足点还是在本。《素问·五常政大论》说：“大毒治病，十去其六；常毒治病，十去其七；小毒治病，十去其八；无毒治病，十去其九；谷肉果菜，食养尽之，无使过之，伤其正也。”这种理论的正确性，已为千百年来医疗实践所证实和发展。

2. **标本兼顾。**在一般治疗中，大量存在着的是并非很急的情况，这种情况要求治疗时标本兼顾。这时，可以在标本处理上有主有次，但从根本上说，顾标仍然是为了顾本。中医学之所以坚决反对不顾正气衰盛的一切作法，就是这个缘故。所谓补中兼通，通而勿耗，补阴顾阳，补阳护阴，攻而勿伐，补而勿滞等原则，其目的都是为了使邪去正安，身体康复，而不至造成邪去正败的不良后果。

瘀血是病邪，与正气相对而言属于标。从邪正标本关系上看，对待瘀血证，首先应该想到的是正气方面的情况如何，再据此而决定祛瘀祛到何种程度，用些什么方法，以及和其它治法配合的比例如何。这就是说，见到瘀血证不能只考虑瘀血的范围、程度、影响等情况，仅仅只考虑这些，和根本不考虑这些都同样是错误和片面的。

三、虚实补泻

《素问》说：“邪气盛则实，精气夺则虚。”虚实症候可有下列几种具体情况：1.邪气盛为实证，精气夺为虚证；2.邪气盛，但精气夺，则会出现以虚为主的虚实夹杂证，病情较危急；3.邪气不盛，但精气夺，也会出现以虚为主的虚实夹杂证，但病情较缓。这就是说临床上的虚实，乃是正邪双方斗争力量对比的表现，它们相互转化取决于正邪双方力量的对比，其中人体正气盛衰起决定性的作用。比如老年体衰之人患支气管肺炎，虽然邪实却表现为体温不高，症状不明显，白细胞计数不高，仅中性略增，而虚象却非常明显。中医治病，是以正邪的具体情况为根据，恰当地看待对邪气的祛除。中医治病十分强调正气的盛衰，并处处注意

顾护正气。以对冠心病的治疗来说，主张以扶正为主，在扶正的基础上，再加祛邪之品，使病员体质不断增强，病邪渐去，如痰浊瘀血阻滞较甚，心痛较剧，不攻逐痰浊瘀血不足以缓解者，可用祛邪之法以暂缓其标急，然祛邪亦当顾正，适可而止，切不可屡攻屡逐，否则必将导致正愈虚而邪愈实，给后期治疗造成困难。特别是对久心痛的治疗，更应当注意到扶持阴阳气血，纵然有瘀血、痰浊，亦应慎重处理，祛瘀不当猛烈，祛痰不宜峻剂。持这种观点的近代和当代名医决非少数。

在多种慢性病和内伤诸病中，其邪实乃由正虚而存，正胜则邪却，这已是屡经临床所证实。尽管其中很多细节未得到今天科学完全揭示，但总不能偏废其实用价值，这有如我们并不完全明白某些食物中营养成分到底是些什么时，仍须吃饭才能生存一样。

活血祛瘀法亦属祛邪的范畴，它的使用不可能特殊到超越上述关于扶正与祛邪之间的种种关系，可以任意使用而无禁忌。真理超越其范围一步就是谬误，在这里其含义仍是正确的。尽管目前对活血化瘀的研究多围绕着血证，而对气以及气血、阴阳、虚实等相互关系对瘀血的影响研究较少，但从中也发现了顾及气血虚实之间的关系对疗效有直接的影响。

四、影响药物发挥作用的诸因素

王安道在《医经溯洄集》中说：“愈疾之功，非疾不能知之。”今天，这个结论得到了更进一步地证实和说明。临床和实验室研究都告诉我们，药物等治疗手段的具体效果，不只取决于它们的科属、化学成份及实验室的结果，这些结果能否在病员身上重新

出现，还要取决于病体中正邪斗争、阴阳失调处于何种具体的状态。比如温阳益气药，一般说来是升压药，临床上常用来治疗厥逆血压下降之证，但是，用得对证却又能治疗高血压的一些证型，起到降压的作用，这是因为这类高血压证型的本质，是阳气不足的缘故。再如一般而论，益气养阴、扶正固本的中药，能提高机体的免疫功能，但有人通过临床实践，得出也能起到免疫抑制作用的结论。如《中医杂志》1979年第4期《口——眼干燥和关节炎综合证一例治验》即是。人参、五味子之类的药物，被称为具有适应原作用，但也不尽是对人体起有利作用，历史上素有“人参杀人无罪，大黄救人无功”之说，就包含着否定的意思。这一切都说明，要谈论药物的作用如何，是不能离开具体病员阴阳盛衰，和邪正斗争的情况。离开了这点，就只能是纸上谈兵、按图索骥，往往和实际发生的作用差异很大。

患病以后，体内的变化状态往往还要受到病员平素的嗜好、体质、心情、性格、服药时间、服药方法以及气候、环境等因素的影响。比如，据动物试验，用大白鼠作苯巴比妥半致死量试验，上午服药死亡50%，下午服药死亡100%，晚间服药死亡率很低。又如糖尿病员在上午四时对胰岛素最敏感等。在异常的气候条件下，使用某些药物会产生与平时不同的结果，特别是在气压和湿度发生变化的情况下，表现得比较明显。如毛地黄，在暴风雨和气压下降时应用，其毒性反应增加。高气温也能影响药物疗效，特别是利尿药。中医学认为，气候变化与人体脏腑生理活动具有密切关系，如《素问·四时刺逆从论》说：“春气在经脉，夏气在孙络，长夏气在肌肉，秋气在皮肤，冬气在骨髓中。”《素问·离合真邪论》说：“天地温和，则经水安静；天寒地冻，则经水凝泣；天暑地热，则经水沸溢；卒风暴起，则经水波涌而随

起。”可见，中医学对于四时用药宜忌规律，深有研究，自《内经》始，历代医家均有发挥。由此表明，为了提高疗效，探索合理的服药时间、治疗季节、气候的宜忌，乃是值得人们重视的课题。这里引录一段徐灵胎的精辟论述来作总结：“天下有同此一病，而治此则效，治彼则不效，且不惟不效，而反有大害者，何也？则以病同而人异也。夫七情六淫之感不殊，而受感之人各殊，或气体有强弱，质性有阴阳，生长有南北，性格有刚柔，筋骨有坚脆，肢体有劳逸，年力有老少，奉养有膏粱藜藿之殊，心境有忧劳和乐之别，更加天时有寒暖之不同，受病有深浅之各异，一概施治，则病情虽中，而于人之气体迥乎相反，则利害亦相反矣。”活血祛瘀药物进入人体，是否也会出现“利害亦相反”的情况呢？我认为，结论是完全可以肯定的。在运用活血祛瘀药物去治疗瘀血证时，倘不注意以上相异之处，一概施治，则有可能走向愿望的反面。

《伤科秘要》说：“瘀血停滞或积于脏腑者，宜攻利之，先逐其瘀，而后和营止痛，自无不效。”《灵枢·邪气脏腑病形篇》说：“人有所堕坠，恶血留内，腹中满胀，不得前后，先饮利药。”后世宗此甚多，证之临床，下法也确为治疗跌打损伤所致之瘀血积于脏腑证的有效治则之一。但是，当病员脾胃之清气不升，或血虚、或气亏、或肾气不足时，则每每又不能取效，反而加重瘀血病症。

平时阳气虚弱之人，不论由何种原因造成瘀血证，都会使阳气更受亏损，不以温补之法为主，就很难通过益气、行气、活血以达到祛瘀的目的。如果是在治疗过程中造成阳气不足者，亦当如是观之。如马××，男，51岁。左迎香穴生疔，治疗两月余方控制住红肿，出脓封口后，皮下硬肿一块，3×1.5厘米，时时微

痛发痒，又用活血化瘀合清热解毒方药服一月，病员感到疲乏异常，思卧，幸平素体健，胃口尚佳，改用温补之剂配合活血祛瘀和清解药，病员日感精神体力转佳，肿块亦迅速软化消失。

综上所述，临床上纵然见到瘀血症状而需要使用活血祛瘀法时，如果活血化瘀会发生不利于人体正气的后果，就应当根据具体情况，权衡利弊，从而决定其取舍、比例和程序。见瘀即贸然治瘀，实非上策。

讨论见瘀休要贸然治瘀的目的，并非是为了不治瘀，不用活血祛瘀法，而是不滥用活血祛瘀法，使这种治法能得到更恰当地运用，从而提高对瘀血证治疗的效果，提高活血祛瘀法的使用艺术。

行血、生血和摄血之气的探讨

气对血的种种作用，是中医学基础理论的重要内容，其主要作用有三点：即气能行血、生血和摄血。古今文献中对此的论述颇为繁杂，很多地方显得含混，成为中医学中较难理解而又容易造成混乱的部分。我认为，随着历史的发展，随着临床实践的不断深入，中医学中已经积累了大量的、丰富的临床治疗经验。加强对中医基础理论的研究，对积累起来的大量经验材料的内在联系进一步清理，使笼统得到清晰，使繁杂得到精简，这对于中医学理论的进一步发展，实已成为当务之急。为此，我从如何有益于解释和指导临床这一角度出发，对行血、生血和摄血之气进行

初步地探讨。

气在中医学中所指的范围较广，归纳起来主要含义有二：一指流动于体内的微细的营养物质，如水谷之气、呼吸之气等；二指人体组织器官所产生的功能活动，如脏腑之气、经络之气等，总之，气有功能与物质之分，二者功用有根本的区别。物质之气与血、精、津液等物质可以归为一类，都是滋养濡煦润泽人体形态实体和作为人体功能活动的能源的物质基础。（以下物质基础一词，均指这些物质而言）根据中医理论阐述，没有脏腑、肌肉、骨骼等形态实体的存在，就没有相应的功能之气可言，而形体的生存和相应功能之气的活动，又必须依赖物质基础的滋养。物质基础的作用，大致可以分为三个方面：1.滋养和充实形体；2.润泽保护形体。这两类物质属阴，它们间接地维持人体功能之气进行活动；3.直接地作为人体功能之气活动的能源，这类物质属阳。人体功能之气将食物、药物中的各种有用物质加以吸收为人体所用，以及促成物质基础之间的相互转化、糟粕废物的排泄等活动，中医学把这类活动称为气化。而人体功能之气支配物质基础在全身出入升降地进行流通，并维持着动态平衡的活动，中医学称此为气机。人体气机和气化活动的进行，是以人体形态实体为根据，以物质基础为能源，以功能之气为动力得以进行的。总之，没有人体形态实体，就没有相应的功能活动存在，而人体功能活动和形体的存在，又必须依赖物质基础的温养。在人体生命活动的过程中，物质基础不断被人体功能活动和形态实体的代谢所消耗，又不断为人体功能活动所滋生而补充，它们之间的关系就是如此。

恩格斯说：“物体相对静止的可能性，暂时的平衡状态的可能性，是物质分化的根本条件，因而也是生命的根本条件。”在

中医学的基础理论中，也深深地置根着这种思想。《素问·六微旨大论》说：“亢则害，承乃制，制则生化。”这就是说，体内阴阳只有在相对的平衡状态，才能维持气机和气化活动的正常进行。中医学认为，脏腑经络的功能活动，是人体生命活动的主要活动，任何一个脏腑的功能活动，都是人整体功能活动的组成部分，所谓体内阴阳相对平衡，具体地说，就是脏腑功能活动之间的内在平衡协调，这是维持整体正常生命活动的根本基础，因而也是人体气机和气化活动正常进行的根本保证。人体行血、生血和摄血的生理活动，是属于气机和气化活动的范畴，因而它们也是以功能之气为动力，只有在脏腑经络之气活动正常和协调的情况下，才能正常进行，兹分别讨论于下：

一、行血之气

气为血之帅，气行则血行，这为帅之气是何气呢？《针灸学》（上海中医学院编，人民卫生出版社，1974年）认为：“营气和卫气在体内循行，需要有一种推动力量，这种动力在经络学说叫做宗气。营、卫、气、血运行散布于全身，宗气的推动是主要关键，而宗气的生理功能，是经络作用的具体体现。”《中医名词术语选释》（人民卫生出版社，1973年）指出，宗气有两大功能：“其二是贯注心脉而行气血，凡气血的运行，以及肢体的寒温和活动能力，多与宗气有关。”建国以来，绝大多数的教科书、工具书和中医基础理论论述都持这种看法，我觉得这个认识有商榷的必要。宗气是水谷之气和吸入的大气相结合在胸中者，是一种温养全身的物质之气，因此，它的产生和运动，都属于人体气机和气化活动的范畴，因而它不可能是推动血行的根本动力。没有脾胃功能之

气的活动，就没有水谷之气的产生，没有肺主气和肾纳气的功能活动，大气也就不会被吸入到胸中，这几者缺一都不可能产生宗气。离开了肺朝百脉、司呼吸的功能活动，宗气又如何能贯血脉、走息道呢？由此可见，为帅行血之气，显非宗气。

心主血脉，“其华在面，其充在血脉。”（《素问·五脏生成篇》）心的功能之气，是行血的主要推动力，故“心痹者，脉不通。”（《素问·痹论》）“手少阴气绝，则脉不通，脉不通，则血不流，血不流则髡色不泽。”（《灵枢·经脉篇》）血之运行于脉，是以心主血脉为主，肺朝百脉为辅，但五脏间功能活动的协调与否，对血运有着更为复杂和重要的影响。肝主疏泄，疏泄之含义颇广，泛指肝气具有舒畅、调达、疏通、透泄等综合性的生理功能，其中就涉及到血液运行是否和畅调达。经脉是血行的道路，“诸十二经脉者，皆系于生气之原，所谓生气之原者，谓十二经之根本也，谓肾间动气也。”（《难经·八难》）《素问·太阴阳明论》说：“今脾病不能为胃行其津液，四肢不得禀水谷气，气日以衰，脉道不利，筋骨肌肉皆无气以生，故不用焉。”何以脾病气日以衰会引起脉道不利呢？这个问题可以从两个方面来说明，首先，土生万物，脾为后天之本，脾气盛则人体脏腑经络之气也盛，推动有力，血运自然流畅；反之，脾气衰则人体功能之气也衰，血运自然不利。另一方面，脾气盛则物质基础盛，血脉就充实，血运就流利；脾气衰，物质基础少，脉道难以充实，血运自然艰涩，这与江河流水同一道理。由此可见，脾气亦是不可忽视的行血之气。再从脏器之间的联系来看，肝气以升发为顺，肺气以肃降为常，肝气升，肺气降，是人体气机通达畅行的内在依据。心属阳位居上焦，肾属阴位居下焦，阴阳上下之间相互制约和既济作用，对血行亦有着深远的影响。脾为中州，是人体气机升

降的枢纽，在人体气机活动中占有重要的地位。因此，只有脏腑经络功能之气的各自正常，和相互间的协调活动，才能从根本上保证营血正常地运行。

当然，物质之气（其中包括宗气）一旦进入到经脉中运行，也会对营血发生一定的推动作用，但这种作用是由功能之气对物质之气推动而产生的。正因为如此，所以同样被功能之气推动而运行的营血，也会对物质之气发生相似地推动作用。前者仍然可以归于“气能行血”这个总的概念中，后者则被称为“血以载气”的作用所概括。实质上，这两种说法不过是对物质之气和营血，共同由功能之气推动在经脉中运行时，相互间传导推动力的形象描述罢了。因此，把宗气当作血行动力的看法，乃是一个本末倒置的认识，这种认识混淆了功能之气与物质之气的各自作用，也削弱了中医学以脏腑经络功能之气的活动为中心的学术体系，使物质和功能之气的概念发生了混乱。临床上所使用的补气行血法，补气药多为补心脾肺之气，理气行血药，多为疏肝行气之品，如果将宗气作为行血之气，这在临床上也无指导意义。既然在理论上和实践上都无甚价值，那么理所当然地应该受到扬弃才对。

二、生血之气

营气能化生为血，《灵枢·邪客篇》说：“营气者，泌其津液，注之于脉，化以为血，以营四末，内注五脏六腑。”在营气转化为血的过程中，哪些脏腑参与了呢？《灵枢·决气篇》说：“中焦受气取汁，变化而赤，是谓血。”《灵枢·营卫生会篇》说：“中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血，以奉生身，莫贵于此。”中焦指脾胃，

上注于肺则明确谈到肺，可见《内经》已明言将营气变化而赤，有脾、胃、肺直接参与，而水谷饮食只有在先变为营气之后，才能进而变化为血。

水谷入胃，化营变血，还不仅仅是脾、胃、肺三者的协同作用就可以完成的。赵献可在《医贯》中说：“饮食入胃，犹水谷在釜中，非火不熟，脾能化食，全赖相火之无形者，在下焦蒸腐，始能运化。”何梦瑶在《医碥》中指出：“脾之所以能运行水谷者，气也，气寒则凝滞而不行，得心火以温之，乃健运而不息，是为心火生脾土。”胃主纳，脾主运，脾胃之消化吸收过程，离开了肝的疏泄作用也是不能完成的。唐容川说：“肝属木，能疏泄水谷，脾土得肝木之疏泄则饮食化。”所以，气能生血乃是指整体脏腑功能之气的活动正常和协调的气化结果，并非一脏一腑，或某几脏某几腑的功能活动所能完成。中医各家学派之所以在细节和侧重点上有分歧，正是因为站在不同角度上去看待整个脏腑间协同活动的缘故。事实上，临床治疗血虚也是关乎五脏的，补血药如熟地黄、白芍、制首乌、阿胶、鹿角胶、当归、枸杞子、龙眼肉等，大都是心、肝、肾三经药物。由于配伍上往往要取其气能生血之义，而配伍补气药，补气药则主要是补肺脾之气。由于血属阴的范围，因而血虚更进一步就是阴虚，二者总的概念是指体内阴血的亏损。血虚有肝血虚、心血虚，涉及到肺和脾者，往往呈现气血两亏的现象，涉及到肾则常见精亏之候，阴虚有肺、心、肝、肾之别。阴血亏损，虽有共同见症，但分为五脏，还各有其特点可循，因而临床治疗阴血亏损，是治分五脏的。故五脏有病，皆可导致血虚，而治疗血虚，实质上是在调整五脏之间的关系，使之正常和协调。

三、摄血之气

《难经·四十二难》说：“脾主裹血，温五脏。”后世诸书俱谓脾统血，摄血之气就是脾气。近年来的多种基础书籍也持这种观点，以高等院校试用教材《中医学基础》（北京中医学院主编，上海科技出版社，1978年）为例，就只谈到了“气虚而固摄作用减退，便将导致出血。”该书引用了唐容川《血证论·脏腑病机论》语：“经云脾统血，血之运行上下，全赖乎脾，脾阳虚则不能统血。”并解释说：“气属阳，这里的脾阳，即指脾气。脾气充实则能统摄血液，使之循行于经脉之内而不致外溢。”颇多的书籍都以这类方式来阐述气不摄血，认为摄血之气就是脾气，气不摄血就是指脾气虚而不能统血，治则就只有补气摄血一法，我认为到此止步的结论是不全面的。人体收摄营血使之在经脉中运行而不致外溢的作用，主要是通过两个途径实现的，一是通过经脉对营血的束约，经脉实体的主要作用就是直接裹护营血等营养物质，在经脉中周流全身如环无端，所以“阳络伤则血外溢，”“阴络伤则血内溢。”（《灵枢·百病始生篇》）二是行血之气不偏亢也不偏衰，偏亢超过经脉所能承受的能力，就会损伤经脉而出血；偏衰则血运艰难，既会使经失所养而不能固密，导致营血离经，也可以产生瘀血内阻经脉，进而引起出血。

总之，摄血之气不是单指脾气而言，五脏之亏，穷必及肾，临床上不少治脾不效的慢性或急性出血疾病，却往往通过治肾而达到了摄血的目的。肝藏血，也包含着摄血的意思在内，“怒则气逆，甚则呕血”，是肝不藏血的病变，而妇科中的不少血症，肝不藏血都是其主要病机。唐容川在《血证论》中就各脏腑对血证的

影响作了比较详细的阐发，五脏六腑、十二经脉，无不有其表里阴阳、上下络属关系，它们之间是相互影响和促进的。因而摄血之气，从根本上说，不是独属于哪一脏，只有脏腑间协调的功能活动，才是保障摄血的根本之气。肾虚肝热的崩漏，肺阴亏火旺的咳嗽出血，胃气上逆的吐血，心火不宁的衄血等，都属于人体功能之气不能正常摄血的病理表现。而究其治法却实实在在不能局限于补气一法，而究其病位，也实实在在不能在于脾家一脏。

在承认摄血之气不独属于脾气之后，也不应当否认脾气在人体摄血功能中有着重要的作用。脾胃为后天之本，气血生化之源，灌溉五脏六腑，滋养四肢百骸，脾气一亏，人体各脏腑经络之气就会受到影响，这就构成了气不摄血的一种条件。对经脉方面来说，在正常情况下，经脉是靠其实体无损伤，有物质基础的濡润滋养，来保证对营血的约束统摄作用。在出血的情况下，就必须依靠物质基础以及药物的作用，去消除病因、调整紊乱的功能活动，并完成对经脉实体损伤的修补和恢复。脾胃对精微物质和药物有着吸收、转输到全身（其中自然包括经脉）的作用，因而脾胃功能的正常与否，确也密切地关系到经脉在正常和非正常的情况下对血液的约束和统摄作用。所谓脾统血，就是针对脾的上述作用而言的。但是，对于脾胃功能进行调整来说，其含义较广，诚如张景岳所说：“脾胃有病，自宜治脾，然脾为土脏，灌溉四傍，是以五脏中皆有脾气，而脾胃中亦皆有五脏之气。此其互为相使，有可分而不可分者在焉。故善治脾者，能调五脏，即所以治脾胃也，能治脾胃而使食进胃强，即所以安五脏也。”叶天士亦强调这种思想，并有着发挥，他指出：“土主四季之末，寒热温凉随时而用，故脾胃有心之脾胃、肺之脾胃、肝之脾胃、肾之脾胃，认清门路，寒热温凉以治之，未可但言惟火能生土而用热药。”因

此，治疗其它脏腑，或用其他治疗原则和方法，只要能恢复脾胃的正常功能活动，都会改善和加强经脉对营血的统摄作用，都会改善和加强人体气机对营血升降出入的收摄作用，而不是只有补气一法才能收摄营血。

四、结 论

综合上述讨论，可以得出如下几点结论：

1. 由于人体生血、行血和摄血的活动是整个人体气机和气化活动中的一部分，所以，维持人体正常地生血、行血和摄血之气，乃是脏腑经络各自之间正常，而相互之间又协调活动的功能之气。
2. 各种原因引起的任何脏腑经络发生病变，都会由此而干扰到整体活动的协调，因而都会不同程度地削弱和影响到人体生血、行血和摄血的正常活动。所谓初病在气，久延血分的规律，其实质就是说功能之气的病变，必然要引起物质之血发生变化。
3. 不是只有补气一法才能加强或恢复气对血生、行、摄的作用。中医的一切常法和变法，都是针对不同病理变化情况，使脏腑经络功能活动恢复正常和协调的治疗手段，因此，都可以调整、加强、恢复气对血的多种作用，并使之正常地进行。

五、意 义

一种理论如果不能很好地解释和指导临床实践，那么，这种理论应该而且必须修正，只有把行血、生血和摄血之气看作是整体脏腑经络正常而又协调活动的功能之气，才能较为完善地解释

营血的各种病理表现和与之相应的治疗法则，才能较好地指导临床辨证论治。以出血证来说，张仲景治出血有用柏叶、干姜、艾叶（柏叶汤）以止血；有用附子、灶中黄土等（黄土汤）以止血；有用大黄、黄连、黄芩（泻心汤）以止血，寒热攻补大相悬殊。后世更增补肝、泻肝、清热、温补、行气、活血等多种具体治则，这些治则与补气、止血、收涩等治则用之恰当一样，均能调整人体气机和气化以达到摄血的目的。再以血虚的治疗来说，除前述五脏对生血的影响外，活血祛瘀法也能补血，如大黄蟅虫丸，张仲景就用于治疗五劳虚极羸瘦，近世祛瘀生新早已普遍运用。推广开去，为什么活血祛瘀能起到行血、生血、摄血、止痛、祛风、治疮疡、癆瘵、咳嗽、痹证、黄疸等多种病症？为什么通腑法可以治疗腑实、便秘、神昏、狂燥、失眠、发烧、出血等多种系统的病变？为什么温阳法既可治疗低血压，又能治疗高血压呢？为什么同病可以异治，而异病可以同治呢？这类问题都只能用整体功能正常和协调的活动，才是人体气机和气化活动正常进行的根本所在这一理论去完满解释。因为任何一种治疗法则，都是针对具体情况，调整人体功能活动，使之与整体活动相协调的一种手段，所以，都能因其使用恰当，而恢复人体气机气化活动之正常进行，从而都能进一步影响到物质基础的产生、运动和转化。

六、对瘀血证治疗的意义

人体功能之气的生血、行血和摄血作用，支配着营血正常运行的种种条件。气能生血，则血量才会充沛；气能行血，则血才会流畅；气能摄血，才能保证营血在经脉内运行。脏腑功能之气

的正常，及其相互间的协调活动，乃是血能正常运行的根本保证，各种复杂的原因，都可能破坏脏腑功能之气的正常，干扰它们之间的协调关系，从而破坏上述条件，产生瘀血证。《内经》说：“百病皆生于气也。”秦伯未在《中医入门》里指出：“假使气受到心理上、环境上的刺激，无论情志方面的喜、怒、哀、乐，气候方面的冷、热，以及工作方面的劳、逸，都会影响到血。”由于各种原因都可以通过影响人体功能之气而产生瘀血，从原因不同治则各异这种原则来看，也必然要求治法多端。

从另一角度来看，瘀血证一旦形成，对人体的影响，一是阻遏气道，使气机阻滞，一是影响气化，使物质基础的产生及相互间的转化发生障碍。由于瘀血能直接干扰到气化和气机的正常进行，因此，瘀血证往往变症丛生，不独不通则痛一症也。正如《沈氏尊生书》所说：“夫气滞血瘀，则作肿作痛，诸变百出。”之所以临床上活血祛瘀法运用广泛，其原因之一也就在这里。

瘀血证可由多种原因产生，而一旦产生又会引起多种症候以及加剧引起原因的病变。综合这两个方面，可以这样说，活血祛瘀法只有针对具体情况，同其它治则恰当地相互配合，才能充分地发挥其功效，更好地达到预期的疗效。如果仅仅围绕着活血祛瘀药物转，乃是一种见血治血的方法，不是辨证论治的方法，因而不能够有效地防治瘀血证。在活血祛瘀法广泛运用于临床的今天，更要坚持这个观点，并且有必要把这个观点提到理论高度来认识和对待。

我认为，加强对中医基础理论的研究，不但会促进中医学本身的提高，而且还会促进中西医结合的进程。基于这种认识，我粗略地探讨了气对血的诸种作用，及其在理论和临床上的意义。

津血同源对瘀血证治疗的意义

中医非常强调津血同源，在病理上亦给予高度的重视。如《灵枢·营卫生会篇》说：“故夺血者无汗，夺汗者无血。”《伤寒论》也有“亡血家不可汗”的禁例。后世医家在临床上更是常常把“亡血”与“亡津液”相提并论。但是，重点都是放在津血伤亡对相互间的影响上，却很少深入地探讨过津血同源这个理论，在瘀血证的治疗中有何指导意义。本文拟从此出发，就津血之间的具体关系，以及这些关系对瘀血证治疗的意义作一粗浅讨论。

津血之间有以下几种关系，也就是说，津血同源有以下几种具体内容：

一、津血同来源

津血实质上都属于体液范畴，都来源于饮食水谷。《素问·经脉别论》说：“饮食入胃，浊气归心、淫精于脉，脉气流经，经气归肺，肺朝百脉，输精于皮毛，毛脉合精，行气于肺，府精神明，留于四脏，气归于权衡，权衡以平，气口成寸，以决生死。饮食入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散津，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水津四布，五经并行，合于四时，五脏阴阳，揆度以为常也。”正因为这样，故《灵枢·决气篇》认为：精、气、津、液、血、脉，名虽有六，实际上都是一气。津血都化源于水谷饮

食，这种相同的来源告诉我们，调理脾胃，注意饮食水谷的质和量，都有助于津血的共同滋生。

二、津液对营血有滋生作用

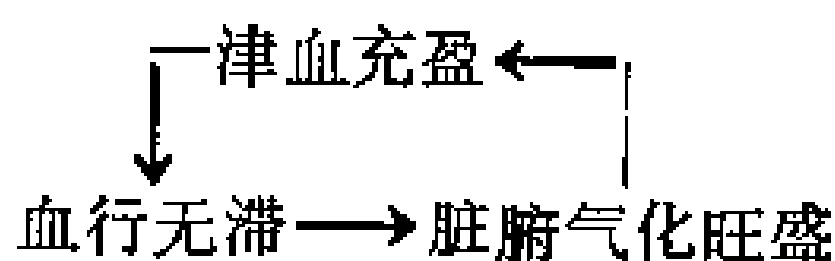
《灵枢·营卫生会篇》有一段足以启发思维的对话：“黄帝曰：愿闻中焦之所出。岐伯答曰：中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化为血，以奉生身，莫贵于此，故独得行于经隧，命曰营气。”《灵枢·痈疽篇》说得更为清楚，“中焦出气如露，上注溪谷，而渗孙络，津液和调，变化而赤为血。”据此，南京中医学院主编的《中医学概论》认为：“血的来源，是水谷之精气（津液），具体地说，就是营气与津液相结合，通过中焦的气化作用而成。”成都中医学院主编的《中医学基础》更明确地指出：“由于津液是生成血的原料，补充津液有助于血的资生，这是津血同源的道理。”显然，这些结论乃是津液对营血有资生作用合乎逻辑的必然结果。因此，在营血发生亏损的时候，用各种方法补充和滋生津液，将有助于营血的资生，这也是津血同源的内容之一。

三、津液能润泽营血

津液对人体所具有的润泽作用是多方面的。皮肤的滋润，肌肉的丰润，肢体与关节运动自如灵活，都是津液对人体润泽的结果和体现。属于津液范畴的涕泪、唾液等，可以润泽及保护眼、鼻、口腔。而脑髓、骨髓也得依靠津液的滋润，才能获得保养。如《灵枢·五癯津液别论》就谈到这一点：“五谷之津液，和合而为膏者，

内渗入于骨空，补益脑髓。”津液的这种润泽作用也涉及到血，周学海在《读医随笔》中谈到：“夫人身之气血，如胭脂然，有粉有质，可粉可淖，入血也可粉可淖也，其淖者津液为之合也，津液为火灼竭，则血行愈滞。”他还进一步比喻道：“血如象舟，津如象水，水津充沛，舟才能行。”由此可见，没有津液对营血的润泽，营血就会稠浓或干涸，这就不可能正常地在体内进行运行，从而出现血行瘀滞的病理现象。对这类瘀血的治疗，不生津以淖血，显非治本之法也。

就这样，我们就可以看到一幅津血相互为用的循环图：



这个如环无端的相互影响的图，表明了津血之间相互为用，以及这种作用与脏腑气机、气化之间的相互关系，即是“保津即以保血，养血即可生津”常作为我们临床指南的根据之所在。

四、对瘀血证治疗的指导意义

根据以上津血同源理论进行推理，其对瘀血证治疗的作用，就主要在于调整津液的质和量，可以进而调整营血的质和量，从而能够调整营血的运行。综合上述津血同源各具体内容，可以推论出如下的指导意义。

1. 应该注意脾津胃阴的情况，它们正常方能保证脾胃中焦功能正常，从而：

(1) 帮助运药，使药力能随津液充分吸收以周流全身，从而发挥最大的药力；

(2) 脾胃正常 $\left\{ \begin{array}{l} \rightarrow \text{生津} \rightarrow \text{补血} \rightarrow \text{气化旺盛} \\ \rightarrow \text{津液充沛} \rightarrow \text{血行流畅} \end{array} \right\} \text{健康}$

这些都直接和间接地支持着瘀血证的治疗和恢复，而所谓直接和间接的关系，又往往随着疾病情况的变化而相互转化着。

当瘀血和脾津胃阴不足共见时，滋补脾津胃阴，就由上述两种作用的缘故，而显得非常重要了。若视而不见，必将带来恶果。

2. 瘀血证中有津伤现象时，更要注意生津，因为生津具备有如下作用：生津既可以解决津伤的情况，又可以帮助瘀血的消除，还可以补血以利于恢复。

3. 需要解决祛瘀生新这类问题时，生津仍然有着不可忽视的作用：生津能加速血亏的恢复（助生新），能淖血以助血行（助祛瘀）。

4. 不应该忘掉的是，瘀血亦当强调祛邪有出路，如果需要汗、吐、下以祛瘀的时候，适当补充津液，是汗、吐、下能够使用的先决条件之一，也是解决汗、吐、下后，能加速机体恢复的必要条件。

生津能保证汗吐下完满进行，因为三法要有足够的津液才能保证实施；汗吐下必然会在一定程度上伤损津液，这样就会成为瘀血产生的条件之一，因此生津对恢复和巩固都是必要的。

事实上，八法在使用和实施的过程中，都会消耗一定的津液，特别是当津液已有亏伤之时，使用八法都要注意生津。如何生津呢？不外直接和间接两法，只要脏腑功能正常，饮食入胃就自能转化为津液，调整脏腑功能以调整体内津液的质和量，是间接生津法；直接用滋阴生津的药物、食品、饮料等进行补充，就是直接生津法。在临床上生津时，往往是两种方法都共同使用。

中医学反对渴而掘井，斗而铸兵，提倡防微杜渐，因此，在临床上使用各种治法以治疗瘀血证时，不要太过或不及，只要能使人体生机活泼、气机舒畅，津液之生也就天然旺盛，不愁匮乏了。

这里举两例我在临床上运用津血同源这个理论以指导瘀血证治疗的验案，谈谈自己的体会。

蓝××，女，28岁，干部。上次月经来潮时感寒受冻。这次经来时突然血量暴下。经西医药治疗后，崩势虽减，但却淋漓不止，血色紫黑而有块，少腹疼痛，两胁肋胀痛，腰痠，心烦舌质淡，苔薄黄，口渴唇燥起屑，脉细数，心慌心跳，夜寐不安已二十余日。此乃寒客胞宫，化热动血，迫血外崩，伤津燥液，以致血行愈滞，更兼气随血衰，故见体倦、疲乏、食少、面色无华、精神萎靡、腰脊酸软、耳鸣、心跳等症。将处方组成浅析于下。

党参20克，白术15克，炙甘草6克，补气培元固中；山萸肉18克，五味子6克，温补肝肾，濡精固气；生地黄20克，麦冬20克，生津液以淖血，并为生血复原以补充原料，更加青果10克，栀子15克，滑泻血热，地榆10克，凉血止血；五灵脂10克，炒蒲黄，煅花蕊石15克，以行血化瘀止血。

病员服一剂后，腹痛减，下血块数枚，淋漓之势顿减，三剂后血止，即转入善后治疗。

善后方用熟地、山药、党参、玉竹、麦冬、芡实、枸杞、黄芪、当归，均大剂与服，仍不忘生津补液能淖血生血，且能防止瘀积也。

罗××，男，26岁，拖拉机手。患急性黄疸型传染性肝炎，注射板蓝根针剂，口服维生素C、B片剂，配合中药清利湿热之剂，已经三月。黄疸未净，胁肋仍胀痛，食欲差，疲乏无力，唇燥起屑，口微渴，舌黯红少苔，常呃气，小便黄，大便干燥，脉细数无力。经医院检查：谷丙转氨酶80单位（正常2—40单位），麀浊8单位。本病被从现代医学病理学的观点来看，肝

炎一方面有瘀血的表现，如变性、充血、坏死等，而另一方面，病员体内往往又有水的代谢失调，组织内有水分潴留现象存在。就临床观察来看，当出现气虚的情况时，又常会出现津亏液燥的现象。这些相互矛盾的表现，我认为其本质上都是由于气虚、气滞造成气化和气机失常，从而引起津液在体内的分布不均，所以此处能见到津液不足，而彼处却又见到水湿潴留，只不过二者在具体病员身上各有偏重罢了。当苦寒叠进之后，其副作用一是伤败脾气、脾阳，二是苦燥伤津，这样就又会加重上述症候。在这种情况下，我针对病机自制下方，临床根据具体情况加减使用，每获良效。处方：鳖甲15克，龟板15克，柴胡15克，白芍15克，麦冬12克，玉竹12克，生地12克，郁金12克，姜黄12克，黄芪20克，枳实3克，甘草3克，锁阳10克，白芥子10克。水煎服。

病员服上方15剂后，谷丙转氨酶、麀浊均恢复到正常范围，食欲、精神、体力亦得到恢复。

此方活血、生津、补气、舒肝、利水、散结、温肾、化痰等多法并用，看似庞杂，却与肝炎此时的病机吻合，故疗效颇佳。急性黄疸型传染性肝炎，叠经苦寒大剂后，常可见到这种证型，都可用此方加减使用。

从上述两案各法相伍中，可以看到津血同源对瘀血证的治疗有着积极的指导意义，而目前有的科研或临床，却很少重视津血调整对瘀血治疗的作用和影响。从中医津血同源的基础理论来看，似乎应该加强这方面的研究，才能提高瘀血证的治疗效果。我在临床中体会到了这点，感到有进一步探索和研究有必要，故特在此提出来。

略论叶桂络病的病理实质是瘀水互患

治络法是叶天士独特治疗手法之一，近年来颇为医界注目，但由于叶氏言多分散、简略，故而对于络病之病理实质的探讨日渐增多。归纳起来，约有三端：一指血分疾病的一部分（血络病）；二指气血沉混，不在于脏腑者；三指邪居深幽隐伏之处的疾病。这些结论的概念比较模糊，特别是后者，尤其显得含混，对指导临床确有影响。尽管络病主要属于瘀血证的范围，这点似有公认的趋势，但也有文章指出，所谓邪深居隐伏之处的含义就不一定单指瘀血、血络，也指气分幽隐之处的病变。（《浙江中医药副刊·叶天士学说研究专辑（一）》载“对叶天士治络法的探讨”）这种幽隐之处的病理实质到底是什么呢？至今未见得出清晰和确切的结论。我认为，整个络病的病理实质就是不同程度和比例的瘀水互患，而所谓幽隐之处的病理实质就更是如此。瘀，是指瘀血，是营血的病变；水，包括痰、饮、湿等，是津液的病变。

气不仅为血之帅，而且也是津液在人体内运行的根本动力。唐容川说：“气之所至，水亦无不至焉。”这就是指气对津液的推动作用，所以，在病理上，就诚如陈修园所指出那样“气滞水亦滞，气行水亦行”。由于气是营血和津液的共同推动力，因而长久的气结，不仅会引起血瘀，也会引起水滞。另一方面，津液要润泽营血，防止血液呈浓、粘、凝、聚的状态，从而保障营血能正常运动于体内，这就决定了津血之间亲密无间、形影不离的关系。因

而血瘀之后，津液就难免不受其牵连而滞留，同样，当津液滞留时，营血也会因此而瘀滞。络病的主要病机是什么？按叶氏的说法，络病的病机主要在于一个久字，即“初病气结在经，久则血伤入络”，就是说血伤是因为气结久了的缘故，气结是因，血伤是着。叶氏明确指出：“久病在络，气血皆窒。”“气钝血滞，日渐瘀痹。”这就是说络病乃气血同病，所以治络的目的，是使“血无凝著，气可宣通”。就是用虫类药物，也是为了“追拔沉混气血之邪”。根据中医基础理论来看，既然久病而致气钝血滞，那么，哪有津液独自安然无恙的道理呢？所以，我认为络病的病理实质是瘀水互患，只不过瘀水之间的程度、比例在具体的表现上有各自不同的特点罢了，但是，谁也不能因为络病外在症状表现上的差异，就否定这种病理实质。叶氏在关于络病的治疗和论述中，对瘀水互患的问题不仅是感觉到了，而且常常加以具体的阐述。如《临证指南医案》张案说，“经以风寒湿三气合而为痹，然经年累月，外邪留著，气血皆伤，其化为败瘀凝痰，混处经络。”徐某案中说：“气冲偏左，厥逆欲呕，呕尽方适，伏饮在于肝络，辛以通之。”姚案说：“胃痛久而屡发，必有凝痰聚瘀。”席案说：“经几年宿病，病必在络，痛非虚症，因久延，体质气馁，遇食物不适，或情怀郁勃，痰因气滞，气阻血瘀，诸脉逆乱，频吐污浊而大便反秘。”汪案说：“痛在胁肋，游走不一，渐至痰多，手足少力，初病两年，寝食如常，今年入夏病甚，此非脏腑之病，乃由经脉，继及络。”华案说：“腹痛三年，时发时止，面色明亮，是饮邪，亦酒湿酿成，因怒左胁有形，痛逸腹中，及胸背诸俞，乃络空，饮气逆攻入络。”陆案说：“病起忧虑上损，两年调整，几经反复，今夏心胸右胁之间常有不舒之象，此气血郁少展，支脉中必有痰饮气阻。”某案说：“夏秋湿热疟痢，正虚邪内留，混入血络结成癥瘕疟母。”至于

叶氏在各种病症中谈及络病，用瘀水并治之药者，更是难以枚举。谭案说：“心痛引背，口涌清涎，肢冷，气塞脘中，此为脾厥心痛，病在络病，例用辛香。高良姜、片姜黄、生茅术、公丁香柄、草果仁、厚朴。”徐灵胎注：“此乃寒痰当加痰药。”某案说：“伏梁病在络，日后当血凝之虑，脉数左大，是其征也。”虽未言及有水，方中用泽泻、茯苓、益母草。由此可见，瘀水互患作为络病的病理实质，在理论上完全合乎逻辑推理，在叶氏的临床实践中也能找到确切的，也是众多的依据。

另外，叶氏对络病用药禁忌的制定，也是自觉和不自觉地根据络病乃瘀水互患这个特点而进行归纳的，如

一、“通血络润补，勿投燥热劫液”，汪案禁用“辛香破气”。

忌用辛香破气很容易理解，络病乃气病之深而及津血者，辛香破气，只会由破气而加重络病的程度。由于津血合和使之淖是血正常运行的重要条件，因此，津亏（或燥痰）血瘀亦是络病瘀水互患的表现形式之一，对这类络病，采取通血络润补的治则是理所当然的事。而燥热劫液之品，不仅会加重瘀血，而且会因劫液导致炼液成痰，加重瘀水互患的病理。

二、“苦寒阻碍”也与络病不宜。

津血之性，均是得寒则凝，得温则行，苦寒过度，只会加重瘀水互患。因此，苦寒阻碍，将伤损人体阳气，阳气受损，不能温煦络脉，可见苦寒阻碍，乃于络病治疗大不相宜者。

三、切勿“乱投滋阴膩浊之药”。

瘀水为有形之邪，宜通利血络使之消散，即使络虚，也当“通补为宜”，更何况，滋阴膩浊之品每多阻滞气机，当然与之不宜。华岫云说：“唯用辛润宣通，不用酸寒敛清以留邪。”“用药大旨每以苦辛凉润宣通，不投燥热敛清呆补，此其治疗大法也。”其禁

忌者，都能用瘀水互患乃有形之邪来得到合理的解释与说明。

综上所述，叶氏络病的病理机制是气钝血滞，病理实质是瘀水互患。这个结论就使邪深居隐伏之处的说法有了确切和清晰的概念，因而也就更能有效地指导临床实践。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名 = 郭贞卿医论集

作者 = 杜英杰

页数 = 1 9 9

S S 号 = 1 0 7 0 9 2 6 7

出版日期 = 1 9 8 3 年 1 2 月 第 1 版